

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

1.1 Compétences mobilisées 3

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications 4

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 5

1.3 Cours 6

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé » 6

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle 12

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection 18

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique 20

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition 31

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale 39

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique 45

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique 52

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls 54

1.4 Approfondissements 70

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé 70

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu 71

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés 71

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids 72

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat 73

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 74

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 75

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5) 76

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique 77

1.7 L'essentiel à retenir 77

1.8 Entraînement 79

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 79

1.8.2 Exercices 81

1.8.3 Questions de réflexion 86

1.8.4 Étude de cas 88

1.8.5 Mises en situation express 88

1.9 Glossaire 92

1.10 Renvois bibliographiques par notion 94

1.12 Bibliographie numérotée 94

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- définir la santé selon différents modèles (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial, santé globale, « Une seule santé / One Health ») et expliquer leurs conséquences pour l'action du diététicien ;
- définir la santé publique, ses missions et son approche populationnelle, et situer les activités du diététicien dans le cadre institutionnel et politique (objectif du guide 2025) ;
- distinguer problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection ;
- distinguer les modes d'intervention en santé publique : surveillance et veille sanitaire, promotion de la santé, prévention (primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire ; universelle, sélective, indiquée), éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle), et les différencier de l'éducation thérapeutique du patient (BC1) ;
- citer les cinq axes et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa (1986) et les illustrer en nutrition ;
- identifier les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition, et ceux qui recueillent et produisent des données ;
- expliquer comment une politique publique de santé est élaborée, pilotée et mise en œuvre, et comment elle est déclinée sur un territoire (ARS, PRS, CLS, PAT) ;
- présenter les politiques nutritionnelles en vigueur au 26 octobre 2026 (SNANC 2025-2030, PNNS 5 2026-2030, PNA 4, EGalim, Nutri-Score, repères alimentaires) et leur histoire ;
- relier ces notions à un projet réel (cas fil rouge) en utilisant les fiches-outils F1 à F14.

1.1 Compétences mobilisées

Ce chapitre est le **socle** de tout le BC3 : il donne le vocabulaire et le cadre institutionnel dans lesquels s'inscrivent les autres chapitres.

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Concepts, modes d'intervention, politiques et acteurs pour poser un diagnostic, justifier des priorités et des objectifs, choisir le bon type d'action	Analyse et diagnostic de situation posé ; priorités et objectifs adaptés au contexte ; règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées
C3.2	Inscrire l'atelier culinaire dans un projet d'éducation pour la santé (éducation alimentaire et sensorielle)	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.3	Connaître les organismes producteurs de données et les grandes enquêtes	Contexte et problématique de l'étude identifiés
C3.4	Identifier les textes de référence à jour (SNANC, PNNS 5, PNA 4) et les sources institutionnelles fiables	Sources d'informations fiables repérées et connues
C3.5	Adapter le discours au public selon la démarche de promotion de la santé (pouvoir d'agir, non-stigmatisation)	Supports et contenus adaptés au public

1.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (référentiel et guide)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Concepts de santé	Définir la santé (OMS 1946) ; comparer les modèles biomédical, biopsychosocial, global ; expliquer « Une seule santé »	Citer la définition de l'OMS mot pour mot ; pas d'histoire détaillée de la médecine
Santé publique : définition et missions	Définir la santé publique ; citer ses missions ; expliquer l'approche populationnelle	Connaître la définition de Winslow et celle du Code de la santé publique (art. L. 1411-1)
Problèmes de santé : danger, risque, facteur de risque	Distinguer ces notions et les illustrer en nutrition	Les déterminants et leurs niveaux sont développés au chapitre 2
Modes d'intervention : surveillance, veille sanitaire, promotion, prévention, éducation pour la santé (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	Distinguer et illustrer chaque mode ; classer une action ; distinguer éducation pour la santé et ETP	Classifications de l'OMS (1948) et de Gordon (1983) exigibles ; Charte d'Ottawa : 5 axes + 3 stratégies
Organismes de recueil et de production de données	Citer les principaux organismes et leur rôle	Les études elles-mêmes (INCA, ESTEBAN, NutriNet-Santé) sont détaillées au chapitre 17
Politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre	Décrire le circuit d'une politique (loi, stratégie, plan, programme)	Pas de droit constitutionnel ; connaître SNS, ARS, PRS, CLS
Politiques nutritionnelles de santé publique	Présenter le PNNS (historique, PNNS 5), la SNANC, le PNA, EGalim, le Nutri-Score, les repères	Le guide 2025 recommande de s'appuyer sur le PNNS ; utiliser la version en vigueur (PNNS 5)
Déclinaison territoriale	Expliquer le rôle de l'ARS, du PRS, des CLS, des PAT, des contrats de ville	Savoir où trouver ces documents pour son lieu de stage

1.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Enjeux de santé publique ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 60). Toutes les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des textes au 26 octobre 2026 ; les corrections sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 1.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 60	Concepts de santé ; danger, risque, facteur de risque ; mesure de l'état de santé ; santé publique ; modes d'intervention ; organismes producteurs de données ; politiques de santé et politiques nutritionnelles (s'appuyer sur le PNNS) ; déclinaison territoriale	1.3.1 à 1.3.7, dans l'ordre du guide (voir le tableau 1.2) ; définitions et calculs des indicateurs et des déterminants au chapitre 2
Référentiel, C3.1	Analyse et diagnostic de situation ; priorités et objectifs adaptés ; règles éthiques, juridiques et déontologiques	1.3.9 (fil rouge) ; 1.6 ; méthodes de présentation du cadre
Référentiel, C3.4	Sources d'informations fiables repérées et connues	1.3.5, 1.3.7 et 1.10 (sources datées, textes en vigueur)
Référentiel, C3.5	Supports et contenus adaptés au public	1.4.4 (non-stigmatisation du poids) ; 1.3.4 (approches éducatives)
Référentiel, activité 3.1	Contexte institutionnel ; données sur le territoire et les déterminants	1.3.5 et 1.3.6 ; le détail des déterminants est au chapitre 2

1.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport aux fascicules du CNED qui traitent de la santé publique :

- *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), module 1, séquences 1 « Notion de santé » (p. 3 à 7), 2 « Outils, ressources et méthodologies en santé publique » (p. 8 à 12) et 3 « Politique de santé, pilotage et mise en œuvre » (p. 13 à 16) ;
- *Environnement professionnel – Synthèse du cours en bref*, 1re année (CNED 3-6123-AN-WT-00-21), module 3 « Santé, politique de santé, système de santé (1re partie) » (p. 25 à 30), pour le passage sur le Nutri-Score.

Toutes les notions de ces passages sont reprises. Les autres parties de ces séquences sont traitées aux chapitres 2, 3, 5 et 17.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)	Définition de la santé de l'OMS (1946) ; exemples de l'alimentation et du sport ; santé « notion relative », « état dynamique »	1.3.1 (définition, critiques, santé relative et dynamique)
Essentiels M1 S1 §2 (p. 3)	Définition de la santé publique attribuée à l'OMS (1952) et cinq moyens d'action collective	1.3.2 (définition de Winslow et missions)
Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)	Évolution historique de la santé publique, de l'Antiquité au XXIe siècle	1.3.2 (brève histoire de la santé publique, frise)
Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)	« Risque sanitaire » ; veille et sécurité sanitaire ; prévention primaire, secondaire, tertiaire (OMS) ; promotion de la santé ; éducation pour la santé et ETP ; restauration de la santé	1.3.3 (risque) ; 1.3.4 (modes d'intervention, sécurité sanitaire et restauration de la santé, ETP)
Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8)	Organismes en charge des données : INDS et SNDS, ANSES, EFSA	1.3.5 (ANSES, EFSA) ; 1.3.6 (données qui éclairent les politiques, Plateforme des données de santé)
Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14)	Politique de santé publique ; quatre types d'acteurs (consultatifs, décideurs, opérationnels, financeurs) ; priorité sanitaire, programme, planification	1.3.5 (typologie des acteurs) ; 1.3.6 (priorités, programmes et planification)
Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15)	Durée des plans ; niveaux régional, national, européen, mondial ; ARS ; HCSP, CNS, CNA	1.3.5 (acteurs par niveau) ; 1.3.6 (PRS, déclinaison territoriale)
Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15)	Démocratie sanitaire : loi du 4 mars 2002, droits individuels et collectifs	1.3.5 (la démocratie sanitaire : la place des usagers)
Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)	L'OMS, fondée en 1948 : missions	1.3.5 (niveau international)
Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)	Stratégie nationale de santé 2018-2022 ; planification sanitaire ; rôle de l'État et de l'ARS	1.3.6 (stratégie nationale de santé, planification descendante et ascendante)
Synthèse 1re année M3 S1 §2 (p. 29)	Information nutritionnelle : étiquetage (règlement de 2011) et Nutri-Score prévu par la loi de 2016	1.3.7 (frise des politiques nutritionnelles, Nutri-Score)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Définition de la santé** (p. 3) : le fascicule écrit « bien-être physique, social et mental » et « l'absence de maladie ». Le texte exact de la Constitution de l'OMS est : « un état de complet bien-être physique,

mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». À l'examen, on cite le texte exact.

- **Définition de la santé publique** (p. 3) : elle est de **Charles-Edward A. Winslow (1920)** ; le comité d'experts de l'OMS l'a reprise en 1952. On la présente donc comme la définition de Winslow, reprise par l'OMS.
- **Veille sanitaire** (p. 5) : elle n'est pas « propre à chaque département ». Elle est organisée au niveau national par **Santé publique France**, avec des cellules régionales, et les ARS reçoivent les signalements.
- **Prévention primaire** (p. 5) : elle ne se limite pas à « informer la population ». Elle agit aussi sur l'environnement (offre alimentaire, réglementation) et sur les compétences des personnes.
- **INDS et CNAMTS** (p. 8) : l'Institut national des données de santé a été remplacé en 2019 par la **Plateforme des données de santé (Health Data Hub)** (loi du 24 juillet 2019). La CNAMTS s'appelle aujourd'hui la **Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM)**.
- **HCSP** (p. 15) : le sigle désigne le **Haut Conseil de la santé publique**, créé par la loi du 9 août 2004 (et non le « Haut Comité »). Il n'existe pas de « CNSP » : seule la **Conférence nationale de santé (CNS)** existe au niveau national.
- **CRAS** (p. 14) : depuis la loi HPST de 2009, l'instance régionale est la **Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA)**. Les « territoires de santé » sont devenus, avec la loi du 26 janvier 2016, les **territoires de démocratie sanitaire**.
- **Stratégie nationale de santé** (p. 16) : la SNS 2018-2022 reste la dernière adoptée. Le projet de **SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, n'était **pas encore adopté** selon une réponse du ministère publiée le 12 mai 2026. Les textes nutritionnels en vigueur sont la **SNANC 2025-2030** (publiée le 11 février 2026), le **PNNS 5 (2026-2030)** et le **PNA 4 (2026-2030)**, lancés le 8 avril 2026.
- **Nom du ministère** (p. 16) : il change avec les gouvernements ; on écrit « ministère chargé de la santé ».
- **Nutri-Score** (1re année, p. 29) : la loi du 26 janvier 2016 a prévu un logo nutritionnel facultatif ; le **Nutri-Score** a été choisi par l'**arrêté du 31 octobre 2017**, et son algorithme a été révisé par l'**arrêté du 14 mars 2025**.

1.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

1.3.1 Les concepts de santé : du modèle biomédical à « Une seule santé »

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §1 (p. 3)

Le mot « santé » paraît simple ; il recouvre pourtant des conceptions très différentes, qui changent la façon d'agir. Un diététicien qui pense que la santé est seulement « l'absence de maladie » limitera son action aux personnes malades ; s'il considère que la santé est une **ressource** qui dépend des conditions de vie, il agira aussi sur l'environnement alimentaire d'un quartier, sur les menus d'une école ou sur le pouvoir d'agir des habitants.

Le modèle biomédical

Dominant du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, le **modèle biomédical** définit la santé de façon **négative** : être en bonne santé, c'est ne pas être malade. La maladie est expliquée par une cause biologique (microbe, lésion d'organe), diagnostiquée et traitée par le médecin. Ce modèle a permis des progrès considérables (vaccins, antibiotiques, chirurgie), mais il ignore le vécu de la personne et les causes sociales des maladies. Appliqué à la nutrition, il conduit à ne voir dans l'obésité qu'un déséquilibre entre apports et dépenses énergétiques, sans tenir compte du revenu, du stress, de l'offre alimentaire ou du marketing.

La définition de l'Organisation mondiale de la santé (1946)

Définition – La santé selon l'OMS

> « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée par la Conférence internationale de la santé à New York (19 juin – 22 juillet 1946), signée le 22 juillet 1946 et entrée en vigueur le 7 avril 1948 (date devenue la Journée mondiale de la santé). Cette définition n'a pas été modifiée depuis.

Cette définition est **révolutionnaire** pour trois raisons : elle est **positive** (la santé est un état de bien-être, pas seulement l'absence de maladie) ; elle est **multidimensionnelle** (physique, mentale, sociale) ; elle fait de la santé un **droit** : la Constitution affirme que « la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale ».

Attention – Les critiques de la définition de l'OMS

- Le « complet » bien-être est un **idéal** presque inatteignable : avec cette définition, presque personne n'est en bonne santé, notamment les personnes vivant avec une maladie chronique (diabète, maladie cœliaque) qui peuvent pourtant mener une vie pleinement satisfaisante.
- Elle décrit un **état** figé, alors que la santé est un **équilibre dynamique**.
- Elle ne dit rien de la **capacité d'adaptation** de la personne. D'où la proposition de Machteld Huber et coll. (*BMJ*, 2011) : la santé comme « capacité à s'adapter et à se prendre en charge face aux défis sociaux, physiques et émotionnels ».

Le modèle biopsychosocial et la santé comme ressource

En 1977, le psychiatre George Engel propose le **modèle biopsychosocial** : la santé et la maladie résultent de l'interaction de facteurs **biologiques** (génétique, physiologie), **psychologiques** (émotions, représentations, stress) et **sociaux** (revenu, travail, culture, entourage). En 1986, la **Charte d'Ottawa** prolonge cette vision : la santé est « une **ressource de la vie quotidienne**, et non le but de la vie » ; c'est « un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et personnelles, et les capacités physiques ». Pour l'atteindre, il faut des **conditions préalables** : la paix, un abri, l'éducation, la nourriture, un revenu, un écosystème stable, des ressources durables, la justice sociale et l'équité.

Lien diététique – Ce que cela change pour le diététicien

Dans le modèle biopsychosocial, une consultation ou un atelier ne peut pas se limiter à « donner des conseils ». Une mère de famille qui sert des boissons sucrées au goûter n'ignore pas forcément qu'elles sont trop sucrées : son choix peut s'expliquer par le prix, la demande des enfants, la publicité, la peur que l'enfant « ne mange rien », ou une habitude culturelle. Le diététicien doit **explorer ces dimensions** avant de proposer une action (chapitres 3 et 4).

Santé perçue, santé objective, santé positive

On distingue la **santé objective**, mesurée par des indicateurs (IMC, glycémie, mortalité) et la **santé perçue**, déclarée par la personne (« Comment jugez-vous votre état de santé ? »). La santé perçue est un indicateur utilisé en santé publique (Baromètre de Santé publique France, enquête européenne EHIS) : elle prédit la mortalité indépendamment des indicateurs médicaux. La **santé positive** (bien-être, qualité de vie, santé mentale positive) est valorisée par la promotion de la santé.

La santé globale et l'approche « Une seule santé / One Health »

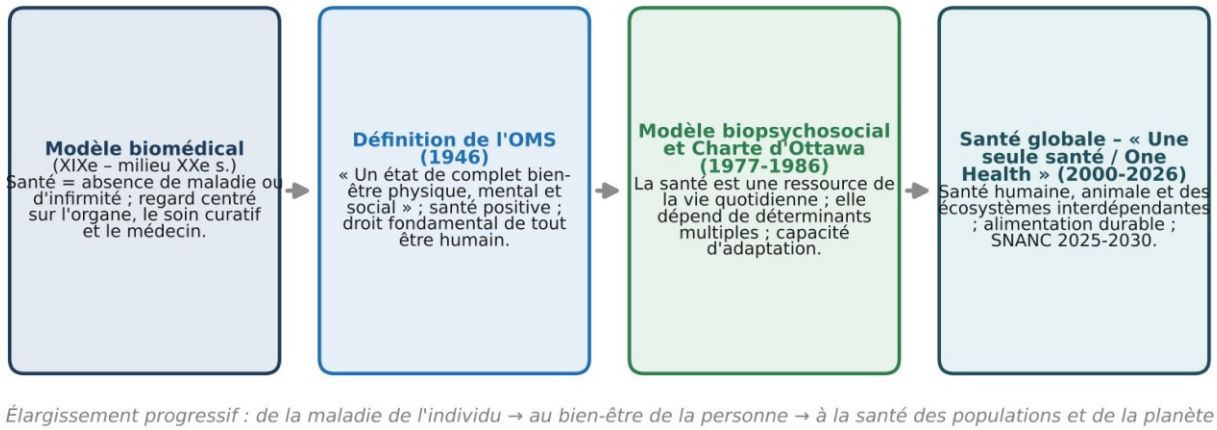


Figure 1.1 – Évolution des concepts de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.1

1. Modèle biomédical : la santé est définie négativement, par l'absence de maladie ; l'action est curative et individuelle.

2. Définition de l'OMS (1946) : la santé devient positive (bien-être), multidimensionnelle (physique, mentale, sociale) et un droit fondamental.

3. Modèle biopsychosocial (Engel, 1977) et Charte d'Ottawa (1986) : la santé est une ressource de la vie quotidienne, influencée par de nombreux déterminants ; l'action vise aussi les conditions de vie.

4. Santé globale et « Une seule santé » : la santé humaine est indissociable de la santé animale et de celle des écosystèmes ; l'alimentation durable est au carrefour des trois.

5. La flèche du bas résume le mouvement : on passe de l'individu malade à la population, puis à la planète.

Le concept **« Une seule santé » (One Health)** est né au début des années 2000 (principes de Manhattan, 2004) à partir d'un constat : environ 60 % des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale (zoonoses), la résistance aux antibiotiques circule entre élevage, environnement et humains, et le changement climatique modifie la production alimentaire. En 2022, l'OMS, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), réunis en **« Quadripartite »**, ont adopté un plan d'action conjoint One Health (2022-2026) et une définition commune.

Définition – Une seule santé (One Health) – définition du panel d'experts OHHLEP, 2021, adoptée par la Quadripartite « Une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large (y compris les écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. »

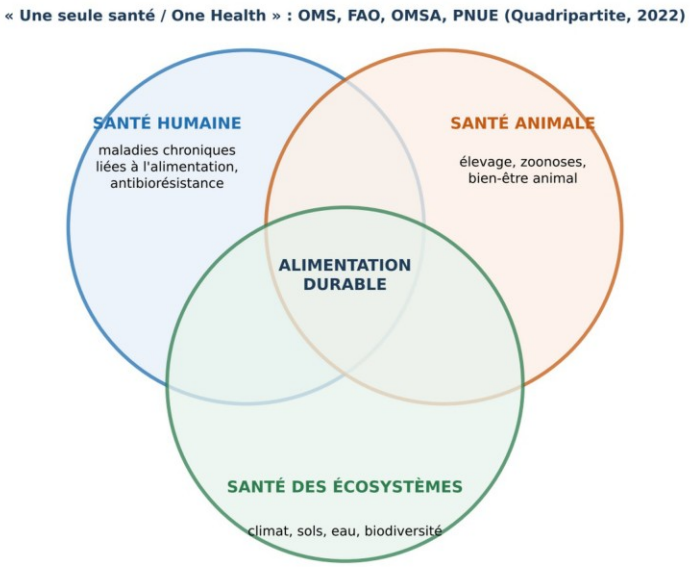


Figure 1.2 – « Une seule santé » : l'alimentation durable au carrefour de trois santés

Comprendre le schéma – Figure 1.2

1. Le cercle bleu représente la **santé humaine** : maladies chroniques liées à l'alimentation (obésité, diabète, cancers), carences, résistance aux antibiotiques.
2. Le cercle orange représente la **santé animale** : conditions d'élevage, bien-être animal, maladies transmissibles à l'humain (zoonoses), usage des antibiotiques en élevage.
3. Le cercle vert représente la **santé des écosystèmes** : climat, qualité des sols et de l'eau, biodiversité, contamination par les pesticides.
4. Les zones de chevauchement montrent les **interdépendances** ; au centre, l'**alimentation durable** agit sur les trois à la fois (par exemple, manger plus de légumineuses et moins de viande améliore la santé humaine, réduit les émissions de gaz à effet de serre et la pression sur les élevages).

Le guide d'accompagnement du BTS (2025) place explicitement **toute intervention en santé publique en nutrition** dans cette approche pluridisciplinaire de l'**alimentation globale « Une seule santé »**. En France, la **SNANC 2025-2030** relie santé publique, transition écologique et souveraineté alimentaire, et le PNNS 5 et le PNA 4 ont été lancés le 8 avril 2026, à l'occasion du **One Health Summit** organisé à Lyon du 5 au 7 avril 2026.

Exemple – Une action de nutrition lue avec les lunettes « Une seule santé »

Une école élémentaire remplace une fois par semaine le plat carné par un plat à base de légumineuses (obligation de la loi EGalim d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire). **Santé humaine** : plus de fibres, moins d'acides gras saturés. **Santé des écosystèmes** : moins d'émissions de gaz à effet de serre (les légumineuses fixent l'azote de l'air et émettent beaucoup moins que la viande de bœuf). **Santé animale** : moindre pression sur l'élevage intensif. Le rôle du diététicien : garantir l'équilibre nutritionnel (apport en protéines, en fer), l'acceptabilité (recettes appréciées des enfants) et la lutte contre le gaspillage.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1

Classez chacune de ces affirmations dans le modèle qu'elle illustre (biomédical, OMS 1946, biopsychosocial/Ottawa, One Health) : **a)** « Monsieur D. est en bonne santé puisque ses analyses sont normales. » **b)** « La réduction des antibiotiques en élevage protège aussi l'efficacité des traitements chez l'humain. » **c)** « Madame K. a un diabète bien équilibré, travaille, fait du sport et se sent bien : elle s'estime en bonne santé. » **d)** « Pour être en bonne santé, il faut un logement, un revenu et l'accès à une alimentation de qualité. »

Corrigé

a) Modèle biomédical : la santé est réduite à des résultats biologiques normaux, sans prise en compte du vécu. **b) One Health** : lien entre santé animale (usage d'antibiotiques en élevage), environnement (diffusion des bactéries résistantes) et santé humaine. **c) Modèle biopsychosocial / santé comme capacité d'adaptation** : malgré une maladie chronique, la personne a une bonne santé perçue et fonctionnelle ; la définition de l'OMS (« complet » bien-être) l'exclurait, ce qui montre sa limite. **d) Charte d'Ottawa** : ce sont les « conditions préalables à la santé » (abri, revenu, nourriture…).

La santé, une notion relative et dynamique

Aucune définition ne suffit à dire ce qu'est la santé pour chacun. Les cours du CNED et les manuels de santé publique insistent sur trois idées que le jury attend dans un exposé.

1. La santé est une notion individuelle. Chacun juge sa santé selon ses connaissances, ses expériences, son âge, son sexe et ses attentes. Une personne de 80 ans qui marche avec une canne peut se dire « en bonne santé » ; un sportif de 25 ans peut se dire « en mauvaise santé » après une entorse.

2. La santé est une notion variable. Elle change selon les époques, les cultures, les groupes sociaux et le niveau de développement du pays. Au XIXe siècle, être « bien en chair » était un signe de santé et d'aisance ; aujourd'hui, le surpoids est un facteur de risque. Dans certains groupes, une maladie chronique bien équilibrée n'empêche pas de se dire en bonne santé.

3. La santé est un état dynamique. C'est un équilibre instable et temporaire entre la personne et son environnement. Il faut le reconquérir sans cesse : une rupture (perte d'emploi, deuil, déménagement) peut déséquilibrer l'alimentation, le sommeil et la santé mentale en quelques semaines.

Définition – Deux formules célèbres à connaître

René Leriche (chirurgien, 1936) : « La santé, c'est la vie dans le silence des organes. » C'est une vision biomédicale : on est en bonne santé tant qu'on ne ressent rien.

Georges Canguilhem (philosophe, « Le normal et le pathologique », 1943) : être en bonne santé, c'est pouvoir **tomber malade et s'en relever** ; c'est la capacité de s'adapter et de créer de nouvelles normes de vie. C'est une vision dynamique, proche de la santé « ressource » de la Charte d'Ottawa.

Attention – Une limite de la définition de l'OMS

La définition de 1946 parle d'un « état de complet bien-être ». Ce mot « complet » est souvent critiqué : presque personne n'est en « complet bien-être », et la définition peut faire de chacun un malade. Les approches récentes (santé positive, santé comme capacité d'adaptation) répondent à cette critique. Savoir citer cette limite montre au jury une **analyse critique** (C3.4).

Exemple – La même personne, trois regards sur sa santé

Mme Diallo, 58 ans, a un diabète de type 2 équilibré par un traitement. **Regard biomédical** : elle est malade (pathologie chronique). **Regard de l'OMS** : son bien-être social est bon (associative, entourée), son bien-être mental aussi ; seul le volet physique est touché. **Regard dynamique** : elle a adapté son alimentation et marche chaque jour ; elle se dit « en forme ». Pour le diététicien en santé publique, ce regard dynamique est le plus utile : il s'appuie sur les **ressources** de la personne et non sur ses manques.

Mesurer l'état de santé d'une population : premiers repères

Le guide d'accompagnement 2025 place la **mesure de l'état de santé** dans les « enjeux de santé publique ». Pour savoir si une population est en bonne santé, on utilise des **indicateurs** : des données chiffrées, calculées à date

régulière, qui rendent les situations comparables (natalité, mortalité, mortalité infantile, espérance de vie, prévalence, incidence, indice de développement humain). Ils sont produits par l'Insee, la Drees, Santé publique France ou les observatoires régionaux de la santé. Leurs définitions et leurs calculs sont présentés au chapitre 2.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 bis – Santé relative

Citez les trois caractéristiques qui font de la santé une notion relative et illustrez chacune par un exemple lié à l'alimentation.

Corrigé – Exercice 1.1 bis

Individuelle : une personne âgée qui mange avec plaisir malgré une dentition fragile se dit en bonne santé. **Variable** : la minceur valorisée aujourd'hui ne l'était pas au XIXe siècle. **Dynamique** : un étudiant qui quitte le foyer familial peut voir son alimentation se dégrader en quelques semaines, puis la rééquilibrer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.1 – Les concepts de santé

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez la définition de la santé de l'OMS (1946) et citez une critique de cette définition.
2. Associez chaque modèle à sa date : modèle biopsychosocial ; Charte d'Ottawa ; constitution de l'OMS. Dates : 1946, 1977, 1986.
3. Vrai ou faux : « Pour le modèle biomédical, une personne diabétique bien équilibrée est en bonne santé. » Justifiez.
4. Expliquez en deux phrases pourquoi la santé est une notion relative et dynamique.
5. Citez les trois santés reliées par l'approche « Une seule santé » et donnez un exemple en alimentation.
6. Citez trois indicateurs de l'état de santé d'une population et deux organismes qui les produisent.

Corrigé – Point d'étape 1.3.1

1. « Un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. » Critique : le mot « complet » rend l'objectif presque inatteignable ; la définition est statique.
2. Modèle biopsychosocial : 1977 (Engel) ; Charte d'Ottawa : 1986 ; constitution de l'OMS : 1946 (en vigueur en 1948).
3. Faux : pour le modèle biomédical, la santé est l'absence de maladie ; la personne a une maladie chronique, elle est donc « malade ». Seules les approches globales et dynamiques permettent de dire qu'elle se sent en bonne santé.
4. Relative : elle dépend de chaque personne (âge, expérience, attentes) et varie selon les époques et les cultures. Dynamique : c'est un équilibre instable avec l'environnement, à reconquérir sans cesse.
5. Santé humaine, santé animale, santé des écosystèmes. Exemple : réduire la viande rouge et diversifier les protéines (légumineuses) est bon pour la santé humaine et réduit l'impact environnemental.
6. Par exemple : taux de mortalité, espérance de vie, prévalence d'une maladie ; Insee, Drees, Santé publique France, observatoires régionaux de la santé.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.2 La santé publique : définitions, missions et approche populationnelle

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §2 (p. 3) ; Essentiels M1 S1 §3 (p. 4)

Définitions

Définition – Santé publique – définition de C.-E. A. Winslow (1920)

« La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et de promouvoir la santé et l'efficacité physiques à travers les efforts coordonnés de la communauté pour l'assainissement de l'environnement, le contrôle des infections dans la population, l'éducation de l'individu aux principes de l'hygiène personnelle, l'organisation des services médicaux et infirmiers pour le diagnostic précoce et le traitement préventif des pathologies, le développement des dispositifs sociaux qui assureront à chacun un niveau de vie adéquat pour le maintien de la santé. »

Cette définition centenaire contient déjà tout : **prévenir**, **promouvoir**, agir **collectivement** (« efforts coordonnés de la communauté ») et agir sur les **conditions de vie** (« niveau de vie adéquat »). On retiendra une formulation courte : la santé publique est l'ensemble des **savoirs, des savoir-faire et des actions organisées** qui visent à **maintenir et améliorer la santé de la population**, en agissant de façon collective sur ses déterminants.

Définition – La politique de santé dans le Code de la santé publique (art. L. 1411-1)

La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État ; elle tend à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la population, la réduction des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes, et à garantir la meilleure sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins. Elle comprend notamment la surveillance et l'observation de l'état de santé et de ses déterminants, la promotion de la santé, la prévention collective et individuelle, l'organisation des parcours de santé, la sécurité sanitaire, l'information et l'éducation à la santé (article issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; formulation résumée).

Définition – Santé publique – définition de l'OMS (1952)

En 1952, le comité d'experts de l'OMS sur l'administration de la santé publique reprend et complète la définition de Winslow : « La santé publique est la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité physiques et mentales des individus, par le moyen d'une action collective concertée visant à assainir le milieu, à lutter contre les maladies qui présentent une importance sociale, à enseigner à l'individu les règles de l'hygiène personnelle, à organiser des services médicaux et infirmiers en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies, ainsi qu'à mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. L'objet final est de permettre à chaque individu de jouir de son droit inné à la santé et à la longévité. » (formulation reprise par le CNED, Environnement professionnel)

Méthode – Lire la définition de 1952 avec un regard de diététicien

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Assainir le milieu	Qualité de l'eau de boisson ; sécurité sanitaire des aliments ; environnement alimentaire (offre autour des écoles)
Lutter contre les maladies qui ont une importance sociale	Obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, dénutrition de la personne âgée
Enseigner les règles d'hygiène personnelle	Éducation pour la santé : repères du PNNS, ateliers culinaires, hygiène en cuisine

Ce que dit la définition	Exemple en nutrition aujourd'hui
Organiser des services en vue du diagnostic précoce	Repérage du rebond d'adiposité en PMI ; dépistage de la dénutrition en EHPAD
Mesures sociales et niveau de vie	Aide alimentaire, tarification sociale de la cantine, chèques alimentaires, épiceries solidaires
Droit inné à la santé	Lien avec l'équité et la réduction des inégalités sociales de santé

Brève histoire de la santé publique

La santé publique n'est pas née avec l'OMS. Elle s'est construite par étapes, en réponse aux grandes menaces de chaque époque. Connaître cette histoire aide à comprendre pourquoi nos dispositifs actuels sont organisés ainsi.

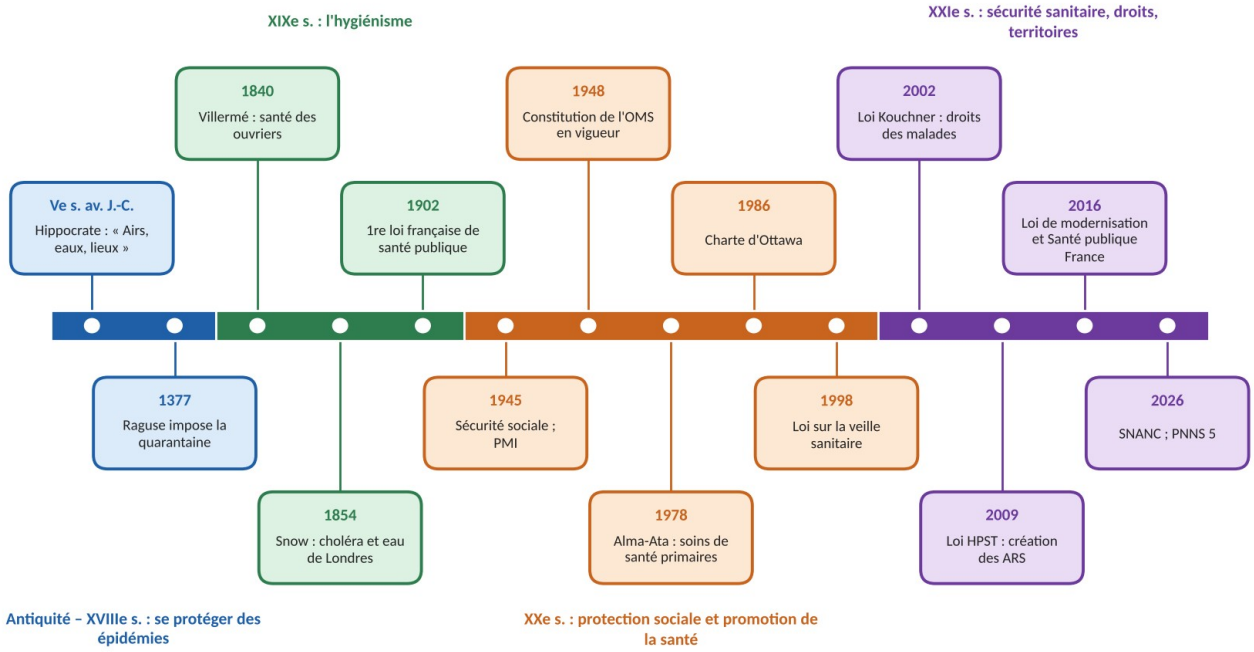


Figure 1.2 bis – Les grandes étapes de la santé publique, de l'Antiquité à aujourd'hui

Comprendre le schéma – Figure 1.2 bis

1. La frise est divisée en **quatre périodes** de couleur : chaque période répond à une préoccupation dominante.
2. **En bleu (Antiquité – XVIIIe siècle)** : on cherche surtout à **éviter la propagation des épidémies** (peste, choléra) par l'isolement et la quarantaine ; Hippocrate relie déjà la santé à l'air, à l'eau et aux lieux.
3. **En vert (XIXe siècle)** : le **mouvement hygiéniste** montre que la misère, le logement insalubre et l'eau polluée tuent ; l'État commence à légiférer (loi de 1902).
4. **En orange (XXe siècle)** : la santé devient un **droit** ; la protection sociale (1945), l'OMS (1948), puis les chartes d'Alma-Ata (1978) et d'Ottawa (1986) élargissent la santé publique à la **promotion de la santé**.
5. **En violet (XXIe siècle)** : après des crises (sang contaminé, vache folle, canicule de 2003, Covid-19), l'accent est mis sur la **sécurité sanitaire**, les **droits des usagers** et l'organisation par **territoires** (ARS).
6. Les dates en orange et en violet sont à connaître pour l'oral : elles permettent de situer le cadre réglementaire d'une action.

Période	Préoccupation dominante	Repères et textes	Ce qu'il en reste en nutrition
Antiquité – Moyen Âge – Renaissance	Survivre aux épidémies dans un contexte de religion toute-puissante, d'instabilité politique et d'absence de médecine curative	Hippocrate (Ve s. av. J.-C.), *Airs, eaux, lieux* ; quarantaine à Raguse (1377) ; lazarets	L'idée que l'environnement fait la santé
XVIIIe siècle	Influence des idées des Lumières et de la Révolution ; la santé du peuple devient l'affaire de l'État	Premières statistiques de population ; vaccination antivariolique (Jenner, 1796)	L'idée de compter pour agir (données)
XIXe siècle	Lutter contre la mortalité ; surveiller les épidémies ; éduquer	Villermé, *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers* (1840) ; Snow et le choléra de Londres (1854) ; Pasteur (microbiologie) ; loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique	Hygiène des aliments, eau potable, lait propre pour les nourrissons (« gouttes de lait »)
XXe siècle	Protéger tout le monde ; passer du curatif au préventif puis à la promotion de la santé	Ordonnances de 1945 (Sécurité sociale, PMI) ; OMS (1948) ; Alma-Ata (1978) ; Ottawa (1986) ; loi du 1er juillet 1998 sur la veille sanitaire	PMI, médecine scolaire, premières campagnes d'éducation nutritionnelle
XXIe siècle	Sécurité sanitaire, droits des usagers, inégalités, territoires, climat	Loi du 4 mars 2002 ; loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; loi HPST du 21 juillet 2009 (ARS) ; loi du 26 janvier 2016 ; SNS 2018-2022 (projet 2023-2033 non adopté en mai 2026)	PNNS (2001 à 2030), Nutri-Score, EGalim, SNANC

À retenir

La santé publique est passée de la **protection contre les épidémies** (isoler, assainir) à la **promotion de la santé** (agir sur les déterminants, renforcer le pouvoir d'agir). Les grandes lois françaises à citer sont : **1902** (première loi de santé publique), **2002** (droits des malades), **2004** (politique de santé publique), **2009** (ARS), **2016** (modernisation du système de santé, Nutri-Score).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.1 ter – Situer une action dans l'histoire

Une diététicienne prépare l'exposé d'un projet « Bien boire, bien manger » dans une école. Le jury lui demande : « En quoi votre action est-elle l'héritière de l'histoire de la santé publique ? » Rédigez une réponse de 6 à 8 lignes qui cite au moins trois périodes et deux textes.

Corrigé – Exercice 1.1 ter (exemple de réponse)

« Mon action s'inscrit d'abord dans l'héritage **hygiéniste** du XIXe siècle : l'accès à une eau potable gratuite à l'école répond au souci d'assainir le milieu, déjà présent dans la loi de **1902**. Elle reprend ensuite l'approche du **XXe siècle** : avec la Charte d'**Ottawa** (1986), on ne se contente plus d'informer, on agit sur l'environnement (fontaines, menus) et on renforce les compétences des enfants. Enfin, elle relève du **XXIe siècle** : elle répond à une priorité du **PNNS 5** et du projet régional de santé de l'ARS, créée par la loi **HPST** (2009), et elle associe les parents, ce qui rejoint l'esprit de la démocratie sanitaire. » Le correcteur valorise : trois périodes nommées, deux textes datés, le lien avec l'action.

Les caractéristiques de l'approche de santé publique

Caractéristique	Approche clinique (BC1)	Approche de santé publique (BC3)
Cible	Un individu (le patient)	Une population ou un groupe (habitants d'un quartier, élèves, salariés, résidents)
Point de départ	Une demande de soin, une prescription médicale	Un diagnostic de situation : données épidémiologiques, besoins normatifs, exprimés, ressentis et observés
Objectif	Guérir, soulager, accompagner la personne	Maintenir et améliorer la santé du groupe, réduire les inégalités
Leviers	Bilan, diagnostic diététique, plan de soin, ETP	Environnements, politiques, communication, éducation, partenariats, plaidoyer
Acteurs	Équipe soignante	Équipe pluridisciplinaire et intersectorielle : santé, social, éducation, collectivités, associations, agriculture
Évaluation	Évolution clinique du patient	Indicateurs de processus et de résultats sur le groupe
Exemple en nutrition	Consultation diététique pour un enfant en situation d'obésité	Programme « goûters sains » dans toutes les écoles d'un quartier

Les missions de la santé publique

L'OMS et son bureau régional pour l'Europe ont décrit des **opérations essentielles de santé publique**, que l'on peut regrouper en grandes missions :

1. Observer et surveiller l'état de santé de la population et ses déterminants (données, indicateurs, enquêtes).

2. Veiller et alerter : détecter et répondre aux menaces sanitaires (épidémies, toxi-infections alimentaires collectives, contaminations).

3. Protéger : sécurité sanitaire des aliments, de l'eau, de l'environnement (réglementation, contrôles).

4. Promouvoir la santé : agir sur les déterminants, créer des environnements favorables, renforcer le pouvoir d'agir.

5. Prévenir les maladies et leurs complications (vaccination, dépistage, prévention nutritionnelle).

6. Éduquer et informer la population.

7. Organiser le système de santé et l'accès aux soins et à la prévention.

8. Former les professionnels, **chercher** et **évaluer** (recherche, données probantes, évaluation des politiques).

9. Gouverner : élaborer des politiques, les financer, coordonner les acteurs (gouvernance intersectorielle).

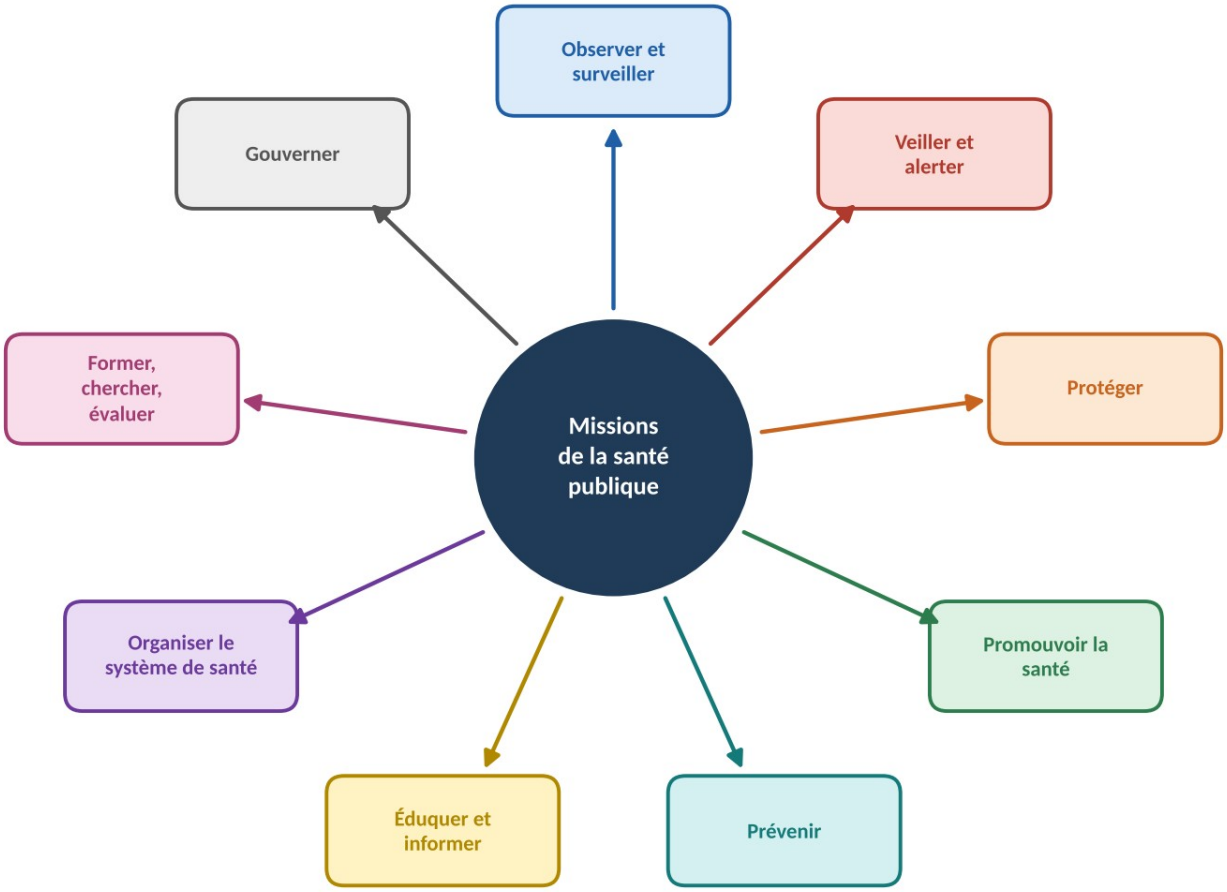


Figure 1.2 ter – Les neuf grandes missions de la santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.2 ter

1. Les neuf missions sont disposées en **cercle** : aucune n'est plus importante que les autres, elles s'enchaînent et se renforcent.
2. **Observer, veiller, protéger** : ce sont les missions de connaissance et de défense (données, alertes, sécurité sanitaire).
3. **Promouvoir, prévenir, éduquer** : ce sont les missions d'action auprès de la population ; c'est là que se situe surtout le diététicien.
4. **Organiser, former et évaluer, gouverner** : ce sont les missions qui donnent un cadre, des moyens et des règles.
5. Pour l'oral, retenez une phrase : « mon action relève surtout de la mission "promouvoir" ou "éduquer", et elle s'appuie sur les données de la mission "observer". »

Pourquoi agir sur toute la population ? Le paradoxe de la prévention

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible) En 1985, l'épidémiologiste britannique **Geoffrey Rose** a montré qu'un **grand nombre de personnes exposées à un petit risque** peut générer **plus de cas** qu'un petit nombre de personnes exposées à un risque élevé. C'est le **paradoxe de la prévention** : une mesure qui apporte beaucoup à la population peut apporter peu à chaque individu qui y participe.

Exemple – Le paradoxe de Rose appliqué au sel

Imaginons une population de 100 000 adultes. 5 000 d'entre eux ont une hypertension sévère (risque élevé d'accident vasculaire cérébral) ; 95 000 ont une pression artérielle normale ou modérément élevée (risque

faible). Supposons, à titre pédagogique, que sur 10 ans, il survienne 10 AVC pour 1 000 personnes dans le groupe à haut risque et 2 pour 1 000 dans le groupe à faible risque. **Étape 1 – AVC dans le groupe à haut risque** : 5 000 × 10 / 1 000 = **50 AVC**. **Étape 2 – AVC dans le groupe à faible risque** : 95 000 × 2 / 1 000 = **190 AVC**. **Étape 3 – Total** : 50 + 190 = **240 AVC**, dont 190 / 240 = 0,79, soit **79 %** dans le groupe dit « à faible risque ». **Interprétation** : traiter uniquement les personnes à haut risque ne pourrait éviter, au mieux, que 21 % des AVC. Une mesure **populationnelle** (réduction du sel dans le pain, accord de filière, étiquetage) qui baisse légèrement la pression artérielle de tous agit sur la grande majorité des cas. C'est pourquoi les politiques nutritionnelles combinent stratégie **populationnelle** et stratégie **à haut risque** (dépistage et prise en charge).

À retenir

La santé publique s'intéresse à la **population** et pas seulement aux individus malades ; elle agit **collectivement** et **en amont**, sur les **déterminants** de la santé ; elle combine actions pour toute la population et actions ciblées (paradoxe de Rose).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.2 – La santé publique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les auteurs et les dates des deux définitions de la santé publique étudiées.
2. Citez cinq missions de la santé publique.
3. Complétez : l'approche clinique vise …… ; l'approche de santé publique vise …… .
4. Expliquez le paradoxe de la prévention de Geoffrey Rose (1985) en trois lignes.
5. Citez trois lois françaises de santé publique avec leur date.
6. Calcul : 80 000 adultes dont 4 000 à haut risque (15 cas pour 1 000) et 76 000 à faible risque (3 cas pour 1 000). Quelle part des cas survient dans le groupe à faible risque ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.2

1. Winslow (1920) ; OMS (1952), qui reprend et complète Winslow.
2. Observer et surveiller ; veiller et alerter ; protéger ; promouvoir la santé ; prévenir ; éduquer et informer ; organiser le système ; former, chercher, évaluer ; gouverner (cinq au choix).
3. Clinique : un individu (le patient), pour le soigner. Santé publique : une population, pour maintenir et améliorer sa santé et réduire les inégalités.
4. Beaucoup de personnes exposées à un petit risque produisent plus de cas que peu de personnes exposées à un risque élevé. Une mesure pour toute la population évite donc plus de cas, même si elle apporte peu à chaque individu.
5. Loi du 15 février 1902 (protection de la santé publique) ; loi du 4 mars 2002 (droits des malades) ; loi du 9 août 2004 (politique de santé publique) ; loi HPST du 21 juillet 2009 ; loi du 26 janvier 2016 (trois au choix).
6. Haut risque : 4 000 × 15 / 1 000 = 60 cas. Faible risque : 76 000 × 3 / 1 000 = 228 cas. Total : 288 cas. Part : 228 / 288 × 100 = 79,2 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.3 Problème de santé, danger, risque, facteur de risque et facteur de protection

Module · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Pour définir des priorités, le diététicien doit nommer précisément ce qu'il cherche à éviter. Ces notions sont indispensables au diagnostic de situation (chapitre 7) et seront approfondies avec les déterminants (chapitre 2).

Notion	Définition	Exemple en nutrition
Problème de santé	Situation qui altère ou menace la santé d'une population, mesurable par des indicateurs (fréquence, gravité, coût, retentissement)	Obésité infantile, dénutrition des personnes âgées, carence en fer chez l'adolescente, insécurité alimentaire
Danger	Agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste (propriété intrinsèque)	Listeria monocytogenes dans un fromage au lait cru ; excès de sel ; allergène (arachide)
Exposition	Contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose)	Consommation quotidienne de pain et de plats préparés riches en sel
Risque	Probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition : risque = danger × exposition	Probabilité de développer une hypertension dans une population qui consomme en moyenne 8 g de sel/jour
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une probabilité accrue de maladie (sans être forcément la cause unique)	Sédentarité, consommation fréquente de boissons sucrées, tabagisme, faible revenu
Facteur de protection	Caractéristique associée à une probabilité réduite de maladie	Allaitement maternel, consommation de fruits, légumes et fibres, activité physique, soutien social
Population à risque	Groupe plus exposé ou plus vulnérable	Femmes enceintes (Listeria), personnes âgées isolées (dénutrition), enfants de familles précaires (obésité)

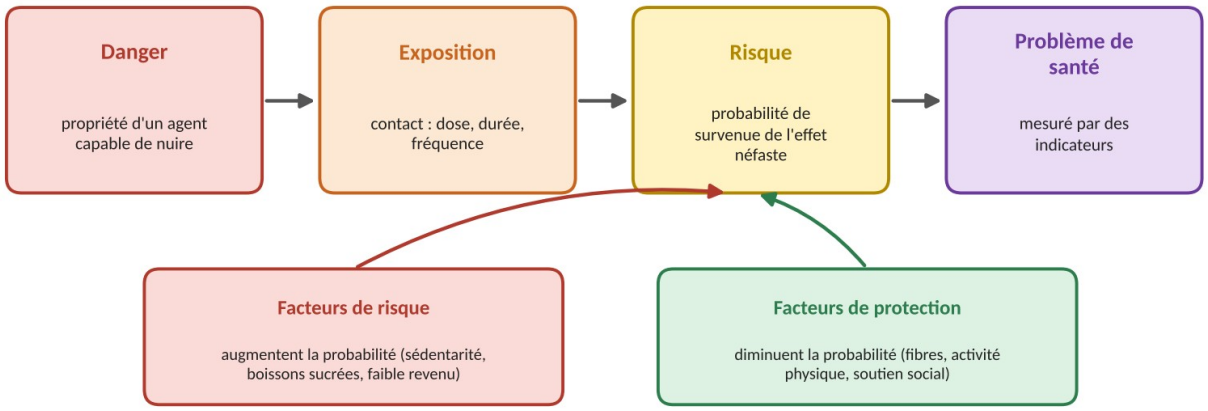


Figure 1.3 bis – Du danger au problème de santé : la chaîne du risque

Comprendre le schéma – Figure 1.3 bis

1. Le **danger** est une propriété de l'agent (le sel, une bactérie) : il existe même si personne n'y est exposé.
2. L'**exposition** décrit le contact avec le danger : dose, durée, fréquence.
3. Le **risque** naît de la rencontre du danger et de l'exposition : c'est une **probabilité**.
4. Quand le risque se réalise dans une population, il devient un **problème de santé**, que l'on mesure par des indicateurs (prévalence, incidence).
5. Sur les côtés, les **facteurs de risque** augmentent cette probabilité et les **facteurs de protection** la

diminuent : une action de santé publique cherche à réduire les premiers et à renforcer les seconds.

Attention – Facteur de risque n'est pas cause

Un facteur de risque est **associé statistiquement** à une maladie ; il n'en est pas forcément la cause directe. Par exemple, le fait de vivre dans un quartier prioritaire est associé à une plus forte prévalence d'obésité : ce n'est pas le quartier en lui-même qui « cause » l'obésité, mais un ensemble de déterminants (revenus, offre alimentaire, espaces pour l'activité physique, stress…). Les méthodes de l'épidémiologie (chapitre 16) permettent de discuter la causalité (critères de Bradford Hill).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2

Dans la situation suivante, identifiez le danger, l'exposition, le risque, deux facteurs de risque et un facteur de protection : « Dans un foyer d'hébergement, des résidents âgés de plus de 75 ans mangent seuls dans leur chambre ; certains ont des difficultés de mastication ; les repas sont livrés froids. On craint une dénutrition. »

Corrigé

- **Problème de santé visé** : la dénutrition des personnes âgées.
- **Danger** : des apports alimentaires insuffisants en énergie et en protéines (situation capable de provoquer une dénutrition).
- **Exposition** : repas pris seuls, en chambre, à chaque repas, de façon prolongée.
- **Risque** : probabilité qu'un résident devienne dénutri dans les mois à venir (plus élevée que dans une population qui mange en salle commune avec des textures adaptées).
- **Facteurs de risque** : âge > 75 ans, isolement social au moment du repas, troubles de la mastication, repas peu appétissants (froids).
- **Facteur de protection** : repas pris en commun (convivialité), textures adaptées, enrichissement des repas, surveillance du poids (lien BC1 : critères HAS/FFAMCO 2021 de la dénutrition de la personne de 70 ans et plus).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.3 – Danger, risque, facteurs de risque

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Définissez danger, exposition et risque.
2. Classez en facteur de risque ou facteur de protection : allaitement maternel ; sédentarité ; soutien social ; boissons sucrées quotidiennes.
3. Vrai ou faux : « Un facteur de risque est toujours la cause de la maladie. » Justifiez.
4. Donnez un exemple de population à risque pour la listériose et pour la dénutrition.
5. Dans la situation « des étudiants sautent le petit déjeuner et achètent des viennoiseries au distributeur », nommez le problème de santé visé et l'exposition.

Corrigé – Point d'étape 1.3.3

1. Danger : agent ou situation capable de provoquer un effet néfaste. Exposition : contact entre la population et le danger (durée, fréquence, dose). Risque : probabilité qu'un effet néfaste survienne, compte tenu du danger et de l'exposition.
2. Facteurs de protection : allaitement maternel, soutien social. Facteurs de risque : sédentarité, boissons sucrées quotidiennes.
3. Faux : un facteur de risque est associé statistiquement à la maladie ; il n'en est pas forcément la cause

directe (exemple du quartier prioritaire).

4. Listériose : femmes enceintes (et personnes âgées ou immunodéprimées). Dénutrition : personnes âgées isolées.
5. Problème de santé : déséquilibre alimentaire pouvant favoriser surpoids et baisse de concentration. Exposition : consommation répétée de produits gras et sucrés au distributeur, le matin, plusieurs fois par semaine.

Mon score	Ce que je fais
5 ou 4 sur 5	Je passe à la suite.
2 ou 3 sur 5	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 2 sur 5	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.4 Les modes d'intervention en santé publique

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S1 §4 (p. 5 et 6)

Le guide d'accompagnement (2025) distingue quatre modes d'intervention : la **surveillance et la veille sanitaire**, la **promotion de la santé**, la **prévention** et l'**éducation pour la santé** (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle). Ils ne s'opposent pas : un projet bien construit les combine. Mais il faut savoir les **nommer précisément**, car le jury de l'épreuve E5 attend que vous qualifiiez correctement votre action.

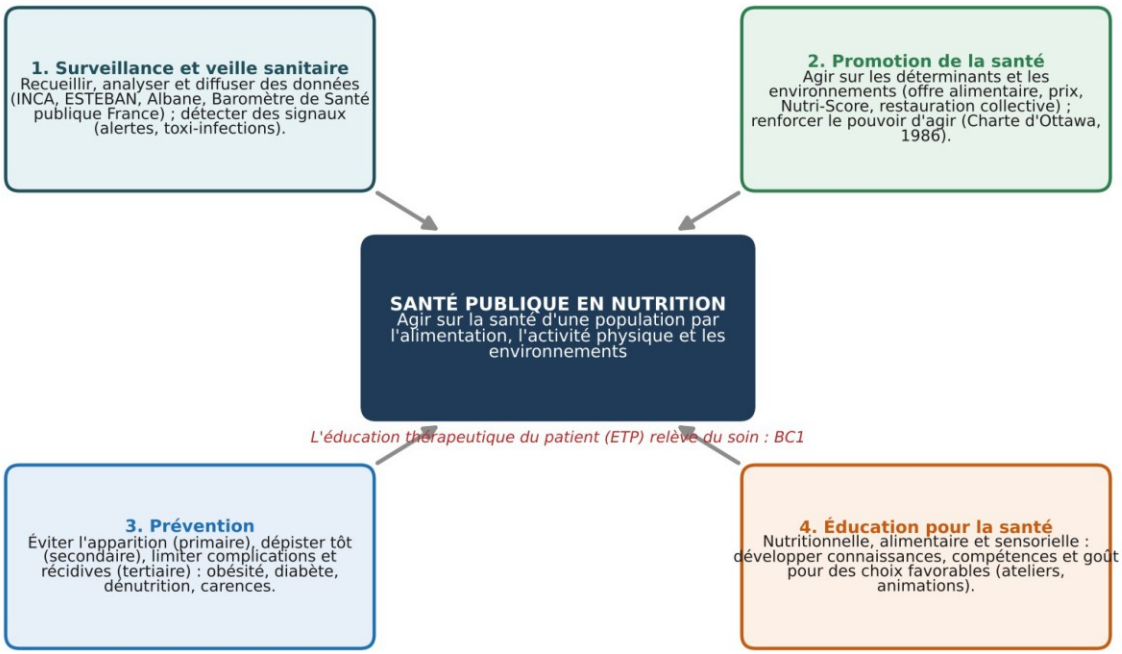


Figure 1.3 – Les quatre modes d'intervention en santé publique en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.3

1. Au centre, la **santé publique en nutrition** : agir sur la santé d'une population par l'alimentation, l'activité physique et les environnements.
2. En haut à gauche, la **surveillance et la veille sanitaire** produisent les données qui permettent de connaître les problèmes et de suivre leur évolution.
3. En haut à droite, la **promotion de la santé** agit sur les déterminants et les environnements, et renforce le pouvoir d'agir.
4. En bas à gauche, la **prévention** cible un problème de santé précis, à différents moments de son histoire

naturelle.

5. En bas à droite, l'**éducation pour la santé** développe connaissances, compétences et goût chez les personnes.
6. La mention en rouge rappelle que l'**éducation thérapeutique du patient** relève du soin (BC1) et non de l'éducation pour la santé.

Mode 1 – La surveillance et la veille sanitaire

Définition – Surveillance épidémiologique

Collecte **systématique et continue** de données sur l'état de santé d'une population et ses déterminants, leur **analyse**, leur **interprétation** et leur **diffusion** aux personnes qui en ont besoin, afin d'orienter l'action (définition classique des Centers for Disease Control, reprise par Santé publique France).

Définition – Veille sanitaire

Ensemble des actions visant à **détecter le plus tôt possible** tout événement sanitaire anormal (« signal ») représentant un risque pour la santé de la population, à l'**évaluer** et à **alerter** les autorités pour qu'elles agissent. En France, la veille sanitaire est confiée à **Santé publique France** (créée le 1er mai 2016 par regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).

En nutrition, la **surveillance** repose sur des enquêtes répétées : études **INCA** (ANSES ; INCA 3 réalisée en 2014-2015, publiée en 2017), **ESTEBAN** (Santé publique France, 2014-2016), cohorte **NutriNet-Santé** (depuis 2009), **Baromètre de Santé publique France**, enquêtes de santé scolaire de la Drees (grande section, CM2, 3e), et désormais l'enquête **Albane**, lancée en juin 2025 par Santé publique France et l'ANSES, qui associera tous les deux ans questionnaires, carnets alimentaires de trois jours, accéléromètres et examens de santé avec prélèvements biologiques (premiers résultats attendus début 2028). La **veille sanitaire** concerne surtout la sécurité des aliments : déclaration obligatoire des **toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)** auprès de l'ARS, alertes et rappels de produits (site **RappelConso**, depuis avril 2021), nutrivigilance de l'ANSES (effets indésirables des compléments alimentaires).

Lien diététique – Le diététicien et la surveillance

Le diététicien est **utilisateur** des données de surveillance (pour poser un diagnostic, chapitre 2) et parfois **producteur** : enquêteur dans une étude nationale, participation aux enquêtes de consommation en restauration collective, signalement d'une TIAC dans un établissement, déclaration d'un effet indésirable en nutrivigilance.

Mode 2 – La promotion de la santé

Définition – Promotion de la santé – Charte d'Ottawa (OMS, 21 novembre 1986)

« La promotion de la santé est le **processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci**. Cette démarche relève d'un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut, d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. » Charte adoptée lors de la première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa (Canada), 17-21 novembre 1986.

La promotion de la santé ne vise pas une maladie particulière : elle vise à **améliorer la santé et le bien-être** en agissant sur l'ensemble des **déterminants** (revenus, logement, éducation, offre alimentaire, environnement…) et

en renforçant la **capacité des personnes et des communautés à agir** (*empowerment*, ou pouvoir d'agir). Elle est **positive** (on cherche à développer des ressources) et **politique** (on agit sur les politiques publiques, pas seulement sur les comportements).

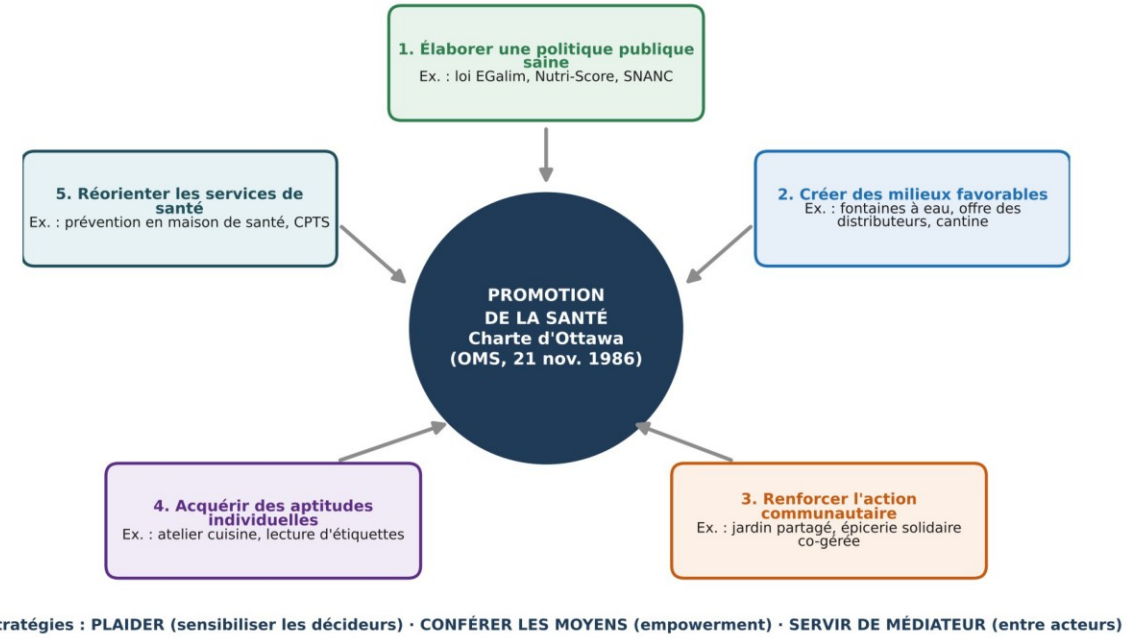


Figure 1.4 – Les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa, illustrés en nutrition

Comprendre le schéma – Figure 1.4

1. Élaborer une politique publique saine : la santé doit être inscrite à l'ordre du jour de tous les décideurs, dans tous les secteurs (agriculture, éducation, urbanisme, économie). Exemples : loi EGalim, Nutri-Score, SNANC.

2. Créer des milieux favorables : rendre les choix sains plus faciles dans les lieux de vie (école, travail, quartier). Exemples : fontaines à eau, suppression des distributeurs de boissons sucrées dans les écoles (loi du 9 août 2004), offre de fruits.

3. Renforcer l'action communautaire : les habitants participent à la définition des priorités et à l'action. Exemples : jardin partagé, épicerie solidaire co-gérée, groupe de parents.

4. Acquérir des aptitudes individuelles : informer, éduquer, développer les compétences. Exemples : atelier cuisine, lecture d'étiquettes, éducation au goût.

5. Réorienter les services de santé : passer d'un système centré sur le soin à un système qui intègre la prévention. Exemples : prévention en maison de santé pluriprofessionnelle, CPTS, rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie.

6. Le bandeau du bas rappelle les **trois stratégies** : **plaider** (convaincre les décideurs), **conférer les moyens** (donner aux personnes les moyens d'agir) et **servir de médiateur** (concilier les intérêts des différents acteurs).

À retenir – Charte d'Ottawa : 5 + 3

5 domaines d'action : politique publique saine ; milieux favorables ; action communautaire ; aptitudes individuelles ; réorientation des services de santé. **3 stratégies** : plaider, conférer les moyens (habiliter), servir de médiateur. Moyen mnémotechnique : « **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement » (Politique, Milieux, Communautaire, Aptitudes, Réorienter).

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Les conférences et chartes qui ont suivi Ottawa

Année et lieu	Apport principal
1978 – Alma-Ata	Déclaration sur les soins de santé primaires : « la santé pour tous en l'an 2000 » ; participation de la population ; la santé dépend du développement économique et social
1986 – Ottawa	Charte de la promotion de la santé (5 domaines, 3 stratégies)
1988 – Adélaïde	Politiques publiques favorables à la santé ; l'alimentation et la nutrition sont un domaine prioritaire
1997 – Jakarta	Partenariats, implication du secteur privé, investissement dans la santé
2005 – Bangkok	Charte de Bangkok : promotion de la santé à l'heure de la mondialisation ; engagement des entreprises
2010 – Adélaïde	Santé dans toutes les politiques (Health in All Policies), réaffirmée à Helsinki en 2013
2016 – Shanghai	Déclaration de Shanghai : promotion de la santé et Objectifs de développement durable (2030), villes-santé, littératie en santé
2021 – Genève	Charte de Genève pour le bien-être : sociétés du bien-être, santé de la planète

Les principes d'action de la promotion de la santé

- **Agir sur les déterminants** plutôt que sur les seuls comportements (chapitre 2). Le modèle des déterminants de Dahlgren et Whitehead (1991) est l'outil de référence pour les visualiser.
- **Participation** des personnes concernées à toutes les étapes du projet (du diagnostic à l'évaluation) : on fait **avec** les personnes, pas **pour** elles.
- **Renforcement du pouvoir d'agir** (*empowerment*) individuel et collectif.
- **Intersectorialité** : santé, social, éducation, urbanisme, agriculture, économie.
- **Réduction des inégalités sociales de santé** : selon le principe de l'**universalisme proportionné**.
- **Approche par milieux de vie** (*settings*) : écoles promotrices de santé, entreprises, villes-santé de l'OMS (réseau français des Villes-Santé, créé en 1990).
- **Non-stigmatisation** : on ne culpabilise pas les personnes (par exemple, on parle de « personnes vivant avec une obésité » et on évite les messages qui opposent « bons » et « mauvais » aliments de façon moralisatrice).

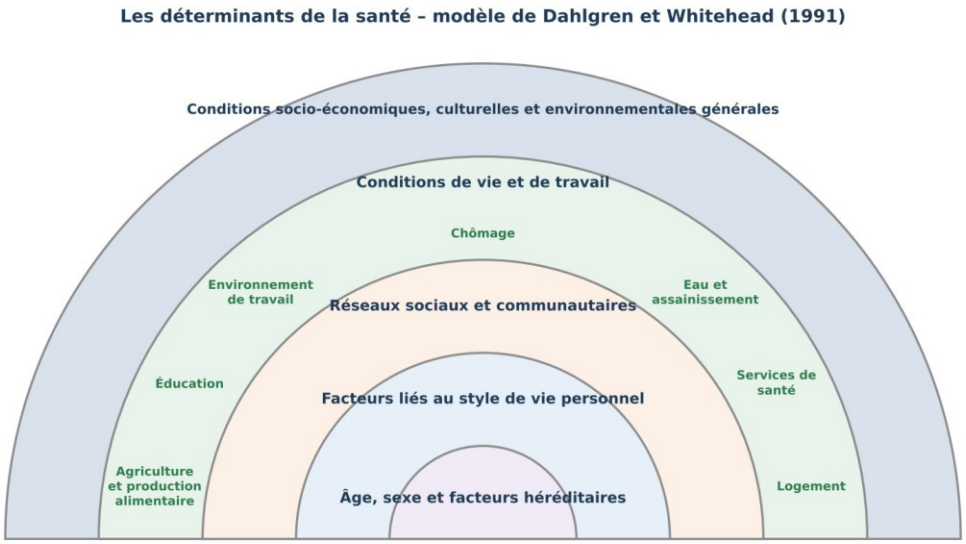


Figure 1.5 – Les déterminants de la santé selon Dahlgren et Whitehead (1991)

Comprendre le schéma – Figure 1.5

1. Au centre, les **facteurs individuels non modifiables** : âge, sexe, facteurs héréditaires.

2. Deuxième couche : les **facteurs liés au style de vie personnel** (alimentation, activité physique, tabac, alcool, sommeil). C'est là que se situent les « comportements », mais ils sont influencés par toutes les couches extérieures.
3. Troisième couche : les **réseaux sociaux et communautaires** (famille, amis, voisinage, soutien social).
4. Quatrième couche : les **conditions de vie et de travail** : agriculture et production alimentaire, éducation, environnement de travail, chômage, eau et assainissement, services de santé, logement.
5. Couche extérieure : les **conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales** (politiques économiques, fiscales, culture, climat).
6. Lecture : plus on agit sur les couches **extérieures**, plus l'action touche de personnes et réduit les inégalités ; agir seulement au centre (« manger mieux ») sans agir sur les couches externes (prix, offre, revenus) a un effet limité et peut accroître les inégalités. Ce modèle sera détaillé au chapitre 2.

Définition – Universalisme proportionné (Michael Marmot, *Fair Society, Healthy Lives*, 2010)

Principe selon lequel les actions doivent être **universelles** (destinées à toute la population), mais avec une **intensité proportionnelle au niveau de désavantage** social. Il évite deux écueils : l'action universelle seule, qui profite surtout aux plus favorisés (qui ont plus de ressources pour s'en saisir), et l'action ciblée seule, qui stigmatise et oublie le **gradient social** (la santé se dégrade progressivement à chaque échelon de l'échelle sociale, pas seulement chez les plus pauvres).

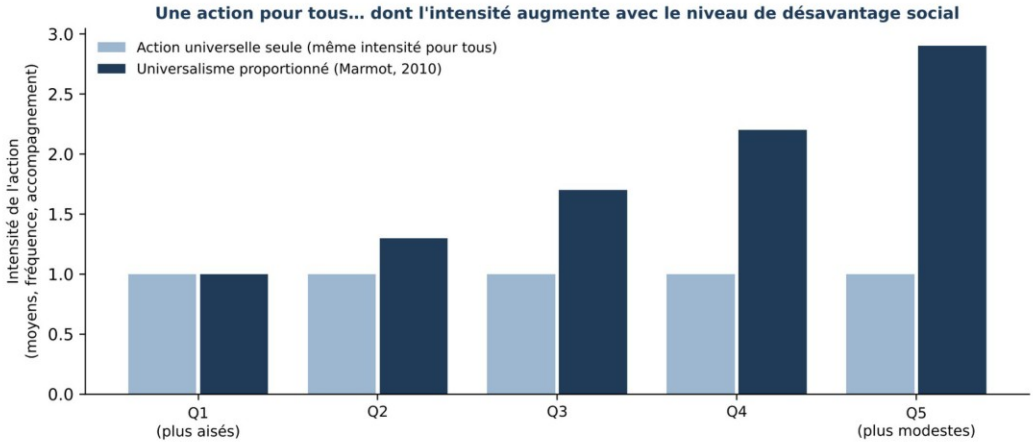


Figure 1.6 – L'universalisme proportionné : une action pour tous, plus intense pour les plus défavorisés

Comprendre le schéma – Figure 1.6

1. L'axe horizontal classe la population en cinq groupes (quintiles) du plus aisé (Q1) au plus modeste (Q5).
2. Les barres claires représentent une **action universelle seule** : la même intensité pour tous.
3. Les barres foncées représentent l'**universalisme proportionné** : l'action existe pour tous, mais son intensité (moyens, fréquence, accompagnement) augmente avec le désavantage.
4. Exemple : une cantine scolaire ouverte à tous (universel), avec une **tarification sociale** (les familles les plus modestes paient moins, dispositif de la « cantine à 1 euro » soutenu par l'État pour les communes rurales éligibles depuis 2019) et un accompagnement renforcé dans les écoles des quartiers prioritaires.

Mode 3 – La prévention

Définition – Prévention – OMS (1948)

« Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. » La prévention part toujours d'un **problème de santé défini** que l'on cherche à éviter ou à limiter.

La classification de l'OMS selon le moment de l'intervention

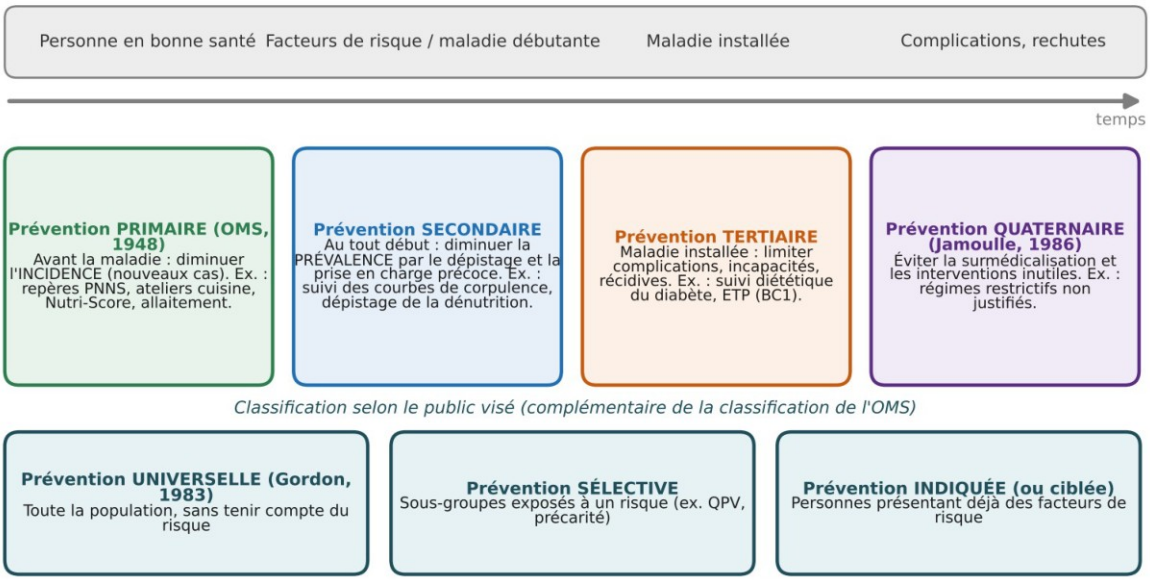


Figure 1.7 – Les niveaux de prévention selon l'OMS et selon Gordon

Comprendre le schéma – Figure 1.7

1. La bande grise représente l'**histoire naturelle de la maladie** dans le temps : bonne santé → facteurs de risque ou maladie débutante → maladie installée → complications.

2. **Prévention primaire** (vert) : intervient **avant** l'apparition de la maladie ; elle vise à diminuer l'**incidence** (le nombre de nouveaux cas). En nutrition : repères du PNNS, éducation alimentaire, promotion de l'allaitement, ateliers cuisine, Nutri-Score, réduction du sel dans le pain.

3. **Prévention secondaire** (bleu) : intervient **au tout début** de la maladie, souvent avant les symptômes ; elle vise à diminuer la **prévalence** (le nombre de cas existants) en réduisant la durée de la maladie par un dépistage et une prise en charge précoces. En nutrition : suivi des courbes de corpulence par le médecin ou la PMI (repérage du rebond d'adiposité précoce), dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD, dépistage du diabète de type 2.

4. **Prévention tertiaire** (orange) : intervient quand la maladie est **installée** ; elle vise à réduire les **complications, les incapacités et les récidives**. En nutrition : prise en charge diététique du diabète, de l'insuffisance rénale, réhabilitation nutritionnelle ; l'ETP en fait partie (BC1).

5. **Prévention quaternaire** (violet) : notion proposée par Marc Jamoulle (1986) ; elle vise à protéger les personnes de la **surmédicalisation** et des interventions inutiles ou nocives. En nutrition : éviter les régimes restrictifs non justifiés, les compléments alimentaires inutiles, les exclusions alimentaires sans diagnostic.

6. En bas, la **classification de Gordon (1983)**, fondée sur le **public visé** : universelle (toute la population), sélective (sous-groupes exposés à un risque), indiquée (personnes présentant déjà des facteurs de risque).

La classification de Gordon selon la population visée

Type	Public visé	Exemple en nutrition
Universelle	Toute la population, sans distinction de risque	Campagne « Manger Bouger », repères PNNS, Nutri- Score, menu végétarien hebdomadaire à l'école
Sélective	Sous-groupes exposés à un risque particulier, sans signe de maladie	Ateliers cuisine petit budget pour les familles d'un quartier prioritaire ; prévention de la carence en fer chez les adolescentes ; actions « 1000 premiers jours » auprès des femmes enceintes en situation de précarité
Indiquée (ou ciblée)	Personnes présentant déjà des facteurs de risque ou des signes précoces	Programme d'activité physique et d'alimentation pour les enfants en surpoids repérés par la santé scolaire (par exemple dispositif « Mission : retrouve ton cap », prise en charge pluridisciplinaire du surpoids de l'enfant financée par l'Assurance maladie)

Une troisième classification : la prévention globale (Robert San Marco, 2003)

Robert San Marco distingue la prévention **« de maladies »** (centrée sur un risque, souvent descendante) et la prévention **« globale »** ou **positive**, centrée sur la **personne** et sa qualité de vie, qui rejoint la promotion de la santé. Cette distinction est utile pour critiquer les campagnes uniquement fondées sur la peur.

Attention – Les erreurs classiques sur la prévention

- Confondre **incidence** (nouveaux cas, que la prévention primaire fait baisser) et **prévalence** (cas existants, que la prévention secondaire fait baisser en raccourcissant la durée de la maladie).
- Classer un **dépistage** en prévention primaire : le dépistage repère une maladie ou un facteur de risque **déjà présent** ; il relève de la prévention secondaire.
- Classer l'**ETP** en éducation pour la santé : l'ETP s'adresse à des **patients** ayant une maladie chronique ; elle relève du soin et de la prévention tertiaire (BC1).
- Croire qu'une action « universelle » est forcément équitable : sans universalisme proportionné, elle peut **creuser les inégalités**.

Mode 4 – L'éducation pour la santé

Définition – Éducation pour la santé (définition reprise par l'INPES puis Santé publique France)

L'éducation pour la santé « a pour but que chaque citoyen acquière, tout au long de sa vie, les **compétences** et les **moyens** lui permettant de promouvoir sa santé et sa qualité de vie ainsi que celles de la collectivité » (Plan national d'éducation pour la santé, 2001). Elle comprend toute combinaison d'expériences d'apprentissage visant à faciliter l'adoption **volontaire** de comportements favorables à la santé.

L'éducation pour la santé est **une composante** de la promotion de la santé (domaine « acquérir des aptitudes individuelles ») et un **moyen** de la prévention. Elle respecte la **liberté** des personnes : elle ne cherche pas à imposer un comportement, mais à donner les moyens de faire des choix éclairés. Le guide du BTS (2025) distingue trois formes en nutrition.

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation nutritionnelle	Connaissances sur les nutriments, les besoins, les repères, les liens alimentation-santé	Atelier « lire une étiquette et comprendre le Nutri-Score » ; jeu des familles d'aliments ; quiz sur les repères PNNS

Forme	Contenu	Exemples d'actions
Éducation alimentaire	Pratiques concrètes : choisir, acheter, conserver, cuisiner, organiser ses repas, gérer un budget, limiter le gaspillage ; dimensions culturelles et sociales	Atelier culinaire « repas complet à moins de 2 € » ; visite d'un marché ; atelier « batch cooking » ; atelier anti-gaspillage
Éducation sensorielle (éducation au goût)	Découverte des cinq sens, du vocabulaire sensoriel, du plaisir de manger ; lutte contre la néophobie	Classes du goût (méthode de Jacques Puisais, 1975, Institut du goût) ; ateliers d'éveil sensoriel en maternelle ; dégustations à l'aveugle ; « Semaine du goût » (depuis 1990, en octobre)

Les approches éducatives : de l'information à la participation

Approche	Principe	Limite	Exemple
Informative	Transmettre des connaissances (« savoir pour bien faire »)	Savoir ne suffit pas à changer : beaucoup de personnes savent qu'il faut manger 5 fruits et légumes	Affiche, dépliant, conférence
Persuasive (ou comportementale)	Convaincre de changer un comportement, parfois par la peur	Culpabilise, peut renforcer les inégalités et la stigmatisation	Campagne choc, injonction
Participative (ou humaniste, d'empowerment)	Partir des représentations et des besoins des personnes ; développer leurs compétences et leur pouvoir d'agir	Plus longue, demande des compétences d'animation	Atelier où les parents choisissent les recettes ; photolangage ; débat ; co-construction d'un livret

À retenir

En santé publique, on privilégie l'**approche participative** et le développement des **compétences psychosociales (CPS)** : Santé publique France a publié en 2022 un **référentiel des CPS** (compétences cognitives, émotionnelles et sociales) et une stratégie nationale de développement des CPS des enfants et des jeunes (2022-2037) ; ces compétences sont un déterminant majeur de la santé et du bien-être (chapitre 3).

Deux autres modes souvent cités : la sécurité sanitaire et la restauration de la santé

Les cours du CNED et de nombreux manuels présentent **cinq ou six** modes d'intervention, alors que le guide 2025 en retient quatre. Il n'y a pas de contradiction : les deux modes supplémentaires sont, soit inclus dans un mode du guide, soit hors du champ du BC3. Il faut savoir les reconnaître si un document ou un membre du jury les cite.

Définition – Sécurité sanitaire

Ensemble des mesures qui **protègent la population contre les risques** liés aux produits de santé, aux aliments, à l'eau, à l'environnement et aux soins. Elle associe la **veille** (détecter), l'**expertise** (évaluer le risque), la **gestion** (décider et agir : retrait, rappel, interdiction) et la **communication**. Elle repose sur le **principe de précaution** (article 5 de la Charte de l'environnement, 2005).

Définition – Restauration de la santé

Actions qui visent à **rétablir la santé** quand la maladie est installée : soins curatifs, réadaptation, réinsertion. Elle correspond à la prévention **tertiaire** de l'OMS et à l'**éducation thérapeutique du patient** ; elle relève surtout du soin (BC1 et BC2).

Mode cité par le CNED ou un manuel	Où le placer avec les quatre modes du guide 2025	Exemple en nutrition
Veille et sécurité sanitaire	Mode 1 (surveillance et veille) pour la détection ; mission « protéger » de la santé publique pour la gestion	Rappel d'un lot de préparation infantile contaminée ; enquête sur une TIAC dans une cantine
Restauration de la santé	Hors BC3 : soin (BC1) ; prévention tertiaire	Prise en charge diététique d'un patient après un infarctus ; programme d'ETP diabète
Promotion de la santé	Mode 2	Projet alimentaire territorial, fontaines à eau dans un quartier
Prévention	Mode 3	Dépistage de la dénutrition en EHPAD
Éducation pour la santé	Mode 4	Ateliers culinaires, éducation sensorielle

Exemple – La sécurité sanitaire des aliments : une chaîne d'acteurs

1. Le signal : trois enfants d'une même école ont des diarrhées et des vomissements le même soir. Le médecin déclare une **TIAC** (au moins deux cas groupés, symptômes similaires, même origine alimentaire) à l'**ARS**.

2. L'enquête : l'ARS et la direction départementale chargée de la protection des populations (DDPP ou DDETSPP) enquêtent sur le repas suspect ; Santé publique France analyse les données ; le laboratoire analyse les plats témoins.

3. L'évaluation : l'**ANSES** (créée en 2010) apporte l'expertise scientifique sur le danger.

4. La gestion : la préfecture ou le ministère décide du retrait ou du rappel des produits ; le rappel est publié sur **RappelConso**.

5. Le rôle du diététicien de la cuisine centrale : fournir les plats témoins conservés 5 jours, les fiches de traçabilité et le plan de maîtrise sanitaire (chapitre 13).

À retenir

Retenez les **quatre modes du guide 2025** pour qualifier votre action à l'épreuve E5. Sachez aussi que la **sécurité sanitaire** protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) et que la **restauration de la santé** relève du soin. Ces deux notions existent, mais elles ne remplacent pas les quatre modes.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.2 bis – Classer des actions

Classez chaque action dans l'un des quatre modes du guide 2025, ou indiquez qu'elle relève de la sécurité sanitaire ou de la restauration de la santé.

a) L'ANSES publie un avis sur les risques liés aux boissons énergisantes.

b) Une diététicienne anime six séances d'ETP pour des patients insuffisants rénaux.

c) Une commune installe des fontaines à eau dans tous ses parcs.

d) Un lot de fromage contaminé par *Listeria* est rappelé sur RappelConso.

e) Santé publique France publie les résultats de l'étude Esteban sur la corpulence.

f) Un atelier « goûter maison » est proposé aux parents d'une crèche.

Corrigé – Exercice 1.2 bis

a) **Sécurité sanitaire** (évaluation du risque par une expertise) ; elle prépare une décision de gestion.

b) **Restauration de la santé** : ETP, prévention tertiaire, champ du soin (BC1).

c) **Promotion de la santé** : on rend l'environnement favorable (choix facile de l'eau).

d) **Sécurité sanitaire** (gestion du risque : retrait et rappel).

e) **Surveillance** (mode 1) : données répétées sur l'état de santé de la population.

f) **Éducation pour la santé** (mode 4) : développer des compétences des parents.

Distinguer promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé et ETP

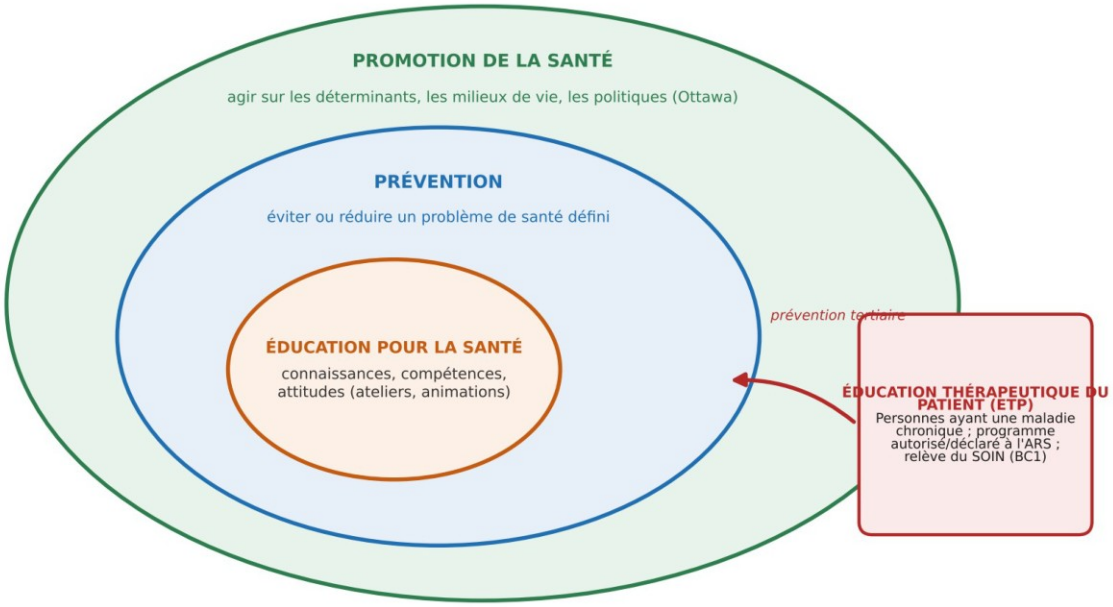


Figure 1.8 – Emboîtement des notions : promotion, prévention, éducation pour la santé et éducation thérapeutique du patient

Comprendre le schéma – Figure 1.8

1. La grande ellipse verte, la **promotion de la santé**, est la notion la plus large : elle agit sur tous les déterminants et sur les politiques.
2. L'ellipse bleue, la **prévention**, est incluse dans la promotion : elle vise des problèmes de santé définis.
3. L'ellipse orange, l'**éducation pour la santé**, est l'un des moyens de la prévention et de la promotion : elle développe les compétences des personnes.
4. Le cadre rouge, l'**ETP**, se situe à part, du côté du **soin** : elle s'adresse à des patients ayant une maladie chronique, dans un programme déclaré à l'ARS ; la flèche rappelle qu'elle participe à la **prévention tertiaire**.

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Cible	Population, milieux de vie, décideurs	Population ou groupe exposé à un problème	Personnes, groupes (bien portants)	Patient atteint d'une maladie chronique et son entourage
Objectif	Améliorer la santé et le bien-être, réduire les inégalités, renforcer le pouvoir d'agir	Éviter ou réduire un problème de santé défini	Développer connaissances, compétences, attitudes	Acquérir des compétences d'autosoins et d'adaptation pour gérer sa maladie
Point de départ	Déterminants de santé	Maladie ou facteur de risque	Besoins éducatifs du public	Diagnostic éducatif (bilan éducatif partagé)

Critère	Promotion de la santé	Prévention	Éducation pour la santé	ETP (BC1)
Leviers	Politiques, environnements, action communautaire, éducation, services	Information, dépistage, vaccination, éducation, réglementation	Ateliers, animations, outils pédagogiques	Programme structuré (séances individuelles et collectives)
Cadre	Charte d'Ottawa ; SNS ; PRS	OMS 1948 ; Gordon 1983	PNES 2001 ; Santé publique France	Loi HPST du 21 juillet 2009 (art. L. 1161-1 CSP) ; HAS 2007 ; programmes déclarés à l'ARS (depuis 2021)
Exemple	Charte « Ville active PNNS », plan alimentaire territorial	Dépistage de la dénutrition à l'entrée en EHPAD	Atelier cuisine parents-enfants	Séance « adapter son alimentation à son diabète » pour des patients d'un service hospitalier

Exemple – Un même thème, quatre modes d'intervention : la consommation de boissons sucrées chez les enfants

- **Surveillance** : les enquêtes de santé scolaire et ESTEBAN mesurent la consommation et la corpulence des enfants ; les données montrent un gradient social.
- **Promotion de la santé** : taxe sur les boissons sucrées (en France depuis 2012, rendue progressive en fonction de la teneur en sucres en 2018 et renforcée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025) ; installation de fontaines à eau dans les écoles ; interdiction des distributeurs automatiques payants dans les établissements scolaires (loi du 9 août 2004).
- **Prévention** (primaire, sélective) : programme dans les écoles d'un quartier où la prévalence du surpoids est élevée.
- **Éducation pour la santé** : atelier « fabriquer des eaux aromatisées et des goûters maison » avec les parents et les enfants ; jeu sur la quantité de sucre dans les boissons.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 – Qualifier une action

Pour chaque action, indiquez le ou les mode(s) d'intervention, le niveau de prévention (OMS) et le type (Gordon) : **a)** Une mairie signe la charte « Ville active du PNNS » et rénove l'offre de sa cantine. **b)** Une infirmière scolaire mesure poids et taille des élèves de grande section et oriente les enfants dont la courbe de corpulence monte. **c)** Une diététicienne anime 6 ateliers cuisine petit budget pour les familles d'une épicerie solidaire. **d)** Un service de diabétologie organise des séances collectives sur le comptage des glucides pour des patients diabétiques de type 1. **e)** Santé publique France diffuse un spot télévisé sur les repères « Manger Bouger ».

Corrigé

a) Promotion de la santé (politique publique locale saine, milieu favorable) ; prévention **primaire**, **universelle** (tous les enfants de la commune). **b) Prévention secondaire** (repérage précoce du surpoids, avant les complications) ; **indiquée** pour les enfants orientés (ils présentent déjà un signe : la courbe qui monte) ; c'est aussi de la **surveillance** si les données sont agrégées. **c) Éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire**, **sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité) ; elle relève aussi de la **promotion de la santé** si les familles participent au choix des thèmes (renforcement du pouvoir d'agir) et si le projet agit sur l'offre (partenariat avec l'épicerie). **d) Éducation thérapeutique du patient** (BC1), **prévention tertiaire** : il ne s'agit pas d'éducation pour la santé, car les participants sont des patients atteints d'une maladie chronique, dans un programme de soin. **e) Éducation pour la santé** de type **informative** (communication de masse), **prévention primaire universelle**.

POUR MIEUX COMPRENDRE – niveau BTS (exigible)

Le marketing social et les « nudges »

Le **marketing social** applique les techniques du marketing commercial (connaissance du public, segmentation, produit, prix, distribution, communication : les « 4 P ») pour favoriser un comportement favorable à la santé (par exemple, le programme anglais *Change4Life*). Les **nudges** (« coups de pouce », Thaler et Sunstein, 2008) modifient l'**architecture du choix** sans interdire ni culpabiliser : placer les fruits à hauteur des yeux et en début de chaîne au self, proposer l'eau par défaut au menu enfant, servir des portions adaptées. Ils sont efficaces pour des comportements quotidiens, mais ne remplacent pas l'action sur les déterminants structurels (prix, revenus, offre).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.4 – Les modes d'intervention

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre modes d'intervention du guide 2025.
2. Citez les cinq domaines d'action et les trois stratégies de la Charte d'Ottawa.
3. Classez selon l'OMS (primaire, secondaire, tertiaire) : dépistage de la dénutrition en EHPAD ; atelier cuisine pour des familles sans maladie ; ETP d'un patient diabétique.
4. Classez selon Gordon (universelle, sélective, indiquée) : un message pour tous les élèves d'un collège ; un atelier pour les familles d'un quartier prioritaire ; un suivi pour des enfants déjà en surpoids.
5. Quelle différence faites-vous entre la sécurité sanitaire et la restauration de la santé ?
6. Citez les trois formes d'éducation pour la santé en nutrition et donnez un exemple pour chacune.

Corrigé – Point d'étape 1.3.4

1. Surveillance et veille sanitaire ; promotion de la santé ; prévention ; éducation pour la santé.
2. Domaines : élaborer une politique publique saine ; créer des milieux favorables ; renforcer l'action communautaire ; acquérir des aptitudes individuelles ; réorienter les services de santé. Stratégies : promouvoir (plaider), conférer les moyens, servir de médiateur.
3. Dépistage : secondaire. Atelier cuisine : primaire. ETP : tertiaire.
4. Tous les élèves : universelle. Quartier prioritaire : sélective. Enfants déjà en surpoids : indiquée.
5. La sécurité sanitaire protège la population contre les risques (aliments, eau, produits) : veille, expertise, gestion, communication. La restauration de la santé rétablit la santé d'une personne malade (soins, réadaptation, ETP) : elle relève du soin.
6. Nutritionnelle (lire une étiquette, comprendre le Nutri-Score) ; alimentaire (atelier culinaire petit budget) ; sensorielle (classes du goût, dégustation à l'aveugle).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.5 Les acteurs et les organismes de la santé publique en nutrition

Module · Référentiel : C3.4, activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §1.5 (p. 15) ; Essentiels M1 S3 §1.6 (p. 15 et 16)

La santé publique en nutrition est **intersectorielle** : elle mobilise la santé, mais aussi l'agriculture, l'éducation, l'économie, l'environnement, la cohésion sociale. Connaître les acteurs est indispensable pour trouver des **données** (diagnostic), des **financements** (appels à projets), des **partenaires** (parties prenantes) et des **ressources** (outils pédagogiques validés).

Une typologie des acteurs selon leur rôle

Avant de présenter les acteurs par niveau (international, européen, national, régional, local), il est utile de les classer selon leur **rôle** dans une politique de santé. Le CNED retient **quatre types d'acteurs**. Un même organisme peut jouer plusieurs rôles : l'ARS décide (elle arrête le PRS), finance (fonds d'intervention régional) et pilote la mise en œuvre.

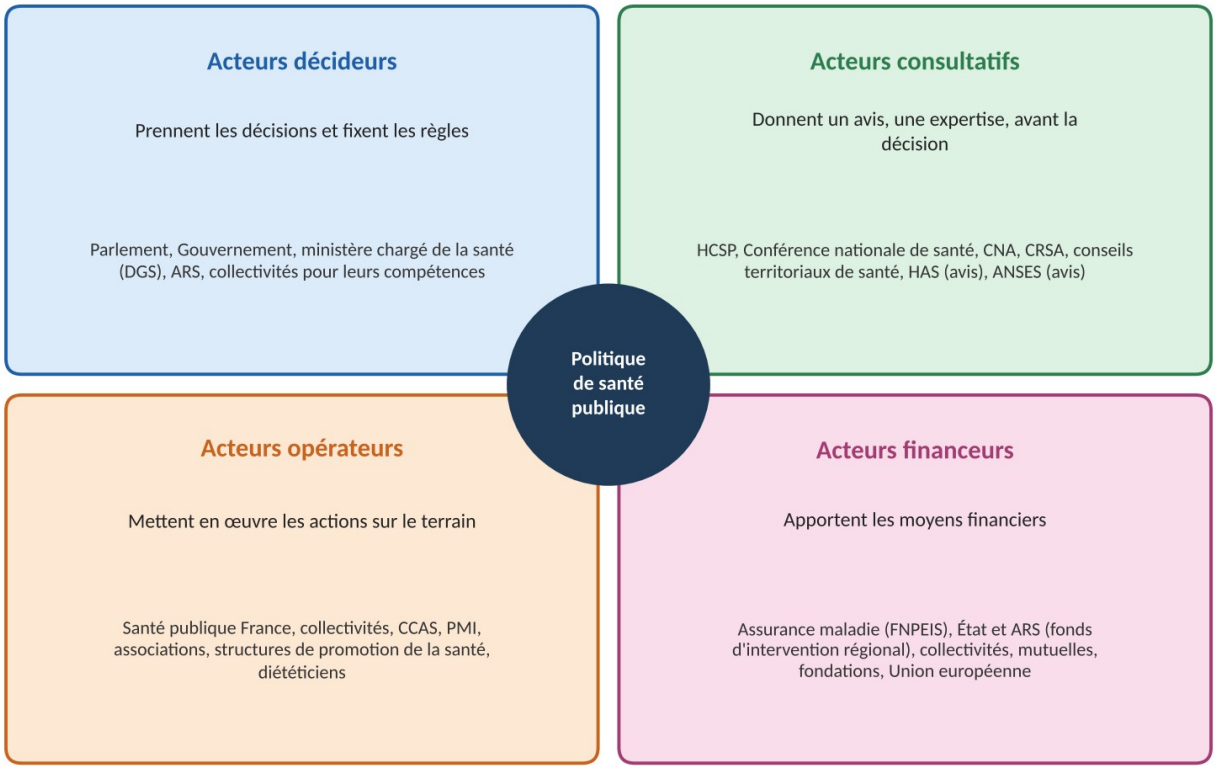


Figure 1.8 bis – Les quatre types d'acteurs d'une politique de santé publique

Comprendre le schéma – Figure 1.8 bis

1. Au centre, la **politique de santé publique** : elle a besoin des quatre types d'acteurs pour exister.
2. **En bleu, les décideurs** : ils sont à l'origine des décisions (lois, plans, arrêtés, choix des priorités).
3. **En vert, les consultatifs** : ils sont consultés **avant** la décision ; ils rendent des avis, des rapports, des recommandations.
4. **En orange, les opérateurs** : ils **mettent en œuvre** la politique décidée, sur le terrain. Le diététicien est un opérateur.
5. **En rose, les financeurs** : ils apportent les crédits (subventions, appels à projets, remboursements).
6. Pour un projet de stage, identifiez au moins un acteur de chaque couleur : c'est la base des **partenariats** (C3.3).

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Décideur	Est à l'origine des décisions	Parlement (lois), Gouvernement, ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé), ministère de l'Agriculture (Direction générale de l'alimentation)	ARS (projet régional de santé), conseil départemental (PMI), commune (restauration scolaire)
Consultatif	Est consulté pour prendre des décisions	Haut Conseil de la santé publique (HCSP), Conférence nationale de santé (CNS), Conseil national de l'alimentation (CNA)	Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), conseils territoriaux de santé

Type d'acteur	Définition (CNED)	Exemples nationaux	Exemples régionaux et locaux
Opérateur	Met en œuvre la politique décidée	Santé publique France, Assurance maladie (actions de prévention), associations nationales	Collectivités, CCAS, PMI, écoles, centres sociaux, structures régionales de promotion de la santé, diététiciens, associations locales
Financeur	Apporte les moyens financiers	Assurance maladie (Fonds national de prévention, d'éducation et d'information en santé, FNPEIS), État	ARS (fonds d'intervention régional, FIR), conseils départementaux et régionaux, communes, conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, mutuelles, fondations

Attention – Mettre à jour les sigles des cours anciens

Certains supports citent encore le « Haut **Comité** de santé publique », les « Conférences régionales de santé (CRS) » ou les « territoires de santé ». Depuis la loi du 9 août 2004, on parle du **Haut Conseil de la santé publique (HCSP)** ; depuis la loi HPST de 2009, de la **CRSA** ; depuis la loi du 26 janvier 2016, des **territoires de démocratie sanitaire** et des **conseils territoriaux de santé**. Utiliser le sigle à jour montre au jury que vos sources sont actualisées (C3.4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 bis – Identifier le rôle des acteurs d'un projet

Le projet « Petits déjeuners pour tous » d'une ville de 25 000 habitants réunit : l'ARS (qui a lancé l'appel à projets et verse 6 000 €), la CRSA (qui a rendu un avis favorable sur le PRS où figure la priorité « nutrition des enfants »), la commune (qui décide d'offrir le petit déjeuner dans 4 écoles et apporte 9 000 €), l'association « Bouge et mange » (qui anime les ateliers), une diététicienne libérale (qui conçoit les menus) et une mutuelle (2 500 €).

1. Classez chaque acteur selon la typologie (un acteur peut avoir deux rôles).
2. Calculez la part de chaque financeur dans le budget total.

Corrigé – Exercice 1.3 bis

1. **ARS** : décideur (elle arrête le PRS et choisit les projets retenus) et financeur. **CRSA** : consultatif. **Commune** : décideur (pour l'école) et financeur. **Association** : opérateur. **Diététicienne** : opérateur. **Mutuelle** : financeur.
2. Budget total : 6 000 + 9 000 + 2 500 = **17 500 €**. ARS : 6 000 / 17 500 = **34,3 %** ; commune : 9 000 / 17 500 = **51,4 %** ; mutuelle : 2 500 / 17 500 = **14,3 %**. Vérification : 34,3 + 51,4 + 14,3 = 100,0 %.

Le niveau international

Organisme	Rôle en nutrition
OMS – Organisation mondiale de la santé (Genève, 1948)	Agence de l'ONU pour la santé ; définit des normes et recommandations (sucres libres < 10 % de l'apport énergétique, idéalement < 5 % – 2015 ; sel < 5 g/jour ; allaitement exclusif 6 mois) ; plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles ; Bureau régional de l'Europe (Copenhague)
FAO – Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 1945)	Sécurité alimentaire mondiale, systèmes alimentaires durables ; avec l'OMS : Conférences internationales sur la nutrition (CIN2, Rome 2014) ; Décennie d'action des Nations unies pour la nutrition (2016-2025)

Organisme	Rôle en nutrition
Codex alimentarius (FAO/OMS, 1963)	Normes alimentaires internationales (étiquetage, additifs, hygiène, contaminants)
UNICEF	Nutrition de l'enfant et de la mère ; promotion de l'allaitement (initiative « Hôpital ami des bébés » avec l'OMS)
ONU – Objectifs de développement durable (2015- 2030)	ODD 2 « Faim zéro », ODD 3 « Bonne santé et bien-être », ODD 12 « Consommation et production responsables »
Quadripartite One Health	OMS, FAO, OMSA (ex-OIE) et PNUE : plan d'action conjoint « Une seule santé » 2022-2026

Le niveau européen

Organisme	Rôle en nutrition
Commission européenne (DG SANTE)	Propose la réglementation alimentaire (règlement INCO n° 1169/2011 sur l'information des consommateurs : déclaration nutritionnelle obligatoire, 14 allergènes ; règlement n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé)
EFSA – Autorité européenne de sécurité des aliments (Parme, 2002)	Évaluation scientifique des risques alimentaires ; valeurs nutritionnelles de référence (Dietary Reference Values) ; avis sur les allégations, additifs, contaminants
Système d'alerte rapide (RASFF)	Échange d'alertes sur les denrées dangereuses entre États membres
EUFIC	Information des consommateurs sur l'alimentation (organisme financé en partie par l'industrie : vérifier les conflits d'intérêts)

Le niveau national

Acteur	Rôle
Ministère chargé de la Santé – Direction générale de la santé (DGS)	Pilote la politique de santé publique et le PNNS ; prépare les lois et règlements ; coordonne les agences
Ministère chargé de l'Agriculture – Direction générale de l'alimentation (DGAL)	Pilote le PNA et la sécurité sanitaire des aliments (contrôles, alertes) ; restauration collective (EGalim, plateforme « ma cantine »)
Ministère de l'Économie – DGCCRF	Loyauté des pratiques commerciales, étiquetage, allégations, sécurité des produits ; RappelConso (avec la DGAL)
Ministère de l'Éducation nationale	Éducation à l'alimentation dans les programmes, santé scolaire, restauration scolaire (avec les collectivités), « Écoles promotrices de santé »
Ministère de la Transition écologique	Copilote de la SNANC ; lutte contre le gaspillage (loi AGEC)
Santé publique France (2016)	Surveillance, veille et alerte ; prévention et promotion de la santé ; programme « Manger Bouger » ; Nutri-Score (gestion du logo en France) ; registre des interventions probantes ; données (Géodes)
ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (2010)	Évaluation des risques ; références nutritionnelles (ANC puis RNP, actualisation des repères 2016-2021) ; études INCA ; table Ciqual de composition des aliments ; observatoire Oqali (avec INRAE) ; nutrivigilance

Acteur	Rôle
HAS – Haute Autorité de santé (2004)	Recommandations de bonne pratique (surpoids et obésité de l'enfant 2022 et de l'adulte, dénutrition 2019 et 2021), ETP, évaluation des pratiques
HCSP – Haut Conseil de la santé publique (2004)	Expertise pour la décision publique ; avis sur les repères alimentaires (2017 adultes, 2020 enfants) ; recommandations pour le PNNS 5 (juin 2025) ; évaluation des plans
CNA – Conseil national de l'alimentation (1985)	Instance consultative de concertation entre acteurs (production, transformation, distribution, consommateurs, santé) ; avis (n° 90 sur les nouveaux comportements alimentaires)
INCa – Institut national du cancer	Prévention nutritionnelle des cancers (avec le réseau NACRe)
Assurance maladie (CNAM, CPAM)	Prévention (examens de prévention, « Mission : retrouve ton cap »), financement d'actions, données du SNDS
Recherche : Inserm, INRAE, universités, EREN (équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle)	Production de connaissances ; cohorte NutriNet-Santé (EREN, depuis 2009)
Producteurs de données statistiques : Insee, Drees, CépiDc (Inserm), FNORS et ORS, Crédoc	Données démographiques, sociales, de mortalité (causes de décès), d'état de santé, de consommation

Le niveau régional

Acteur	Rôle
ARS – Agence régionale de santé (loi HPST du 21 juillet 2009, créées en 2010)	Pilote la politique de santé en région : élabore le projet régional de santé (PRS), finance des actions de prévention (fonds d'intervention régional, FIR), lance des appels à projets (nutrition, précarité, ETP), signe les contrats locaux de santé, autorise les établissements, reçoit les déclarations des programmes d'ETP, coordonne la veille sanitaire (signalements, TIAC)
CRSA – Conférence régionale de la santé et de l'autonomie	« Parlement régional de la santé » : donne un avis sur le PRS
DRAAF – Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt	Déclinaison régionale du PNA ; reconnaissance et financement des projets alimentaires territoriaux (PAT) ; appels à projets PNA
DREETS / DDETS	Cohésion sociale, aide alimentaire (programme « Mieux manger pour tous », depuis 2023)
Conseil régional	Lycées (restauration), formation, agriculture, aménagement
Promotion Santé (structures régionales, ex-IREPS)	Appui méthodologique aux porteurs de projets, formation, centres de ressources documentaires, outils pédagogiques
ORS – Observatoire régional de la santé	Diagnostics et portraits de territoire, indicateurs locaux
Dispositifs régionaux d'appui : réseaux de prévention, CSO (centres spécialisés de l'obésité)	Appui aux professionnels, filières de soins

Le niveau départemental et local

Acteur	Rôle
Conseil départemental	Protection maternelle et infantile (PMI) ; action sociale ; aide aux personnes âgées (APA) et en situation de handicap ; collèges (restauration)

Acteur	Rôle
Communes et intercommunalités	Restauration scolaire (écoles primaires), CCAS (centres communaux d'action sociale : épiceries sociales, aide alimentaire, portage de repas), ateliers santé ville, contrats locaux de santé, PAT, politique de la ville (contrats de ville des quartiers prioritaires, « Engagements Quartiers 2030 »)
CAF – Caisse d'allocations familiales	Financement des centres sociaux (agrément « animation collective familles »), soutien à la parentalité
Éducation nationale et services de santé scolaire	Infirmiers, médecins scolaires ; comités d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE)
Professionnels de santé de ville	Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS, mission de prévention), centres de santé
Associations	Banques alimentaires, Restos du cœur, Secours populaire, Croix-Rouge ; associations de patients ; associations sportives ; associations d'éducation populaire ; jardins partagés
Entreprises et mutuelles	Santé au travail, restauration d'entreprise, actions de prévention des mutuelles
Diététiciens-nutritionnistes	Libéraux, salariés de collectivités, de centres sociaux, d'associations, de mutuelles, de réseaux ; chargés de missions de santé publique (référentiel du BTS 2024)

Lien diététique – Trouver les acteurs de son lieu de stage

Dès la première semaine de stage, établissez une **carte des acteurs** (fiche F1, rubrique « ressources du territoire ») : ARS et sa délégation départementale, contrat local de santé de la commune, PAT du territoire, contrat de ville si le quartier est prioritaire, structure régionale Promotion Santé, ORS, PMI, CCAS, centres sociaux, épiceries solidaires, associations. Ce travail nourrit le diagnostic, le choix des partenaires et la recherche de financements.

À retenir – Organismes de recueil et de production de données (à connaître pour l'examen)

Insee (démographie, revenus, pauvreté, recensement) ; **Drees** (état de santé, enquêtes de santé scolaire, établissements) ; **CépiDc-Inserm** (causes médicales de décès) ; **Santé publique France** (surveillance, ESTEBAN, Baromètre, Géodes, Albane) ; **ANSES** (INCA, Ciqual, Oqali) ; **Assurance maladie** (SNDS : consommations de soins, ALD) ; **ORS/FNORS** (diagnostics locaux, Score-santé) ; **Crédoc** (consommation, précarité alimentaire) ; **Inserm/EREN** (NutriNet-Santé). Leur fonctionnement et l'exploitation de leurs données sont détaillés aux chapitres 2 et 17.

La démocratie sanitaire : la place des usagers

Définition – Démocratie sanitaire

Démarche qui vise à **associer l'ensemble des acteurs du système de santé**, et en particulier les **usagers** (patients, habitants, associations), à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de santé, dans un esprit de dialogue et de concertation (définition du ministère chargé de la santé).

La **loi n° 2002-303 du 4 mars 2002** relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite **loi Kouchner**, est le texte fondateur. Elle répond à une crise de confiance née d'affaires sanitaires (sang contaminé

dans les années 1980). Elle reconnaît aux malades et à leurs associations deux catégories de droits, complétées par la loi HPST de 2009 et par la loi du 26 janvier 2016.

Droits individuels (reconnus à toute personne dans sa relation avec le système de santé)	Droits collectifs (reconnus aux usagers en tant que groupe)
Accès aux soins et à la prévention, sans discrimination	Représentation des usagers par des **associations agréées**
Respect de la dignité et de la vie privée ; secret des informations	Présence de représentants des usagers dans les instances des établissements (commission des usagers)
Information sur son état de santé ; **consentement libre et éclairé**	Participation aux instances consultatives nationales, régionales et territoriales
Accès direct à son dossier médical	Participation à l'élaboration des politiques de santé (avis sur le PRS, débats publics)
Prise en charge de la douleur ; désignation d'une personne de confiance	Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, **France Assos Santé** (créée par la loi de 2016, active depuis 2017)

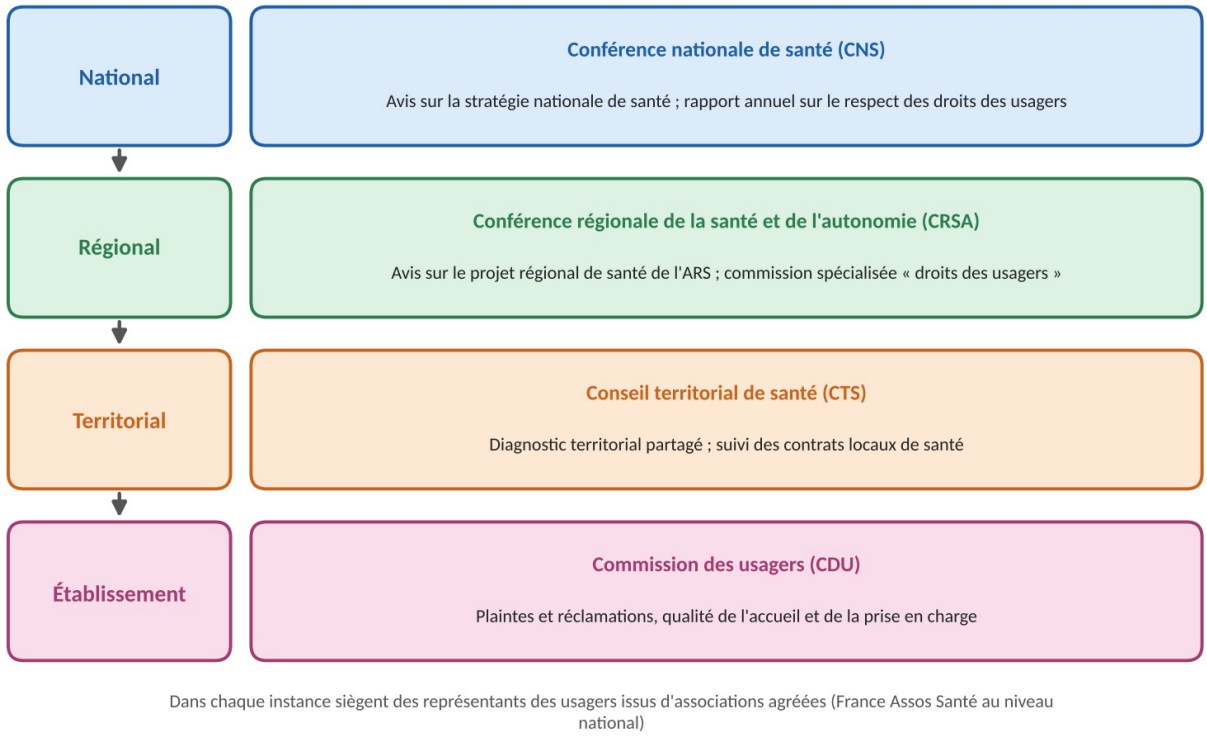


Figure 1.8 ter – Les instances de la démocratie sanitaire, du national à l'établissement

Comprendre le schéma – Figure 1.8 ter

1. Chaque **niveau** du système de santé (à gauche) a son instance de concertation (à droite).
2. **National** : la Conférence nationale de santé donne son avis sur la stratégie nationale de santé et rend chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers.
3. **Régional** : la CRSA, créée par la loi HPST, donne son avis sur le projet régional de santé de l'ARS.
4. **Territorial** : le conseil territorial de santé, créé par la loi de 2016, participe au diagnostic territorial partagé et suit les contrats locaux de santé.
5. **Établissement** : la commission des usagers (CDU) examine les plaintes et propose des améliorations de l'accueil et de la prise en charge.
6. Les flèches indiquent la déclinaison du national vers le local ; dans toutes ces instances siègent des représentants des usagers.

Lien diététique – Pourquoi la démocratie sanitaire concerne le diététicien en santé publique

La démocratie sanitaire justifie la **participation des habitants** à toutes les étapes d'un projet : recueil des besoins exprimés, choix des recettes d'un atelier, évaluation. Le principe de **participation** de la Charte d'Ottawa et la démocratie sanitaire vont dans le même sens. À l'oral, dire « j'ai associé deux mères de famille au comité de pilotage » est un argument fort.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.3 ter – Droits individuels ou collectifs ?

Classez chaque situation et nommez l'instance ou le droit concerné.

a) Une patiente demande à lire les comptes rendus de ses consultations diététiques à l'hôpital.

b) L'association départementale des diabétiques désigne un représentant pour siéger à la commission des usagers de l'hôpital.

c) La CRSA rend un avis sur le projet régional de santé 2023-2028.

d) Un résident d'EHPAD refuse l'enrichissement de ses repas après avoir reçu des explications.

Corrigé – Exercice 1.3 ter

a) **Droit individuel** : accès direct au dossier médical (loi du 4 mars 2002). Les transmissions diététiques font partie du dossier.

b) **Droit collectif** : représentation des usagers par une association agréée au sein de la **commission des usagers**.

c) **Droit collectif** : participation à l'élaboration de la politique régionale via une instance consultative, la **CRSA**.

d) **Droit individuel** : consentement libre et éclairé ; le refus doit être respecté, tracé, et la proposition renouvelée sous une autre forme (chapitre 6, éthique).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.5 – Les acteurs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre types d'acteurs selon le CNED et donnez un exemple de chacun.
2. Quel organisme pilote la veille sanitaire en France ? Depuis quand ?
3. Quel organisme évalue les risques sanitaires liés à l'alimentation et gère la table Ciqual ?
4. Citez trois droits individuels et deux droits collectifs reconnus par la loi du 4 mars 2002.
5. Nommez l'instance de démocratie sanitaire au niveau national, régional, territorial et dans un hôpital.
6. Calcul : un projet reçoit 4 200 € de l'ARS, 2 800 € de la commune et 1 000 € d'une fondation. Quelle est la part de l'ARS ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.5

1. Décideur : ARS, ministère. Consultatif : HCSP, CNS, CRSA. Opérateur : Santé publique France, associations, diététicien. Financeur : Assurance maladie, ARS (fonds d'intervention régional), collectivités.
2. Santé publique France, créée le 1er mai 2016 (regroupement de l'InVS, de l'INPES, de l'EPRUS et d'Adalis).
3. L'ANSES (créée en 2010).
4. Individuels : accès aux soins ; information et consentement libre et éclairé ; accès direct au dossier médical ; secret ; prise en charge de la douleur. Collectifs : représentation par des associations agréées ; présence dans les instances (commission des usagers, CRSA, CNS).
5. National : Conférence nationale de santé. Régional : CRSA. Territorial : conseil territorial de santé. Hôpital : commission des usagers.

6. Total : 4 200 + 2 800 + 1 000 = 8 000 €. Part de l'ARS : 4 200 / 8 000 × 100 = 52,5 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.6 Les politiques publiques de santé : élaboration, pilotage, mise en œuvre et déclinaison territoriale

Module · Référentiel : activité 3.1 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Essentiels M1 S2 §1.1 (p. 8) ; Essentiels M1 S3 §1.1 et §1.2 (p. 13 et 14) ; Essentiels M1 S3 §1.3 et §1.4 (p. 14 et 15) ; Essentiels M1 S3 §2 et §3 (p. 16)

Qu'est-ce qu'une politique publique de santé ?

Définition – Politique publique

Ensemble coordonné de décisions et d'actions conduites par les pouvoirs publics (État, collectivités) pour répondre à un **problème reconnu comme public**, avec des **objectifs**, des **moyens** (juridiques, financiers, humains) et des **acteurs** chargés de sa mise en œuvre. Elle se traduit par des **lois**, des **stratégies**, des **plans** ou **programmes**, des **règlements** et des **financements**.

Outil	Définition	Exemples en nutrition
Loi	Texte voté par le Parlement, de portée générale et obligatoire	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (création des distributeurs interdits dans les écoles, inscription du PNNS) ; loi EGalim (2018) ; loi Climat et résilience (2021)
Règlement (décret, arrêté)	Texte du Gouvernement ou d'un ministre qui précise l'application d'une loi	Arrêté du 31 octobre 2017 sur le Nutri-Score, modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 (nouvel algorithme) ; décret du 30 septembre 2011 sur la qualité nutritionnelle des repas scolaires
Stratégie	Cadre pluriannuel qui fixe les grandes orientations et priorités	Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030
Plan ou programme	Déclinaison opérationnelle d'une stratégie, avec des actions, des pilotes, un calendrier, des indicateurs	PNNS 5 2026-2030 ; PNA 4 2026-2030
Financement	Crédits attribués aux acteurs	Fonds d'intervention régional des ARS ; appels à projets PNA ; programme « Mieux manger pour tous »

Les étapes d'une politique publique

1. Mise à l'agenda : un problème devient « public » sous l'effet de données (surveillance épidémiologique), d'alertes d'experts (avis du HCSP), de médias, d'associations, d'événements (crise sanitaire). Exemple : l'augmentation de la prévalence de l'obésité infantile dans les années 1990 conduit au premier PNNS en 2001.

2. Élaboration : diagnostic, consultation des experts (HCSP, ANSES, CNA), concertation des parties prenantes, consultation publique (le projet de SNS 2023-2033 a fait l'objet d'une consultation publique à l'automne 2023 ; il n'était pas encore adopté en mai 2026), arbitrages interministériels.

3. Décision et adoption : loi, décret, publication d'une stratégie ou d'un programme.

4. Mise en œuvre : par les administrations centrales, les agences, les **ARS** et les collectivités, avec des **financements** et des **partenaires** (associations, professionnels).

5. Pilotage et suivi : comités de pilotage, indicateurs, tableaux de bord, rapports annuels.

6. Évaluation : par des instances indépendantes (HCSP, Inspection générale des affaires sociales – IGAS, Cour des comptes) ; elle prépare le plan suivant. Exemple : l'évaluation du PNNS 4 et l'avis du HCSP de juin 2025 ont servi à construire le PNNS 5.

L'organisation de la politique de santé en France

- **La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé** a fait de la **prévention** et de la **promotion de la santé** des priorités de la politique de santé et a créé le **Nutri-Score** (article 14 : possibilité d'un étiquetage nutritionnel simplifié, facultatif).
- **La Stratégie nationale de santé (SNS)** (article L. 1411-1-1 du Code de la santé publique) fixe les priorités de la politique de santé pour plusieurs années. La dernière SNS adoptée couvre **2018-2022** (décret du 29 décembre 2017). Le **projet de SNS 2023-2033**, soumis à consultation à l'automne 2023, met l'accent sur la prévention tout au long de la vie, l'accès aux soins, la réduction des inégalités et la santé environnementale (« Une seule santé ») ; selon une réponse du ministère publiée au *Journal officiel* le 12 mai 2026, il n'avait pas encore été adopté par le Gouvernement. Dans un dossier, on s'appuie donc sur la SNANC 2025-2030 et le PNNS 5, et l'on présente la SNS 2023-2033 comme un projet.
- **Le Comité interministériel pour la santé** (créé en 2014) coordonne les politiques des différents ministères ayant un impact sur la santé.
- **Les agences sanitaires** (Santé publique France, ANSES, HAS) apportent l'expertise et la mise en œuvre opérationnelle.

Priorités, programmes et planification sanitaire

Définition – Les mots de la planification

Priorité sanitaire : décision des pouvoirs publics de mettre en place des mesures pour résoudre un problème de santé identifié (par exemple, le surpoids des enfants).

Plan ou **programme** : ensemble organisé d'actions, avec des objectifs, des acteurs, des partenaires, des moyens et un calendrier, pour atteindre un objectif commun (le PNNS est un programme ; les plans nationaux durent en général 4 à 5 ans).

Planification sanitaire : démarche qui consiste à **prévoir** les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, **selon un ordre de priorité**, en adaptant l'offre de soins et de prévention aux besoins de la population. Elle doit respecter le cadre fixé par la **stratégie nationale de santé** ; dans chaque région, c'est l'ARS qui la conduit au travers du PRS.

Territoire de démocratie sanitaire : découpage de la région, arrêté par l'ARS depuis la loi du 26 janvier 2016, à l'échelle duquel siège un conseil territorial de santé. Il a remplacé les anciens « territoires de santé ».

Méthode – La logique descendante et la logique ascendante

La planification est **descendante** : la SNS fixe les priorités, le PRS les décline, le contrat local de santé les traduit en fiches-actions. Mais elle est aussi **ascendante** : les diagnostics locaux (diagnostic territorial partagé, observatoire régional de santé) remontent les besoins, et les instances de démocratie sanitaire donnent leur avis. Un bon projet de stage montre les **deux logiques** : « mon action répond à la priorité n° X du PRS » (descendant) et « elle répond aux besoins exprimés par les habitants » (ascendant).

Les données qui éclairent les politiques de santé

Une politique se décide à partir de données. Les grands producteurs de données et les enquêtes nutritionnelles sont étudiés au chapitre 17. Retenez ici deux dispositifs souvent cités dans les cours.

Dispositif	Ce que c'est	Intérêt pour la santé publique
Système national des données de santé (SNDS)	Base qui rassemble, depuis la loi du 26 janvier 2016, les données de l'Assurance maladie (remboursements, SNIIRAM), des hôpitaux (PMSI) et les causes médicales de décès (Inserm-CépiDc) ; il est géré par la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam)	Connaître le recours aux soins, le nombre de personnes traitées pour un diabète, l'évolution d'une maladie dans un territoire
Plateforme des données de santé (Health Data Hub)	Groupement d'intérêt public créé par la loi du 24 juillet 2019 ; il a remplacé l'Institut national des données de santé (INDS, 2017-2019)	Faciliter l'accès sécurisé des chercheurs et des agences aux données de santé, dans le respect du RGPD (chapitre 20)

Attention – Une donnée de remboursement n'est pas une donnée de santé complète

Le SNDS compte les personnes **traitées** et **remboursées**. Une personne diabétique non diagnostiquée, ou qui ne consulte pas, n'y figure pas. Pour l'obésité, qui ne donne pas lieu à un remboursement spécifique, on utilise surtout des **enquêtes** (Esteban, OFÉO, santé scolaire). Il faut toujours dire **d'où vient** un chiffre et **ce qu'il mesure** (C3.4).

La déclinaison territoriale

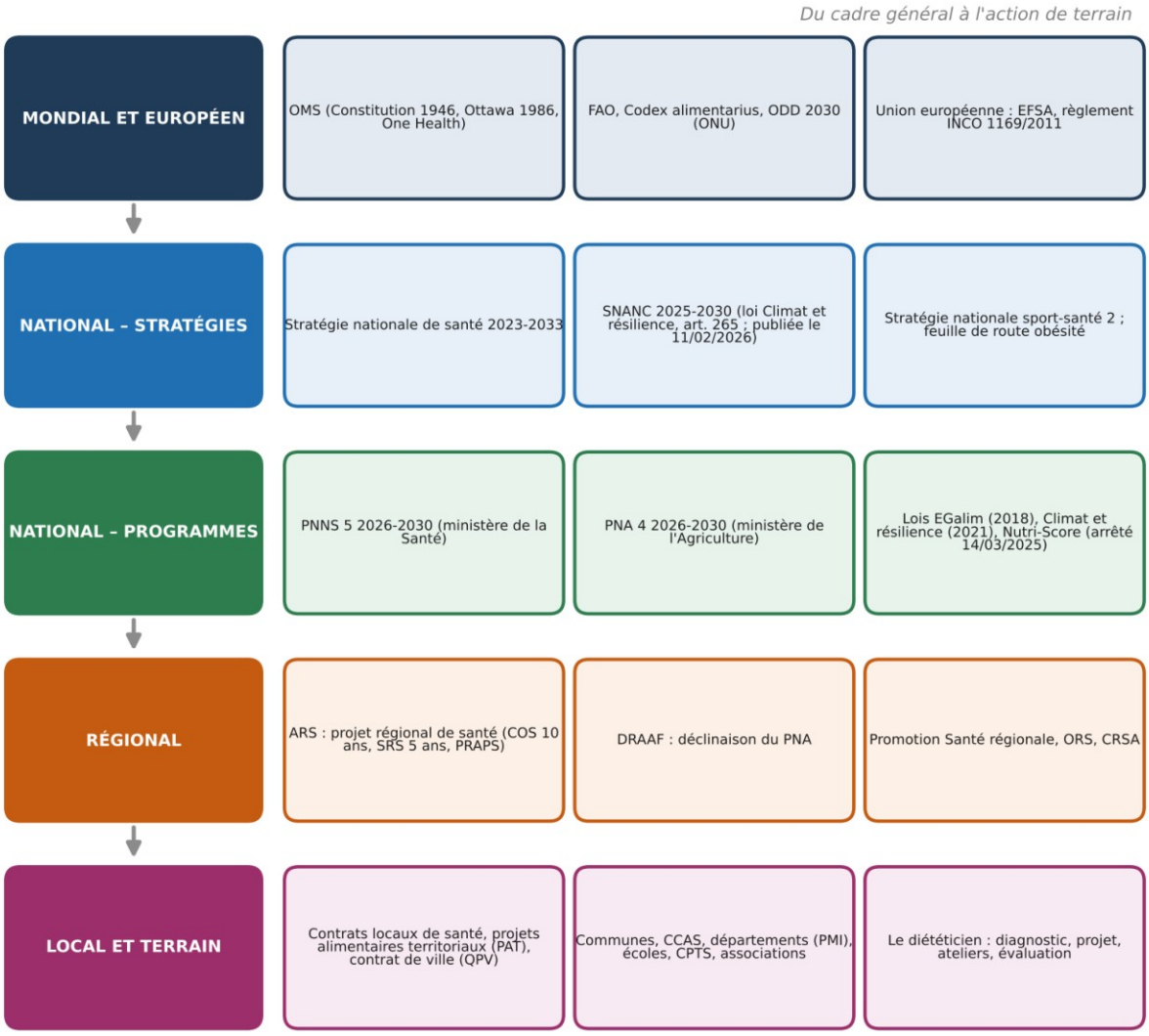


Figure 1.9 – De la stratégie internationale à l'action de terrain : architecture des politiques nutritionnelles en 2026

Comprendre le schéma – Figure 1.9

1. Mondial et européen : l'OMS, la FAO, les ODD et l'Union européenne fixent un cadre (définitions, recommandations, réglementation de l'étiquetage).

2. National – stratégies : la SNS fixe les priorités de santé (dernière adoptée : 2018-2022 ; projet 2023-2033 non adopté en mai 2026) ; la SNANC 2025-2030 relie alimentation, nutrition et climat ; d'autres stratégies complètent (sport-santé, obésité).

3. National – programmes : le PNNS 5 (Santé) et le PNA 4 (Agriculture) déclinent la SNANC en actions ; les lois (EGalim, Climat et résilience) et les règlements (Nutri-Score) les rendent obligatoires.

4. Régional : l'ARS traduit ces orientations dans le PRS ; la DRAAF décline le PNA ; les structures régionales de promotion de la santé et l'ORS apportent l'appui méthodologique et les données.

5. Local et terrain : contrats locaux de santé, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI, écoles, CPTS et associations mettent en œuvre ; le diététicien conçoit et anime les actions et les évalue.

6. Les flèches montrent que chaque niveau **s'appuie** sur le niveau supérieur : en stage, vous devez pouvoir relier votre action locale à ces différents textes.

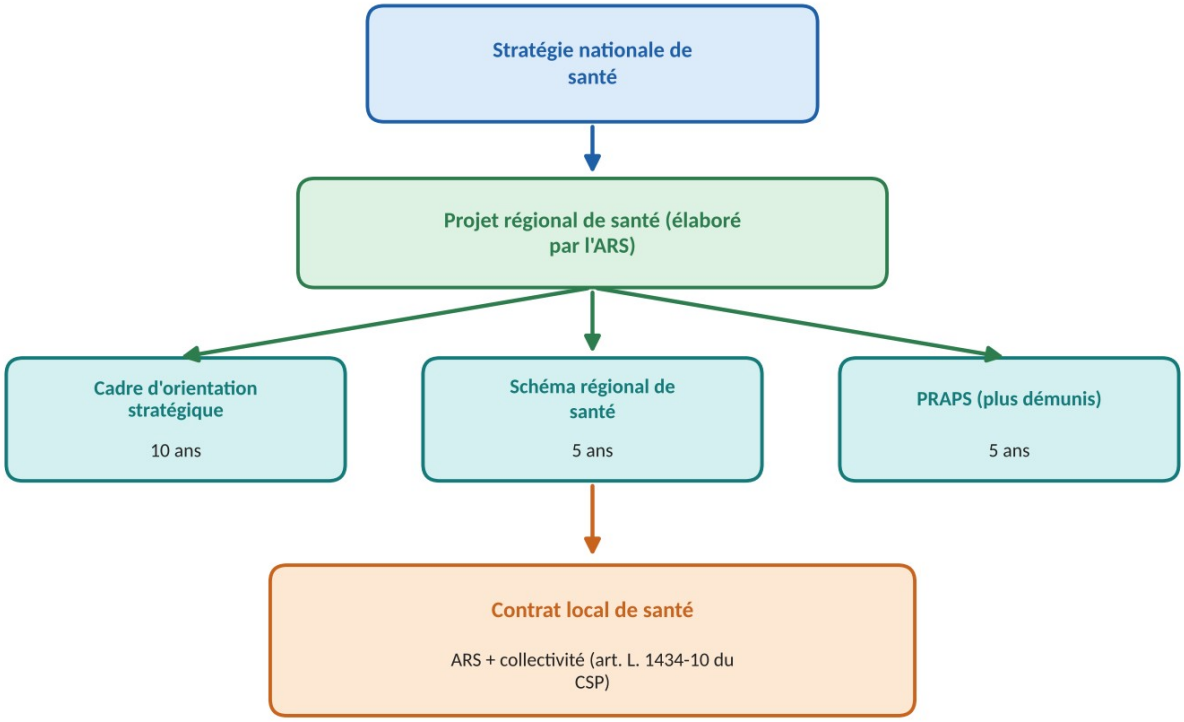


Figure 1.9 bis – De la stratégie nationale au contrat local de santé

Comprendre le schéma – Figure 1.9 bis

1. En haut, la **stratégie nationale de santé** fixe les priorités (dernière adoptée : 2018-2022 ; le projet 2023-2033 n'était pas adopté en mai 2026).
2. Chaque **ARS** élabore un **projet régional de santé** qui la décline dans la région.
3. Le PRS comprend trois documents : le **cadre d'orientation stratégique** (10 ans), le **schéma régional de santé** (5 ans) et le **PRAPS** pour les plus démunis (5 ans).
4. En bas, le **contrat local de santé** est signé entre l'ARS et une collectivité ; il traduit le PRS en fiches-actions sur un territoire (article L. 1434-10 du Code de la santé publique).
5. Un projet de stage cite au moins le **niveau régional** (objectif du PRS) et, s'il existe, le **CLS** du territoire.

Dispositif	Contenu
Projet régional de santé (PRS) – art. L. 1434-1 CSP	Élaboré par l'ARS ; comprend un cadre d'orientation stratégique (COS) sur 10 ans, un schéma régional de santé (SRS) sur 5 ans (prévention, offre de soins, médico-social) et un programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS). Les PRS dits « de 3e génération » couvrent généralement la période 2023-2028 (COS jusqu'en 2033)
Contrat local de santé (CLS) – art. L. 1434-10 CSP	Contrat entre l'ARS et une collectivité (commune, intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants ; volet nutrition fréquent
Projet alimentaire territorial (PAT) – loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014	Démarche collective qui rapproche producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs pour développer une alimentation locale, durable et accessible ; reconnu par le ministère de l'Agriculture ; au 1er juillet 2025, environ 450 PAT étaient reconnus et la SNANC fixe l'objectif d'au moins 80 % du territoire couvert

Dispositif	Contenu
Contrat de ville (politique de la ville)	Concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ; nouvelle génération « Engagements Quartiers 2030 » (2024-2030) ; volet santé souvent porté par un atelier santé ville (ASV)
Conseil local de santé mentale, CPTS, MSP	Coordination des acteurs de santé de proximité

Exemple – Comment une orientation nationale devient une action dans un quartier

1. National : le PNNS 5 (2026-2030) fait de la réduction des inégalités sociales en nutrition et de la santé des enfants des priorités ; il se donne pour objectif de réduire de 30 % la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (20 % chez ceux issus de familles défavorisées).

2. Régional : le PRS de l'ARS inscrit la nutrition des enfants dans les quartiers prioritaires parmi ses priorités de prévention et lance chaque année un **appel à projets** « prévention – promotion de la santé ».

3. Local : le contrat local de santé de la commune de Valmont (fictive) prévoit une fiche-action « Bien manger dans les quartiers ».

4. Terrain : le centre social des Tilleuls répond à l'appel à projets avec l'appui d'une diététicienne et d'une stagiaire de BTS ; il obtient une subvention de 1 500 € (cas fil rouge, fiche F4).

À vous de jouer – Exercice d'application 1.4

Pour votre futur lieu de stage (ou, à défaut, pour votre commune), recherchez sur internet : a) le PRS de votre région et l'objectif qui concerne la nutrition ; b) l'existence d'un contrat local de santé ; c) l'existence d'un PAT ; d) la présence de quartiers prioritaires (site de l'ANCT, *sig.ville.gouv.fr*). Présentez le résultat dans un tableau de 4 lignes : dispositif / existe ? / référence (titre, date) / ce qui concerne la nutrition.

Corrigé – Méthode de correction

- Le PRS se trouve sur le site de l'ARS (rubrique « Projet régional de santé ») ; repérez dans le **SRS** le chapitre « prévention » ou « nutrition » et notez l'objectif précis, avec sa date.
- Les CLS sont listés sur le site de l'ARS ou de la collectivité ; vérifiez qu'il est **en cours** (dates de début et de fin).
- Les PAT sont recensés sur le site du ministère de l'Agriculture et sur France PAT (Réseau national des PAT, RnPAT).
- Les QPV se vérifient sur le système d'information géographique de la politique de la ville (*sig.ville.gouv.fr*), à partir d'une adresse.
- Exemple de ligne rédigée : « CLS de Valmont 2024-2028 – oui – fiche-action 3 "Bien manger dans les quartiers" – actions d'éducation alimentaire dans les centres sociaux, financement ARS. » Chaque ligne doit comporter un **titre**, une **date** et une **source** : c'est l'attendu de l'indicateur « sources d'informations fiables repérées et connues » (C3.4).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.6 – Politiques publiques et territoires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les étapes d'une politique publique.
2. Que fixe la stratégie nationale de santé ? Où en est la SNS 2023-2033 ?
3. Citez les trois composantes du projet régional de santé et leur durée.
4. Qu'est-ce qu'un contrat local de santé ? Qui le signe ?
5. Définissez la planification sanitaire.

6. Vrai ou faux : « Le SNDS permet de connaître le nombre exact de personnes en situation d'obésité. » Justifiez.

Corrigé – Point d'étape 1.3.6

1. Mise à l'agenda ; élaboration ; décision et adoption ; mise en œuvre ; pilotage et suivi ; évaluation (qui prépare le plan suivant).

2. Elle fixe les priorités de la politique de santé ; la dernière adoptée couvre 2018-2022, et le projet 2023-2033 n'était pas encore adopté en mai 2026.

3. Cadre d'orientation stratégique (10 ans), schéma régional de santé (5 ans), programme régional d'accès à la prévention et aux soins des plus démunis (PRAPS).

4. Un contrat entre l'ARS et une collectivité (commune ou intercommunalité) pour mettre en œuvre le PRS au plus près des habitants.

5. Démarche qui consiste à prévoir les actions à mener pour atteindre des objectifs de santé, selon un ordre de priorité, dans le cadre de la stratégie nationale de santé.

6. Faux : le SNDS contient des données de remboursement et d'hospitalisation ; l'obésité n'est pas repérée par un remboursement spécifique. On utilise des enquêtes (Esteban, OFÉO).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.7 Les politiques nutritionnelles de santé publique

Module · Référentiel : C3.4 · Guide 2025 : p. 60 · CNED : Synthèse M3 S1 §2 (p. 29)

Pourquoi une politique nutritionnelle ? Les enjeux en chiffres

La nutrition (alimentation et activité physique) est un **déterminant majeur** des principales maladies chroniques : obésité, diabète de type 2, maladies cardio-neurovasculaires, plusieurs cancers, ostéoporose, et, à l'autre extrémité, dénutrition et carences. Ces maladies sont **fréquentes**, **graves**, **coûteuses** et **socialement inégalitaires** : elles justifient une politique publique.

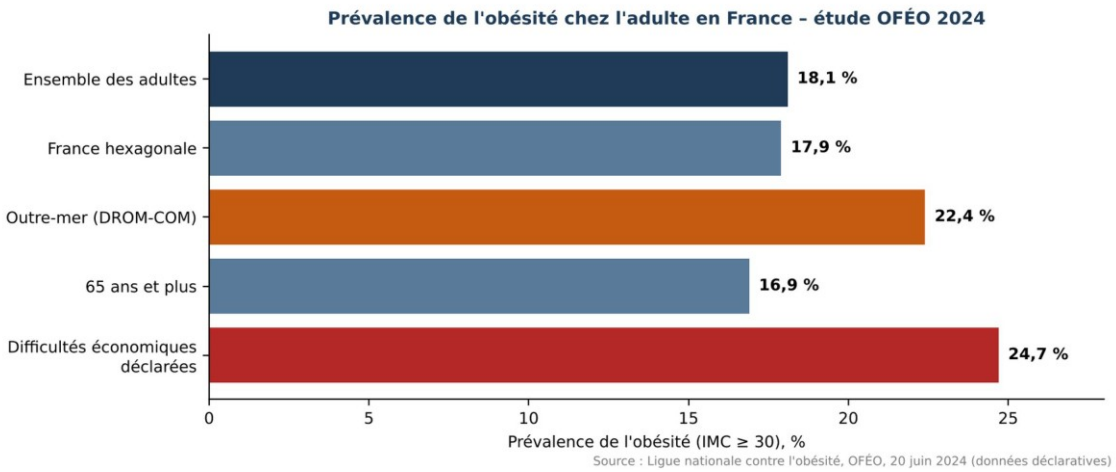


Figure 1.10 – Prévalence de l'obésité chez l'adulte en France selon le territoire, l'âge et la situation économique (OFÉO, 2024)

Comprendre le schéma – Figure 1.10

1. En 2024, **18,1 %** des adultes vivant en France déclarent un IMC ≥ 30 kg/m², soit environ **10 millions** de

personnes (étude OFÉO de la Ligue nationale contre l'obésité, présentée le 20 juin 2024, successeur de l'étude ObÉpi-Roche 2020 qui trouvait 17 %).

2. La prévalence est plus élevée **en outre-mer** (22,4 %) qu'en France hexagonale (17,9 %) : c'est une **inégalité territoriale**.
3. Elle atteint **24,7 %** chez les personnes déclarant des **difficultés économiques** : c'est une **inégalité sociale**.
4. Ces données sont **déclaratives** (poids et taille déclarés), ce qui sous-estime en général la prévalence ; les données **mesurées** de l'étude ESTEBAN (2014-2016) donnaient 17 % d'obésité et 49 % de surpoids (obésité comprise) chez les 18-74 ans.
5. Lecture pour le diététicien : ces écarts justifient le principe d'**universalisme proportionné** et la priorité donnée par le PNNS 5 aux enfants des familles défavorisées et aux territoires ultramarins.

Indicateur	Valeur et source
Obésité de l'adulte (déclarée)	18,1 % en 2024 ; 22,4 % en outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques (OFÉO, Ligue nationale contre l'obésité, juin 2024)
Surpoids (obésité comprise) et obésité mesurés, adultes 18-74 ans	49 % dont 17 % d'obésité (ESTEBAN 2015, Santé publique France, 2017)
Surpoids (obésité comprise) des enfants de 6 à 17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015)
Adultes atteignant les 5 fruits et légumes par jour	environ 30 % des adultes et 20 % des enfants (HCSP, recommandations pour le PNNS 5, juin 2025)
Apports en fibres	90 % des adultes n'atteignent pas 25 g/jour (HCSP, juin 2025)
Viande rouge	4 hommes sur 10 et 1 femme sur 4 dépassent le repère de 500 g par semaine (HCSP, juin 2025)
Sel	Consommation moyenne d'environ 9 g/jour chez l'homme et 7 g/jour chez la femme (INCA 3, ANSES 2017), pour un repère OMS < 5 g/jour
Activité physique des jeunes	42 % des 6-17 ans atteignaient 60 minutes par jour en 2016 ; près d'un adulte sur trois reste assis plus de 7 heures par jour en 2024 (HCSP, juin 2025)
Précarité alimentaire	16 % des Français déclarent ne pas avoir assez à manger (souvent ou parfois) en 2022, contre 9 % en 2016 (Crédoc, 2023)
Espérance de vie à la naissance (2025)	85,9 ans pour les femmes, 80,3 ans pour les hommes (Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026)
Inégalités sociales de mortalité	Environ 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5 % d'hommes les plus aisés et les 5 % les plus modestes (Insee Première n° 1687, février 2018)
Vieillissement	22,2 % de la population a 65 ans ou plus au 1er janvier 2026 (Insee) : enjeu de prévention de la dénutrition

Attention – Bien lire un chiffre de santé publique

Avant de citer un chiffre dans un dossier, vérifiez : **l'année** de recueil (et pas seulement l'année de publication) ; la **population** (adultes ? 18-74 ans ? France entière ?) ; la **méthode** (mesuré ou déclaré) ; la **source** (institutionnelle, associative, industrielle). Par exemple, 17 % d'obésité (ESTEBAN, mesuré, 2015) et 18,1 % (OFÉO, déclaré, 2024) ne sont pas directement comparables.

Historique : du PNNS 1 au PNNS 5

Période	Repères principaux
2001-2005 – PNNS 1	Lancé en janvier 2001 à la suite des États généraux de l'alimentation (2000) et du rapport du HCSP ; 9 objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés (augmenter la consommation de fruits et légumes, de calcium, de glucides complexes et de fibres ; réduire les lipides totaux sous 35 % de l'apport énergétique et les acides gras saturés ; réduire l'alcool, la cholestérolémie, la pression artérielle ; réduire de 20 % l'obésité de l'adulte et stopper l'augmentation chez l'enfant ; augmenter l'activité physique) ; guide « La santé vient en mangeant » (2002)
2004	Loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : le PNNS devient un programme quinquennal inscrit dans la loi ; interdiction des distributeurs automatiques payants de boissons et produits alimentaires dans les établissements scolaires (à partir de 2005) ; messages sanitaires obligatoires sur les publicités alimentaires (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », 2007)
2006-2010 – PNNS 2	Actions sur l'offre alimentaire : chartes d'engagements volontaires de progrès nutritionnel des industriels (2008) ; création de l'Oqali (2008) ; actions auprès des populations défavorisées
2010	Loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 : création du Programme national pour l'alimentation (PNA) ; Plan obésité 2010-2013
2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) – PNNS 3	Réduction des inégalités sociales de santé en nutrition ; activité physique ; dénutrition ; articulation avec le Plan obésité
2016	Loi de modernisation de notre système de santé : base légale du Nutri-Score (adopté en France par arrêté du 31 octobre 2017)
2017	Avis du HCSP sur la révision des repères alimentaires des adultes (février) ; actualisation des repères par l'ANSES (décembre 2016) ; résultats d'INCA 3 et d'ESTEBAN
2018	Loi EGalim (30 octobre 2018)
2019-2023 – PNNS 4	Lancé en septembre 2019 ; 5 axes, 55 actions ; nouveaux repères alimentaires de Santé publique France (janvier 2019) ; extension du Nutri-Score ; PNA 3 (2019-2023) ; PNNS 4 et PNA 3 réunis dans le Programme national de l'alimentation et de la nutrition (PNAN)
2021	Loi Climat et résilience (22 août 2021) : prévoit une stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (article 265) ; menu végétarien hebdomadaire pérennisé en restauration scolaire
2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 (juin) ; nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté du 14 mars 2025) ; lancement de l'enquête Albane (juin)
2026	SNANC 2025-2030 publiée le 11 février 2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 8 avril 2026 au One Health Summit de Lyon

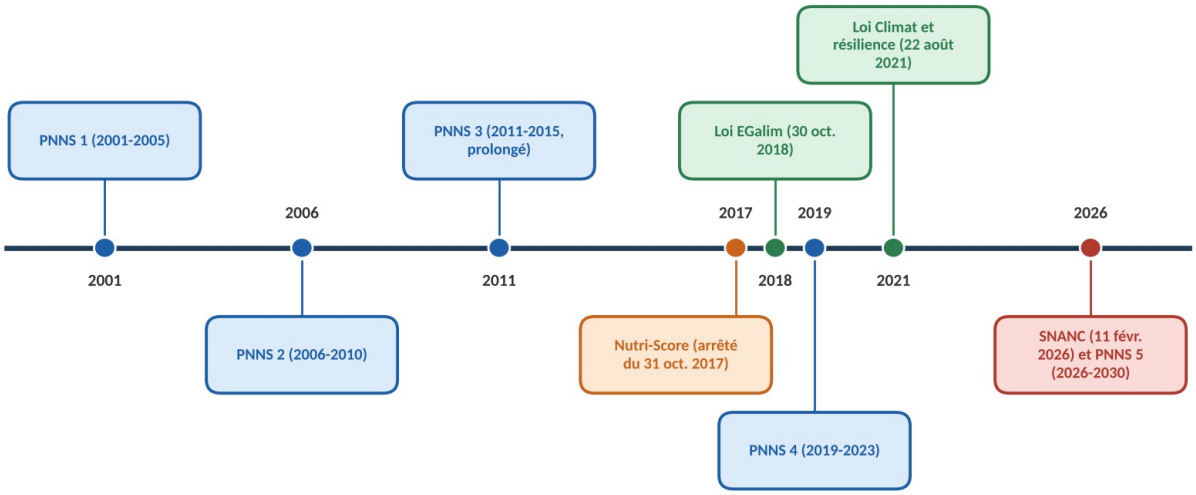


Figure 1.10 bis – Vingt-cinq ans de politiques nutritionnelles en France (2001-2026)

Comprendre le schéma – Figure 1.10 bis

1. En **bleu**, les cinq programmes nationaux nutrition santé : ils se succèdent depuis 2001.
2. En **orange**, le **Nutri-Score**, adopté en France par l'arrêté du 31 octobre 2017.
3. En **vert**, les lois qui agissent sur l'offre alimentaire : **EGalim** (30 octobre 2018) et **Climat et résilience** (22 août 2021).
4. En **rouge**, l'étape actuelle : la **SNANC**, publiée le 11 février 2026, et le **PNNS 5** (2026-2030).
5. La frise montre une évolution : on est passé d'une politique de **messages** (PNNS 1) à une politique qui agit aussi sur l'**environnement alimentaire** et le **climat**.

La Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) 2025-2030

Définition – SNANC

Stratégie prévue par l'**article 265 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021** portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi « Climat et résilience »). Elle fixe les **orientations de la politique de l'alimentation durable**, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et alimentaires et garante de la souveraineté alimentaire, ainsi que les orientations de la **politique de la nutrition**. Elle détermine les orientations du **PNNS** et du **PNA**. Attendue en 2023, elle a été publiée le **11 février 2026** pour la période **2025-2030**.

La SNANC articule **trois enjeux** : **santé publique**, **transition écologique** et **souveraineté alimentaire**. Elle s'organise autour de trois grands axes (présentation gouvernementale du 11 février 2026) :

1. Permettre à tous l'accès à une alimentation plus saine : renforcer la prévention nutritionnelle, encourager des produits de qualité, diversifiés et durables, lutter contre la précarité alimentaire, améliorer l'information du consommateur.

2. Réduire l'impact de l'alimentation sur le climat : pratiques agricoles durables, réduction du gaspillage alimentaire, relocalisation de certaines productions, adaptation de toute la chaîne alimentaire au changement climatique.

3. Soutenir les agriculteurs et les filières : transition agroécologique, valorisation des productions françaises, résilience et innovation. Elle insiste sur l'**action territoriale** (objectif d'au moins **80 % du territoire couvert par des PAT**) et rappelle les obligations EGalim en restauration collective. Le PNNS 5 et le PNA 4 en sont les **déclinaisons opérationnelles**.

Le Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)

État de la veille – PNNS 5 – ce qu'il faut savoir (état au 26 octobre 2026)

- **Pilotage** : ministère chargé de la Santé (DGS), en articulation interministérielle avec le PNA 4 ; programme élaboré avec l'IGAS, le CGAAER, le HCSP et une large concertation (ARS, société civile, chercheurs).
- **Trois axes** : 1) « garantir à tous l'accès à des environnements nutritionnels durables favorables à la santé » ; 2) « encourager des comportements nutritionnels sains et durables » ; 3) « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé » (entreprises, établissements scolaires et d'enseignement supérieur).
- **20 mesures** (contre 55 actions dans le PNNS 4), dont des actions spécifiques pour les **enfants et adolescents** et pour les **territoires ultramarins**.
- **Objectifs chiffrés annoncés** : réduire de **30 %** la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants et adolescents (et de **20 %** chez ceux issus de familles défavorisées) ; atteindre **12 %** de consommation de produits bio ; **40 %** des Français utilisant le Nutri-Score (contre 33 %) et **75 %** du volume des produits transformés affichant le Nutri-Score (contre 62 %) ; **85 %** d'enfants allaités à la naissance.
- **Mesures phares** : protection des enfants face au marketing alimentaire (charte ARCOM 2025-2029, réflexion sur des restrictions autour des écoles) ; accord collectif demandé aux filières pour réduire les **sucres** dans les produits destinés aux enfants (viennoiseries, biscuits) ; Nutri-Score étendu (non-préemballé, restauration hors foyer en test) ; promotion de l'allaitement et alimentation des « 1000 premiers jours » ; prévention de la **dénutrition** des personnes âgées ; **nouvelles recommandations alimentaires saines et durables** pour la population générale et des publics spécifiques (femmes en désir de grossesse, personnes âgées…).
- **Ce qui change** : l'activité physique relève désormais principalement de la **Stratégie nationale sport- santé** et la prise en charge de l'obésité d'une feuille de route dédiée ; les aliments **ultra-transformés** sont reconnus comme un enjeu majeur, l'ANSES étant chargée d'en proposer une définition opérationnelle.

Sources : présentation officielle du 8 avril 2026 et synthèses publiées (Réseau national nutrition santé, Vidal, avril 2026). **À vérifier dans le texte intégral** sur le site du ministère de la Santé ou sur mangerbouger.fr avant toute citation chiffrée dans un dossier.

Le Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)

Piloté par le **ministère de l'Agriculture**, le PNA (créé par la loi du 27 juillet 2010, art. L. 1 du Code rural et de la pêche maritime) décline la SNANC sur les volets **offre alimentaire**, **restauration collective**, **lutte contre le gaspillage**, **éducation alimentaire** (notamment à l'école) et **justice sociale** (accès de tous à une alimentation de qualité). Il soutient les **PAT** et lance des **appels à projets** nationaux et régionaux (via les DRAAF) dont peuvent bénéficier des projets d'éducation alimentaire.

Les repères alimentaires en vigueur (adultes)

Les repères de **Santé publique France (janvier 2019)**, issus de l'avis du HCSP (février 2017) et de l'actualisation de l'ANSES (décembre 2016), sont présentés sur **mangerbouger.fr** en trois catégories :

Catégorie	Repères
Augmenter	Fruits et légumes : au moins 5 portions par jour (une portion ≈ 80 à 100 g) ; légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches) : au moins 2 fois par semaine ; fruits à coque sans sel ajouté : une petite poignée par jour ; activité physique : au moins 30 minutes d'activité dynamique par jour
Aller vers	Féculents complets (pain, pâtes, riz) : au moins un par jour ; huiles de colza, de noix, d'olive ; poisson : 2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; produits laitiers : 2 par jour ; aliments de saison et produits locaux, bio si possible ; fait maison

Catégorie	Repères
Réduire	Alcool : au maximum 10 verres standard par semaine, pas plus de 2 par jour, et des jours sans consommation ; boissons sucrées (sodas, jus de fruits) : au maximum un verre par jour ; produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés ; charcuterie : 150 g par semaine maximum ; viande (hors volaille) : 500 g par semaine maximum ; sel ; temps passé assis

Attention – Repères et populations spécifiques

Les repères ci-dessus concernent les **adultes**. Il existe des repères spécifiques pour les **enfants de 0 à 17 ans** (HCSP, juin 2020 ; déclinaisons Santé publique France), les **femmes enceintes et allaitantes** et les **personnes âgées** (ANSES 2019 ; révisions annoncées par le PNNS 5). En atelier, adaptez toujours les messages au public (chapitres 4 et 10).

Les autres leviers réglementaires et programmes

Levier	Contenu
Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) et loi Climat et résilience (2021)	En restauration collective publique (et privée depuis 2024) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio (en valeur d'achat HT, depuis le 1er janvier 2022) ; depuis le 1er janvier 2024, 60 % de produits durables et de qualité pour les viandes et poissons (100 % pour l'État) ; menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire ; plan pluriannuel de diversification des protéines (plus de 200 couverts par jour) ; information des convives ; lutte contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; suppression progressive du plastique. Les achats sont télédéclarés sur la plateforme « ma cantine ». Le bilan publié en 2024 (achats 2023) montrait environ 25,5 % de produits durables et de qualité et 12,1 % de bio : les objectifs ne sont pas atteints
Nutri-Score	Logo nutritionnel à 5 couleurs et lettres (A à E), développé par l'équipe EREN, adopté en France le 31 octobre 2017, facultatif (le droit européen ne permet pas de l'imposer) ; utilisé dans 7 pays (France, Belgique, Espagne, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) ; nouvel algorithme adopté par le comité de pilotage européen (2022-2023) et rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, avec 2 ans de transition : meilleur classement des huiles riches en acides gras insaturés (colza, olive, noix), des poissons gras, des céréales complètes ; classement plus sévère des produits salés et sucrés et des boissons édulcorées ; seule l'eau est classée A parmi les boissons
Fiscalité	Contribution sur les boissons sucrées (2012), progressive selon la teneur en sucres depuis 2018, et sur les boissons édulcorées
Encadrement du marketing	Loi du 20 décembre 2016 (suppression de la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique depuis 2018) ; chartes alimentaires de l'ARCOM (charte 2025-2029)
1000 premiers jours	Programme lancé en 2020 (rapport de la commission présidée par Boris Cyrulnik) : alimentation de la femme enceinte et du jeune enfant, allaitement, accompagnement des parents ; site 1000-premiers-jours.fr
Aide alimentaire	Programme « Mieux manger pour tous » (depuis 2023) : améliorer la qualité nutritionnelle et l'accès à des produits frais et locaux dans l'aide alimentaire ; projets alimentaires de territoire solidaires

Levier	Contenu
Restauration scolaire	Tarification sociale (« cantine à 1 € », 2019) ; petits-déjeuners gratuits dans les écoles des territoires prioritaires (2019) ; programme européen « lait et fruits à l'école »
Labels et chartes PNNS	Collectivités actives PNNS (villes, départements), établissements actifs, entreprises actives ; logo PNNS sur les supports conformes ; Réseau national nutrition santé

Lien diététique – Utiliser les politiques nutritionnelles dans son dossier E5

Dans la partie « contexte » de votre dossier, montrez que votre projet **s'inscrit** dans les politiques en vigueur : citez la **SNANC 2025-2030**, l'axe et l'action du **PNNS 5** concernés, l'objectif du **PRS** de votre région, le **CLS** ou le **PAT** du territoire. Une phrase type : « Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du PNNS 5 (2026-2030), "encourager des comportements nutritionnels sains et durables", et dans l'objectif de réduction des inégalités sociales de santé du PRS de la région… ». Le jury valorise la **cohérence** entre le diagnostic local et ces priorités.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 – Calculer un taux EGalim

Une cantine scolaire a acheté sur l'année 120 000 € HT de denrées, dont 18 000 € de produits bio, 21 000 € de produits sous label Rouge ou AOP/IGP (non bio), et 6 000 € de produits issus de la pêche durable (écolabel). Calculez le taux de produits bio et le taux de produits durables et de qualité. La cantine respecte-t-elle la loi EGalim ?

Corrigé

Formule : taux (%) = montant des achats de la catégorie / montant total des achats × 100. **Étape 1 – Taux de bio** : 18 000 / 120 000 × 100 = **15 %**. L'objectif est d'au moins 20 % : **non atteint** (il manque 5 points, soit 0,05 × 120 000 = 6 000 € d'achats bio supplémentaires à budget constant). **Étape 2 – Produits durables et de qualité** (le bio en fait partie) : 18 000 + 21 000 + 6 000 = 45 000 € ; 45 000 / 120 000 × 100 = **37,5 %**. L'objectif est d'au moins 50 % : **non atteint** (il manque 12,5 points, soit 15 000 €). **Interprétation** : la cantine est en progression mais ne respecte pas les deux seuils EGalim ; le diététicien peut proposer de remplacer une partie des achats conventionnels par des produits bio de saison (moins chers en saison) et de financer ces achats par la diversification des protéines (plats à base de légumineuses, moins coûteux) et la réduction du gaspillage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.7 – Les politiques nutritionnelles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les périodes des cinq PNNS.
2. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand la SNANC a-t-elle été publiée ?
3. Quels sont les trois axes du PNNS 5 ?
4. Quelles sont les obligations EGalim en restauration collective (produits durables et bio) ?
5. Citez quatre repères « Augmenter » de Santé publique France.
6. Calcul : un restaurant scolaire achète 82 000 € HT de denrées, dont 15 600 € de produits bio et 23 400 € d'autres produits durables et de qualité. Les objectifs EGalim sont-ils atteints ?

Corrigé – Point d'étape 1.3.7

1. PNNS 1 : 2001-2005 ; PNNS 2 : 2006-2010 ; PNNS 3 : 2011-2015 (prolongé jusqu'en 2018) ; PNNS 4 : 2019-2023 ; PNNS 5 : 2026-2030.

2. La loi Climat et résilience du 22 août 2021 (article 265) ; publication le 11 février 2026.

3. Environnements nutritionnels durables et favorables à la santé ; comportements nutritionnels sains et durables ; mobilisation des milieux de vie et des acteurs clés.

4. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits bio, en valeur d'achat HT.

5. Fruits et légumes (au moins 5 par jour) ; légumes secs (au moins 2 fois par semaine) ; fruits à coque sans sel ajouté (une petite poignée par jour) ; activité physique (au moins 30 minutes par jour).

6. Bio : 15 600 / 82 000 × 100 = 19,0 % (objectif de 20 % non atteint). Durables et de qualité, bio compris : (15 600 + 23 400) / 82 000 × 100 = 47,6 % (objectif de 50 % non atteint). Il manque 0,20 × 82 000 − 15 600 = 800 € de bio et 0,50 × 82 000 − 39 000 = 2 000 € de produits durables.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.8 Le diététicien-nutritionniste en santé publique

Module · Référentiel et guide : voir 1.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Le cadre réglementaire de la profession

Définition – Diététicien – article L. 4371-1 du Code de la santé publique

« Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée. Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux **activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition**. »

Le titre de diététicien est **protégé** : seuls peuvent l'utiliser les titulaires du BTS Diététique et nutrition, du BUT Génie biologique parcours diététique et nutrition (ou des anciens diplômes équivalents) ou d'une autorisation d'exercice, **enregistrés au répertoire ADELI puis RPPS** (répertoire partagé des professionnels de santé). Le terme « nutritionniste », lui, n'est pas protégé : c'est pourquoi on emploie l'expression **diététicien- nutritionniste**.

Les missions en santé publique

Le référentiel du BTS (2024) cite, parmi les emplois accessibles, celui de **chargé de missions en santé publique** sur des programmes pilotés par des collectivités territoriales. Le guide de l'AFDN « Le diététicien dans les actions de santé publique » (version 2, 2022) décrit les missions suivantes :

- réaliser ou participer à un **diagnostic** de santé nutritionnelle d'un territoire ou d'une population ;
- **concevoir, coordonner, animer et évaluer** des projets et des actions de promotion de la santé, de prévention et d'éducation nutritionnelle ;
- concevoir des **outils pédagogiques** et des **supports de communication** adaptés (littératie) ;
- **former** des relais (animateurs, enseignants, aides à domicile, bénévoles d'associations) ;
- **conseiller** les décideurs (élus, directeurs de structures) sur la qualité de l'offre alimentaire (restauration scolaire, distributeurs, aide alimentaire) ;
- participer à des **études** et à la **recherche** (enquêteur, analyse de données) ;
- assurer une **veille** et diffuser des informations validées ;

- participer à des **réseaux** et à des instances (CLS, PAT, comités de pilotage).

Les cadres d'exercice

Employeur	Exemples de missions de santé publique
Collectivités territoriales (communes, CCAS, départements, régions)	Coordination d'un volet nutrition de CLS, PMI (1000 premiers jours), restauration scolaire, portage de repas, PAT
Centres sociaux, associations d'éducation populaire, épiceries solidaires	Ateliers cuisine, accompagnement de familles, éducation alimentaire
Associations de prévention, structures régionales Promotion Santé, réseaux	Conception de programmes, formation de relais, appui méthodologique
Mutuelles, Assurance maladie, entreprises (santé au travail)	Programmes de prévention pour les adhérents ou les salariés
Éducation nationale, enseignement supérieur	Interventions en classes, projets d'« écoles promotrices de santé », services de santé étudiante
Clubs et fédérations sportives	Nutrition du sportif, prévention des troubles du comportement alimentaire
Libéral	Interventions ponctuelles rémunérées par des structures (conventions de prestation)

La posture professionnelle en santé publique

- **Respecter** les personnes, leurs cultures, leurs choix et leurs contraintes ; ne pas juger ni culpabiliser (pas de « bons » et de « mauvais » aliments assénés de façon moralisatrice ; vocabulaire non stigmatisant).
- **Partir des besoins** et des représentations du public, et non de ce que le professionnel croit savoir.
- **Travailler en partenariat** et reconnaître les compétences des autres acteurs (animateurs, travailleurs sociaux, enseignants).
- **Transmettre des informations validées**, datées et sourcées, indépendantes des intérêts commerciaux ; déclarer et éviter les **conflits d'intérêts** (par exemple, ne pas faire la promotion d'une marque lors d'un atelier).
- **Respecter le secret professionnel** et le **RGPD** (données des participants, photos : droit à l'image).
- **S'auto-évaluer** et ajuster sa pratique (indicateur du référentiel).

Attention – Ce qu'un diététicien ne fait pas en santé publique

- Poser un **diagnostic médical** ou dépister une maladie sans cadre (le repérage se fait selon des protocoles et avec orientation vers un médecin).
- Prescrire un **régime thérapeutique** à un participant d'atelier : en cas de pathologie, on oriente vers une consultation (BC1).
- Utiliser des outils ou des messages d'une **marque** sans analyse critique (conflit d'intérêts).
- Diffuser des **photos** de participants sans autorisation écrite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 1.3.8 – Le diététicien en santé publique et le projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois missions du diététicien en santé publique.
2. Donnez la définition d'un projet selon l'Afnor.
3. Distinguez projet, action et atelier avec un exemple.
4. Citez les quatre types de besoins de Bradshaw.
5. Citez trois choses qu'un diététicien ne fait pas en santé publique.
6. Citez les six étapes de la démarche de projet.

Corrigé – Point d'étape 1.3.8

1. Réaliser un diagnostic de santé nutritionnelle ; concevoir, animer et évaluer des projets et des actions ; concevoir des outils pédagogiques ; former des relais ; conseiller les décideurs sur l'offre alimentaire ; participer à des études ; assurer une veille ; participer à des réseaux (trois au choix).
2. « Processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. »
3. Projet : « Bien manger, petit budget » sur six mois. Action : cycle de 4 ateliers culinaires (un objectif opérationnel). Atelier : la séance n° 3 « Repas complet petit budget ».
4. Normatif, ressenti, exprimé, comparatif.
5. Poser un diagnostic médical ; prescrire un régime thérapeutique à un participant d'atelier ; promouvoir une marque ; diffuser des photos sans autorisation écrite.
6. Analyse de situation et diagnostic ; priorités et objectifs ; conception et plan d'action ; mise en œuvre et pilotage ; évaluation ; valorisation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés « À retenir » de la section, puis je refais les questions manquées.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la section et je refais l'exercice d'application.

1.3.9 Fil rouge : le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » du centre social des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 1.2.2)

Ce cas, entièrement **fictif** mais construit à partir de situations réelles et d'ordres de grandeur nationaux, accompagne tout le BC3 (comme le cas de Mme L. dans le BC1). Il montre comment une étudiante de BTS, **Inès**, mène un projet de santé publique pendant son stage de six semaines, de l'analyse de situation à la valorisation, en remplissant les **14 fiches-outils** (F1 à F14). Les méthodes de chaque étape sont détaillées aux chapitres 7, 8 et 9 ; ici, l'objectif est de voir le **projet dans son ensemble** et de relier chaque étape aux notions du chapitre 1.

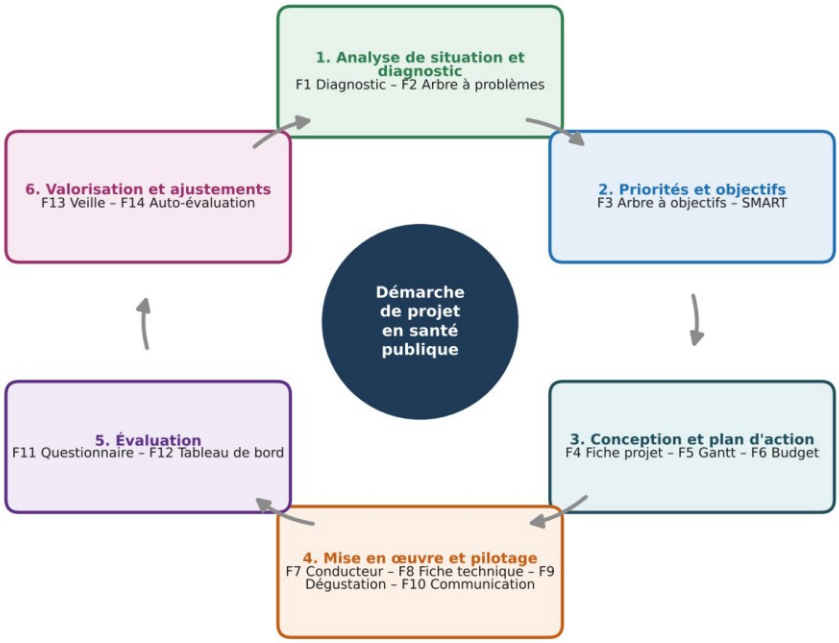


Figure 1.11 – La démarche de projet en santé publique et les fiches-outils F1 à F14

Comprendre le schéma – Figure 1.11

1. Analyse de situation et diagnostic : on rassemble les données sur le territoire et le public (F1) et on identifie le problème central, ses causes et ses conséquences (F2, arbre à problèmes).

2. Priorités et objectifs : on transforme l'arbre à problèmes en arbre à objectifs (F3) et on rédige des objectifs SMART.

3. Conception et plan d'action : on rédige la fiche projet (F4), le planning (F5, Gantt) et le budget (F6).

4. Mise en œuvre et pilotage : on prépare et anime chaque séance (F7 conducteur, F8 fiche technique d'atelier, F9 grille de dégustation) et on communique (F10).

5. Évaluation : on recueille et on analyse les données (F11 questionnaire, F12 tableau de bord).

6. Valorisation et ajustements : on diffuse les résultats, on assure la veille (F13) et on s'auto-évalue (F14).

7. Au centre, la démarche est un **cycle** : l'évaluation nourrit un nouveau diagnostic et l'amélioration du projet.

Le projet en santé publique : définitions et vocabulaire

Définition – Projet (Afnor)

Un projet est un « processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant une date de début et une date de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conformément à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (définition reprise de la norme NF EN ISO 9000, citée par le CNED).

Un **projet de santé publique** ajoute trois caractéristiques à cette définition : il part d'un **diagnostic de situation** partagé, il vise une **population** (et non un individu) et il est **évalué** au regard de ses objectifs et de son effet sur les inégalités de santé. Il respecte le cadre légal : Code de la santé publique, recommandations officielles, code de déontologie, éthique et secret professionnel.

Notion	Définition	Exemple dans le fil rouge
Projet	Ensemble coordonné d'actions, sur une durée définie, qui répond à un problème identifié par un diagnostic, avec des objectifs, des moyens et une évaluation	« Bien manger, petit budget, grand plaisir » (septembre 2027 – mars 2028)
Action	Ensemble d'activités qui répond à **un objectif opérationnel** du projet	Cycle de 4 ateliers culinaires pour les parents ; exposition « goûters malins »
Atelier (ou séance)	Temps concret d'animation, avec un public, un lieu, une durée et un déroulé ; c'est une **modalité** d'une action	Atelier n° 3 « Repas complet petit budget » du 21 mars 2028
Appel à projets	Procédure par laquelle un financeur (ARS, Assurance maladie, collectivité, fondation) publie un **cahier des charges** (priorités, publics, critères, montant, date limite) et sélectionne les projets qu'il finance	Appel à projets « prévention – promotion de la santé » de l'ARS
Parties prenantes	Toutes les personnes et organisations concernées par le projet : l'**équipe** projet, les **partenaires** (appui humain, logistique, matériel ou financier, ponctuel ou régulier), les **usagers** (bénéficiaires)	Inès, Mme Martin et Mme Benali ; épicerie solidaire, PMI, CCAS ; parents du quartier
Valorisation	Faire connaître le projet et ses résultats aux participants, aux partenaires et aux financeurs, **tout au long** du projet	Article dans le journal municipal, bilan présenté au comité de pilotage
Capitalisation	Transformer l'expérience en **connaissances et en outils réutilisables** pour d'autres projets	Livret de recettes et fiche « comment monter un atelier » transmis au centre social

Erreur fréquente – Appeler « projet » un simple atelier

Un atelier culinaire isolé n'est pas un projet : il n'a ni diagnostic, ni objectifs hiérarchisés, ni évaluation d'ensemble. À l'oral, dites « l'atelier n° 3 est **une des actions** de mon projet », et non « mon projet, c'est un atelier ».

Méthode – Démarche d'étude et démarche de projet

La **démarche d'étude** analyse un sujet, une population ou un territoire à partir de données ; elle **produit de la connaissance** (chapitre 18). La **démarche de projet** utilise cette connaissance pour **agir**. L'étude recueille des données « **froides** » (statistiques, rapports d'activité, bilans) et des données « **chaudes** » (questionnaires, entretiens, observations, réunions). Le diagnostic d'un projet combine toujours les deux.

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
QQOQCP (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)	Décrire une situation de façon complète, sans oublier d'aspect	Chapitre 7
Arbre à problèmes et arbre à objectifs	Relier le problème central à ses causes et à ses conséquences, puis en déduire les objectifs	Chapitre 7 (exemples aux figures 1.12 et 1.13)
Diagramme d'Ishikawa (causes et effet)	Classer les causes d'un problème par familles (par exemple : personnes, offre alimentaire, environnement, organisation, budget)	Chapitre 7

Outil d'analyse	À quoi il sert	Chapitre où il est approfondi
Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)	Évaluer la faisabilité d'un projet : ressources internes et contexte externe	Chapitre 7
Analyse des champs de forces (Lewin)	Identifier les forces favorables et les forces de résistance à un changement	Chapitre 8
Carte mentale	Organiser les idées d'un sujet autour d'un thème central, en équipe ou seul	Chapitres 7 et 15

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le contexte

Valmont est une commune fictive de 38 000 habitants. Le **quartier des Tilleuls** (4 200 habitants) est un **quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)**. Le **centre social des Tilleuls**, agréé par la CAF (« animation collective familles »), dispose d'une **cuisine pédagogique**. Sa référente familles, **Mme Martin** (conseillère en économie sociale et familiale), est la **tutrice** d'Inès. Une diététicienne, **Mme Benali**, intervient au centre social dans le cadre d'une convention avec le CCAS. L'**épicerie solidaire** « Le Panier partagé » (CCAS) est située à 300 mètres. **Calendrier du stage** : période 1 du 31 mai au 11 juin 2027 (2 semaines, fin de 1re année) ; travail de conception en établissement de septembre 2027 à février 2028 ; période 2 du 6 au 31 mars 2028 (4 semaines, 2e année), soit **6 semaines au total** comme le prévoit le référentiel ; épreuve E5 en juin 2028.

Les besoins : la typologie de Bradshaw

Le mot « besoin » est au cœur du diagnostic. Le sociologue britannique **Jonathan Bradshaw** a distingué en **1972** quatre types de besoins sociaux. Cette typologie est classique en santé publique : elle oblige à croiser le regard des professionnels et celui de la population.

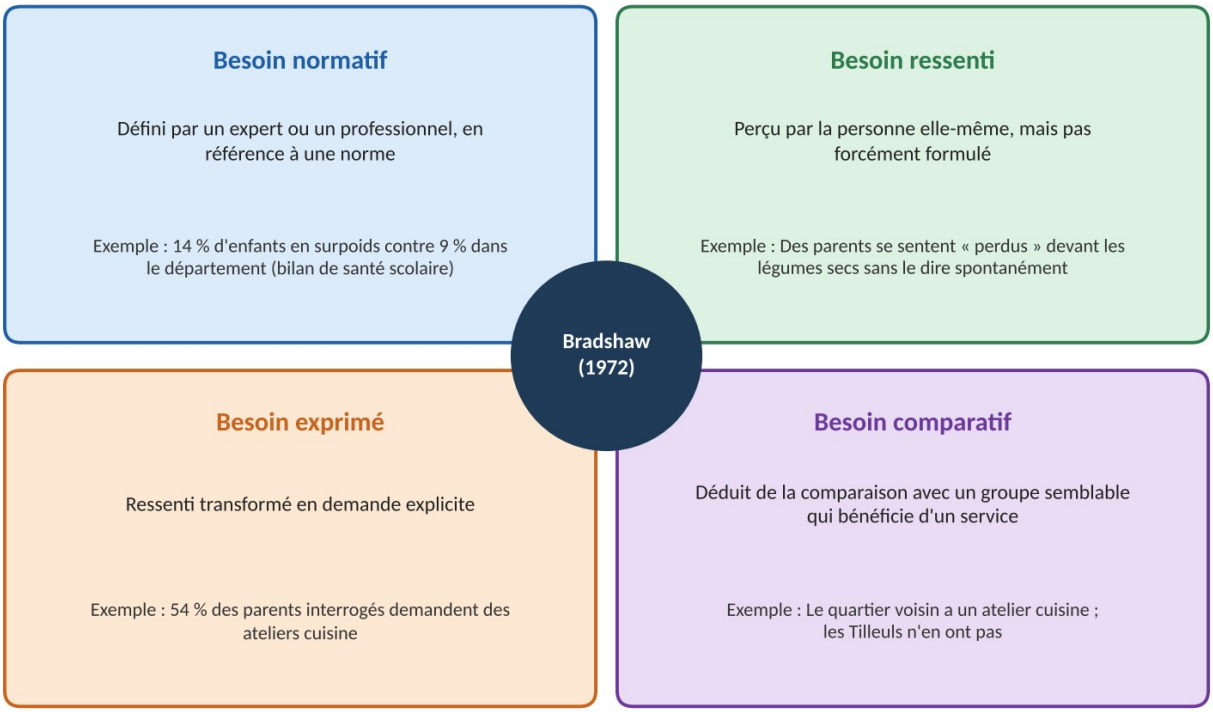


Figure 1.11 bis – Les quatre types de besoins selon Bradshaw (1972), illustrés par le fil rouge

Comprendre le schéma – Figure 1.11 bis

1. **En bleu, le besoin normatif** : un expert le définit en comparant une situation à une **norme** (recommandation, moyenne départementale, repère du PNNS).

2. **En vert, le besoin ressenti** : c'est la population qui le **perçoit**, même si elle ne le dit pas spontanément ; on le fait émerger par des entretiens ou des groupes de parole.
3. **En orange, le besoin exprimé** : c'est un besoin ressenti devenu **demande** (inscriptions, réponses à un questionnaire, demandes au guichet).
4. **En violet, le besoin comparatif** : on le déduit en comparant avec un groupe semblable qui bénéficie déjà d'un service.
5. Un besoin est d'autant plus **prioritaire** qu'il apparaît dans plusieurs cases à la fois.

Erreur fréquente – Attribuer les besoins ressentis aux professionnels

Les besoins **ressentis** sont ceux de la **population**. Ce que constatent ou estiment les professionnels (animatrice, infirmière, PMI) relève du besoin **normatif**, ou de l'**observation**. Écrire « besoins ressentis par les professionnels » est une erreur relevée par les jurys.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.5 bis – Classer des besoins

Pour un projet dans une résidence autonomie (78 résidents), classez chaque information selon Bradshaw.

a) Le médecin coordonnateur note que 17 résidents ont perdu plus de 5 % de leur poids en un mois.

b) Au conseil de la vie sociale, 12 résidents demandent des repas plus variés le soir.

c) Lors d'un entretien, une résidente confie qu'elle « n'a plus envie de cuisiner pour elle seule ».

d) La résidence voisine propose un repas partagé hebdomadaire ; celle-ci non.

Calculez la part de résidents concernés en a) et en b).

Corrigé – Exercice 1.5 bis

a) **Normatif** : la norme est le critère de dénutrition (perte de poids d'au moins 5 % en un mois, HAS 2021). Part : 17 / 78 × 100 = **21,8 %**.

b) **Exprimé** : demande formulée dans une instance. Part : 12 / 78 × 100 = **15,4 %**.

c) **Ressenti** : la résidente perçoit une difficulté sans en faire une demande.

d) **Comparatif** : comparaison avec une structure semblable.

Conclusion : la dénutrition et la convivialité des repas apparaissent dans plusieurs types de besoins ; ce sont des priorités solides pour le projet.

Étape 1 – Analyse de situation et diagnostic (fiche F1)

Pendant la période 1, Inès rassemble plusieurs types de données : les **données objectives** (statistiques du territoire), les **besoins exprimés** par les habitants (leurs demandes), les **besoins ressentis** qu'elle fait émerger dans un groupe de parole, et les **besoins normatifs** repérés par les professionnels au regard des normes (typologie de Bradshaw), auxquels s'ajoutent les **besoins observés** (ce qu'elle constate elle-même).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F1 – Diagnostic de situation (extrait rempli)

Rubrique	Données recueillies	Source
Territoire	Valmont, 38 000 habitants ; QPV des Tilleuls : 4 200 habitants ; 32 % de moins de 18 ans (21 % dans la commune)	Insee, recensement ; sig.ville.gouv.fr (données fictives)

Rubrique	Données recueillies	Source
Situation sociale	Taux de pauvreté 41 % (15 % dans la commune) ; 28 % de familles monoparentales ; taux de chômage 24 %	Insee, Filosofi ; contrat de ville (données fictives)
Santé	14 % d'enfants en surpoids (obésité comprise) lors du bilan de grande section dans les 2 écoles du quartier (9 % en moyenne dans le département)	Service de santé scolaire, bilan 2026 (fictif)
Offre alimentaire	1 supérette, 3 restaurants rapides, 1 boulangerie ; marché le samedi en centre-ville (2,5 km, bus toutes les 30 min)	Observation, repérage à pied
Ressources	Centre social avec cuisine pédagogique ; épicerie solidaire (85 familles inscrites) ; jardin partagé (8 parcelles) ; PMI ; maison de santé ; 2 écoles élémentaires	Entretiens, sites internet
Politiques	PNNS 5 (2026-2030) ; PRS de la région (priorité : nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont 2024- 2028, fiche-action « Bien manger dans les quartiers » ; PAT de l'agglomération	Sites ARS, ministère, agglomération
Besoins exprimés (habitants)	Questionnaire à 48 parents (sortie d'école) + groupe de parole de 8 parents : 71 % (34/48) pensent que « manger équilibré coûte cher » ; 58 % (28/48) « ne savent pas cuisiner les légumes secs » ; 63 % (30/48) disent que leurs enfants refusent les légumes ; 54 % (26/48) souhaitent des ateliers cuisine	Enquête d'Inès, juin 2027
Besoins normatifs (repérés par les professionnels)	Animatrice : goûters industriels et sodas fréquents ; épicerie : les légumes secs et les légumes frais restent en rayon ; PMI : allaitement court, diversification précoce	Entretiens semi-directifs (3)
Besoins observés	27 % (13/48) des familles consomment des légumes secs au moins 2 fois par semaine ; 46 % (22/48) déclarent que leurs enfants boivent une boisson sucrée tous les jours	Questionnaire, observation des goûters

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 – Calculer et interpréter des pourcentages du diagnostic

Vérifiez les pourcentages de la fiche F1 (arrondis à l'unité) et calculez combien de familles inscrites à l'épicerie solidaire (85) on peut estimer intéressées par des ateliers cuisine si la proportion observée chez les 48 parents s'applique.

Corrigé

Formule : pourcentage = effectif / effectif total × 100.

- 34 / 48 × 100 = 70,8 % ≈ **71 %** ; 28 / 48 × 100 = 58,3 % ≈ **58 %** ; 30 / 48 × 100 = 62,5 % ≈ **63 %** ; 26 / 48 × 100 = 54,2 % ≈ **54 %** ; 13 / 48 × 100 = 27,1 % ≈ **27 %** ; 22 / 48 × 100 = 45,8 % ≈ **46 %**.
- **Estimation** : 85 × 0,542 = 46,1, soit environ **46 familles** potentiellement intéressées.
- **Interprétation et limite** : cette extrapolation suppose que les parents interrogés à la sortie de l'école ressemblent aux familles de l'épicerie, ce qui n'est pas certain (**biais de sélection**, chapitre 16) ; il s'agit d'un ordre de grandeur pour dimensionner l'action (un cycle de 12 familles est réaliste, avec une liste d'attente).

Étape 2 – Problème central, causes et conséquences (fiche F2)

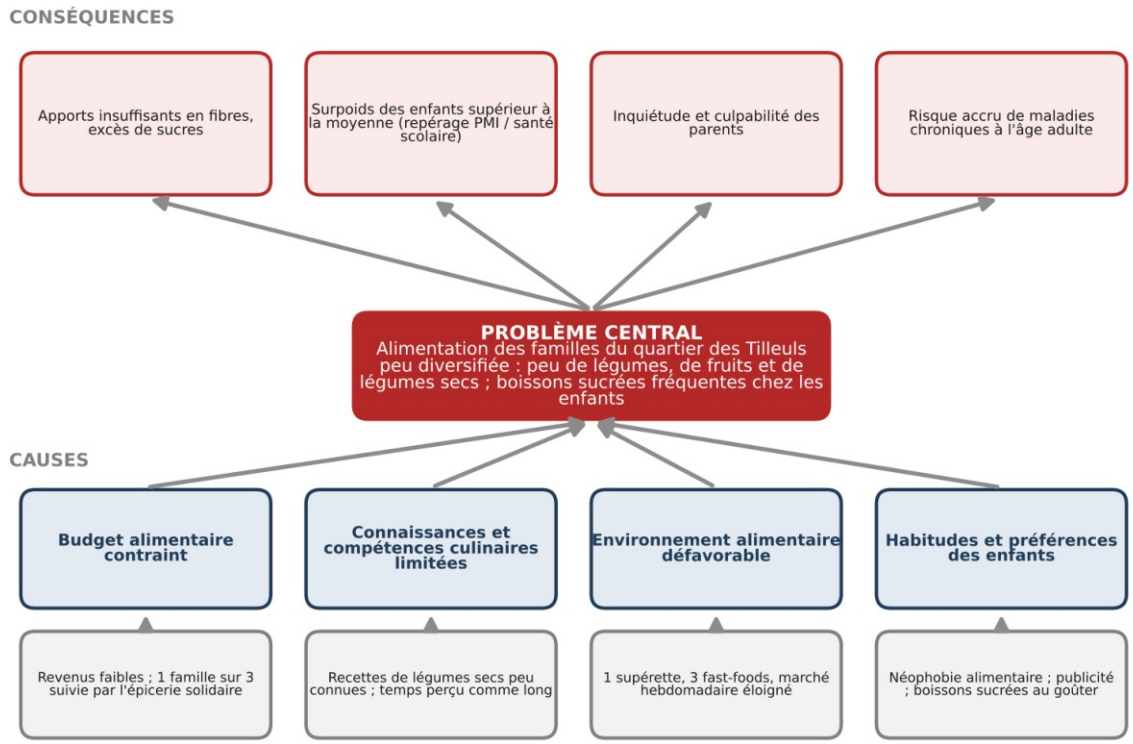


Figure 1.12 – Arbre à problèmes du projet fil rouge (fiche F2)

Comprendre le schéma – Figure 1.12

1. Au centre, le **problème central**, formulé comme une situation négative observable : une alimentation des familles peu diversifiée (peu de légumes, de fruits et de légumes secs, boissons sucrées fréquentes chez les enfants).
2. En bas, les **causes** (racines) : budget contraint, connaissances et compétences culinaires limitées, environnement alimentaire défavorable, habitudes et préférences des enfants ; chaque cause est précisée par un fait issu du diagnostic (encadrés gris).
3. En haut, les **conséquences** (branches) : apports insuffisants en fibres et excès de sucres, surpoids des enfants supérieur à la moyenne, inquiétude des parents, risque de maladies chroniques.
4. Les flèches indiquent la **relation de cause à effet**. L'arbre permet de choisir **sur quelles causes agir** : le centre social peut agir sur les compétences, les habitudes et en partie sur l'accès (partenariat avec l'épicerie), mais pas directement sur les revenus (il peut en revanche **plaider** auprès de la commune).

Étape 3 – Priorités et objectifs (fiche F3)

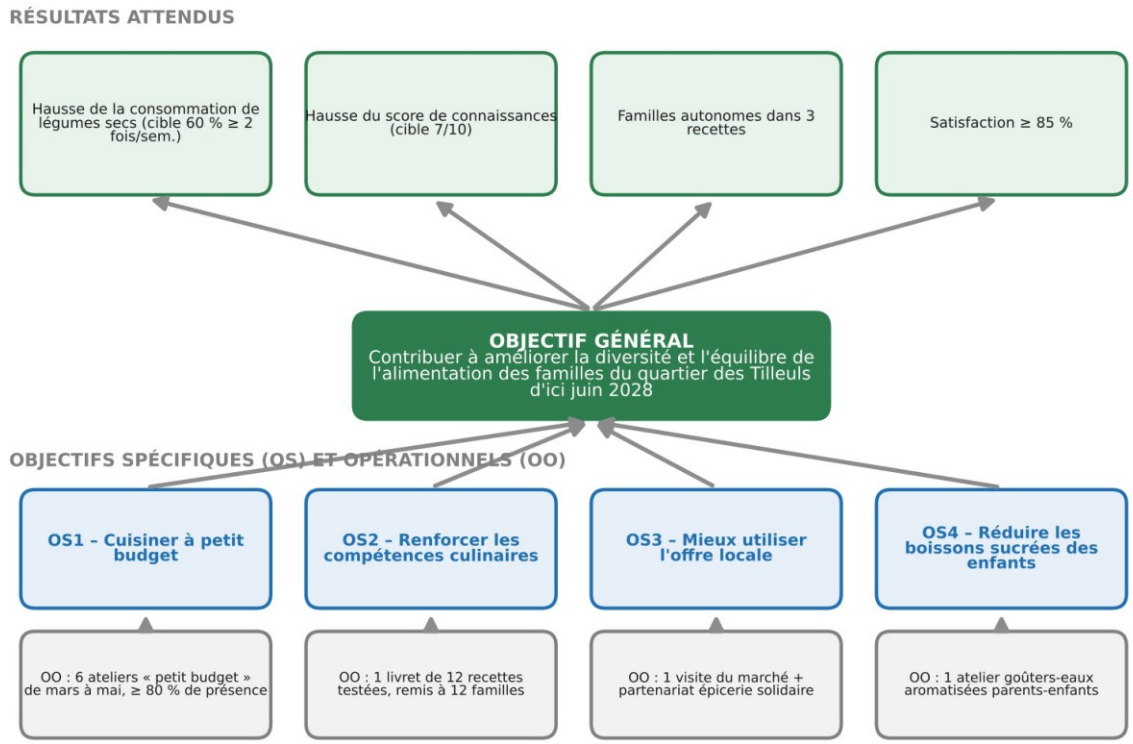


Figure 1.13 – Arbre à objectifs du projet fil rouge (fiche F3)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F3 – Objectifs SMART (extrait rempli)

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif général	Contribuer à améliorer la diversité et l'équilibre de l'alimentation des familles du quartier des Tilleuls d'ici juin 2028	(à long terme, non mesuré par le seul projet)
Objectif spécifique 1	D'ici fin mai 2028, au moins 60 % des familles participantes déclarent consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine (contre 25 % au début du cycle)	% de familles (questionnaire avant/après)
Objectif spécifique 2	À la fin du cycle, le score moyen de connaissances des participants sur l'alimentation à petit budget atteint au moins 7/10	Score moyen au questionnaire
Objectif spécifique 3	D'ici fin mai 2028, les familles participantes savent repérer et utiliser l'offre locale à petit prix (marché, épicerie solidaire)	Participation à la visite ; achats déclarés
Objectif spécifique 4	D'ici fin mai 2028, les familles participantes proposent moins souvent une boisson sucrée au goûter	Fréquence déclarée
Objectif opérationnel	Animer 6 ateliers culinaires de 3 heures, de mars à mai 2028, pour 12 familles, avec un taux de présence d'au moins 80 %	Nombre d'ateliers ; présences / 72

Niveau	Formulation	Indicateur
Objectif opérationnel	Réaliser un livret de 12 recettes testées pendant les ateliers et le remettre aux 12 familles le 27 mai 2028	Livret réalisé et distribué

Méthode pas à pas – Vérifier qu'un objectif est SMART

Spécifique (un seul résultat, un public précis) – **M**esurable (indicateur chiffré) – **A**tteignable (réaliste au regard des moyens) – **R**éaliste / pertinent (répond au problème identifié) – **T**emporel (échéance). Exemple de vérification pour l'objectif spécifique 1 : S = consommer des légumes secs, familles participantes ; M = au moins 60 % ; A = passer de 25 % à 60 % en 3 mois est ambitieux mais possible car 3 ateliers sur 6 portent sur les légumes secs ; R = répond à la cause « compétences culinaires » et au constat de l'épicerie ; T = fin mai 2028. La méthode complète est au chapitre 7.

Étape 4 – Conception : fiche projet, planning et budget (fiches F4, F5, F6)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F4 – Fiche projet / réponse à l'appel à projets de l'ARS (extrait rempli)

Rubrique	Contenu
Intitulé	« Bien manger, petit budget, grand plaisir »
Porteur	Centre social des Tilleuls (association loi 1901), référente : Mme Martin ; conception et animation : Inès (étudiante en BTS Diététique et nutrition) avec l'appui de Mme Benali, diététicienne
Partenaires	Épicerie solidaire « Le Panier partagé » (CCAS) : orientation des familles, produits utilisés ; écoles élémentaires (diffusion) ; PMI (orientation) ; marché de Valmont (visite) ; jardin partagé
Public	12 familles du QPV (parents et, pour l'atelier 4, enfants de 6 à 11 ans)
Inscription dans les politiques	PNNS 5 axe 2 ; PRS (nutrition des enfants en QPV) ; CLS de Valmont, fiche-action 3 ; PAT de l'agglomération
Type d'intervention	Éducation pour la santé (alimentaire, nutritionnelle, sensorielle) au service de la prévention primaire sélective ; démarche de promotion de la santé (participation des familles au choix des recettes, partenariat avec l'épicerie)
Actions	6 ateliers culinaires (mardi 9 h – 12 h) : 1) légumes secs ; 2) légumes de saison ; 3) repas complet petit budget ; 4) goûters et boissons (parents-enfants) ; 5) anti-gaspillage ; 6) recettes du monde choisies par les familles ; visite du marché ; temps fort festif avec remise du livret
Calendrier	7 mars – 27 mai 2028
Évaluation	Processus (présences, ateliers réalisés, budget) et résultats (questionnaire avant/après, consommation déclarée de légumes secs, satisfaction) – fiche F12
Budget	3 510 € (dont 450 € de contributions en nature) ; demande à l'ARS : 1 500 €

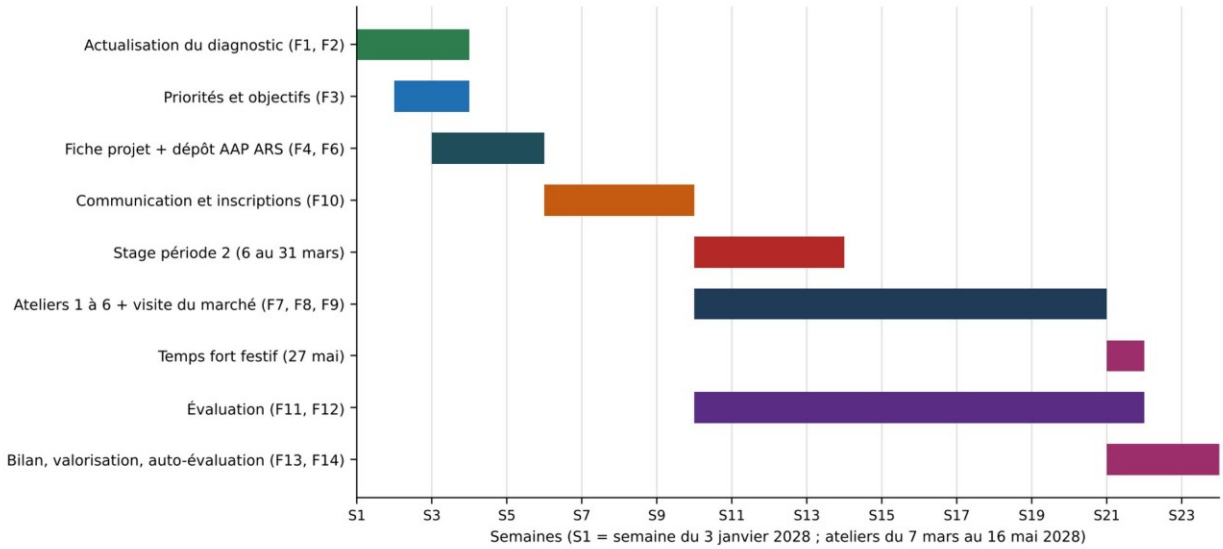


Figure 1.14 – Diagramme de Gantt du projet fil rouge (fiche F5)

Comprendre le schéma – Figure 1.14

1. Chaque barre représente une **tâche**, positionnée selon sa semaine de début et sa durée (S1 = semaine du 3 janvier 2028).
2. Les tâches de conception (diagnostic actualisé, objectifs, fiche projet et dépôt de l'appel à projets) se chevauchent en janvier et février.
3. La barre rouge montre la **période 2 du stage** (6 au 31 mars) : Inès y anime les ateliers 1 à 3 et la visite du marché ; la diététicienne et la référente familles animent les ateliers 4 à 6 en suivant les conducteurs qu'elle a rédigés, et lui transmettent les données d'évaluation.
4. L'**évaluation** court pendant tout le cycle (questionnaire avant au 1er atelier, émargements à chaque séance, questionnaire après au 6e atelier).
5. Le **temps fort festif** (27 mai) et le bilan clôturent le projet.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F5 – Feuille de temps d'Inès, période 2 (extrait)

Activité	Heures	Commentaire
Préparation des ateliers 1 à 6 (conducteurs, fiches techniques, courses)	38	Dont 6 h pour les ateliers 4 à 6 animés par l'équipe
Animation des ateliers 1 à 3 (3 × 3 h)	9	Avec la diététicienne
Visite du marché (samedi 25 mars)	4	Récupération du samedi
Communication (affiches, flyers, messages aux familles)	12	Supports validés par la tutrice
Évaluation (questionnaires, saisie, tableur)	16	Dépouillement complet à réception des questionnaires « après »
Livret de recettes	18	Maquette, relecture FALC
Réunions (tutrice, comité de pilotage, partenaires)	10	Dont 1 comité de pilotage
Rédaction du dossier et auto-évaluation	23	
Total	130	Pour 4 semaines de 35 h, soit 140 h : 10 h de temps d'observation d'autres activités du centre social

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F6 – Budget prévisionnel (calculé dans le tableur, feuille 3)

Charges	Quantité	Coût unitaire	Montant
60 – Denrées alimentaires (6 ateliers + temps fort)	7	30,00 €	210,00 €
60 – Petit matériel de cuisine (balance, ustensiles)	1	180,00 €	180,00 €
60 – Matériel et supports pédagogiques	1	150,00 €	150,00 €
62 – Impression et communication (affiches, flyers, livret)	1	220,00 €	220,00 €
62 – Déplacements (visite du marché)	1	60,00 €	60,00 €
64 – Diététicienne (heures)	40	38,00 €	1 520,00 €
64 – Coordinatrice / animatrice familles (heures)	30	24,00 €	720,00 €
86 – Mise à disposition de locaux (valorisation)	7	30,00 €	210,00 €
86 – Bénévolat (valorisation, heures)	20	12,00 €	240,00 €
Total des charges			3 510,00 €

Produits	Montant
74 – Subvention ARS (appel à projets prévention)	1 500,00 €
74 – Commune / CCAS (contrat de ville)	600,00 €
74 – CAF (animation collective familles)	400,00 €
75 – Participation des familles (2 € × 12 familles × 6 ateliers)	144,00 €
Autofinancement du centre social	416,00 €
87 – Contributions volontaires en nature	450,00 €
Total des produits	3 510,00 €

Corrigé – Les calculs du budget, pas à pas

Étape 1 – Charges : chaque ligne = quantité × coût unitaire ; par exemple, diététicienne : 40 h × 38 € = 1 520 €. Somme : 210 + 180 + 150 + 220 + 60 + 1 520 + 720 + 210 + 240 = **3 510 €**. **Étape 2 – Participation des familles** : 2 € × 12 familles × 6 ateliers = **144 €**. **Étape 3 – Contributions en nature** (comptes 86 et 87, qui doivent être égaux) : 210 + 240 = **450 €**. **Étape 4 – Autofinancement** (montant qui équilibre le budget) : 3 510 − (1 500 + 600 + 400 + 144 + 450) = 3 510 − 3 094 = **416 €**. **Étape 5 – Indicateurs** : part de la subvention ARS dans les produits = 1 500 / 3 510 = 0,427, soit **42,7 %** ; part des financements publics (ARS + commune + CAF) = 2 500 / 3 510 = **71,2 %** ; coût par famille = 3 510 / 12 = **292,50 €** ; part du personnel = (1 520 + 720) / 3 510 = **63,8 %**. **Interprétation** : un budget prévisionnel doit être **équilibré** (total des charges = total des produits) ; un financeur ne finance jamais 100 % d'un projet, d'où la diversité des financeurs ; le poste principal est le **temps humain**, ce qui est habituel en éducation pour la santé.

Étape 5 – Mise en œuvre : l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget » (fiches F7, F8, F9)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F7 – Conducteur de séance, atelier n° 3 (mardi 28 mars 2028, 9 h – 12 h)

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
8 h 30 – 9 h	Installation	Plan de travail, ingrédients pesés par recette, affichage des fiches recettes, tenues, désinfection des surfaces	Fiche technique F8	Inès, Mme Benali

Horaire	Étape et objectif	Contenu et déroulement	Méthode, outils	Qui
9 h – 9 h 15	Accueil, émargement	Café, émargement, rappel des règles (hygiène, tablier, cheveux attachés, lavage des mains), présentation du menu	Tour de table « une couleur pour votre humeur »	Inès
9 h 15 – 9 h 35	Représentations	« Pour vous, un repas équilibré à petit prix, c'est… » ; classement de 10 cartes- aliments par prix au kilo puis par prix par portion	Photo-expression, cartes-aliments	Inès
9 h 35 – 11 h 05	Réalisation culinaire	3 groupes de 3-4 personnes : salade de chou-carottes ; parmentier de lentilles corail ; crumble pommes-avoine ; consignes de sécurité (couteaux, four) ; tri des déchets	Fiches recettes illustrées (pictogrammes)	Inès + Mme Benali (1 animatrice pour 2 groupes)
11 h 05 – 11 h 35	Dégustation et analyse sensorielle	Repas partagé ; grille de dégustation (échelle de 1 à 5) ; échanges sur les goûts des enfants	Grille F9	Inès
11 h 35 – 11 h 50	Synthèse	Calcul collectif du coût par personne (1,38 €) ; 3 astuces à retenir ; recette à refaire à la maison	Tableau papier	Inès
11 h 50 – 12 h	Évaluation et clôture	Évaluation « météo » (soleil, nuage, pluie) + 1 mot ; distribution des fiches recettes ; restes partagés dans des boîtes apportées par les familles	Émargement, boîtes	Mme Benali
12 h – 12 h 30	Rangement, bilan à chaud	Vaisselle, nettoyage, tri ; bilan entre animatrices (ce qui a marché, ce qui est à améliorer)	Fiche bilan	Toutes

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 – Fiche technique de l'atelier : mise à l'échelle et coût (calculés dans

le tableur, feuille 1) Recettes de base pour 4 portions, préparées pour **12 portions** (10 participants + 2 animatrices). **Coefficient** = portions visées / portions de base = 12 / 4 = **3**.

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Salade chou-carottes					
Chou blanc	200 g	600 g	1,60 €/kg	0,96 €	saison, local
Carottes	150 g	450 g	1,40 €/kg	0,63 €	saison, local
Huile de colza	15 g	45 g	3,50 €/L	0,16 €	
Vinaigre de cidre	10 g	30 g	2,00 €/L	0,06 €	
Moutarde	5 g	15 g	4,00 €/kg	0,06 €	allergène
Parmentier de lentilles					

Ingrédient	Base (4 p.)	Pour 12 p.	Prix	Coût	Qualité
Lentilles corail sèches	160 g	480 g	3,20 €/kg	1,54 €	
Carottes	300 g	900 g	1,40 €/kg	1,26 €	saison, local
Oignon	100 g	300 g	1,80 €/kg	0,54 €	saison, local
Pommes de terre	600 g	1 800 g	1,30 €/kg	2,34 €	saison, local
Lait demi-écrémé	150 mL	450 mL	1,05 €/L	0,47 €	allergène (lait)
Huile de colza	20 g	60 g	3,50 €/L	0,21 €	
Emmental râpé	40 g	120 g	9,90 €/kg	1,19 €	allergène (lait)
Concentré de tomate	30 g	90 g	4,00 €/kg	0,36 €	
Épices (cumin, paprika)	4 g	12 g	25,00 €/kg	0,30 €	
Crumble pommes-avoine					
Pommes	500 g	1 500 g	2,90 €/kg	4,35 €	saison, local, bio
Flocons d'avoine	60 g	180 g	2,50 €/kg	0,45 €	allergène (gluten)
Farine de blé T65	40 g	120 g	1,60 €/kg	0,19 €	Label Rouge ; gluten
Beurre doux	40 g	120 g	10,00 €/kg	1,20 €	allergène (lait)
Sucre roux	30 g	90 g	1,20 €/kg	0,11 €	
Cannelle	2 g	6 g	30,00 €/kg	0,18 €	

Corrigé – Les calculs de la fiche technique, pas à pas

Étape 1 – Quantité à prévoir = quantité de base × coefficient. Exemple : lentilles corail : 160 g × 3 = **480 g**. **Étape 2 – Coût d'un ingrédient** = quantité (g) / 1 000 × prix (€/kg). Exemple : 480 / 1 000 × 3,20 = **1,536 €** ≈ 1,54 €. **Étape 3 – Coût de chaque recette** (somme des ingrédients, valeurs non arrondies) : salade = 0,96 + 0,63 + 0,1575 + 0,06 + 0,06 = **1,87 €** ; parmentier = 1,536 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 0,4725 + 0,21 + 1,188 + 0,36 + 0,30 = **8,21** € ; crumble = 4,35 + 0,45 + 0,192 + 1,20 + 0,108 + 0,18 = **6,48 €**. **Étape 4 – Coût par portion** = coût de la recette / 12 : salade 1,8675 / 12 = **0,16 €** ; parmentier 8,2065 / 12 = **0,68** € ; crumble 6,48 / 12 = **0,54 €**. **Étape 5 – Coût du repas complet** : 1,8675 + 8,2065 + 6,48 = **16,55 €** pour 12 personnes, soit 16,554 / 12 = **1,38 € par personne**. **Étape 6 – Part des produits de qualité (en valeur)** : produits de saison = 0,96 + 0,63 + 1,26 + 0,54 + 2,34 + 4,35 = 10,08 € ; 10,08 / 16,554 = **60,9 %** (les mêmes produits sont locaux : 60,9 %) ; bio = 4,35 / 16,554 = **26,3 %** ; produits « durables et de qualité » au sens EGalim (bio ou Label Rouge) = (4,35 + 0,192) / 16,554 = **27,4 %**. **Interprétation** : un repas complet, fait maison, coûte **1,38 € par personne en denrées**, ce qui répond directement à la représentation « manger équilibré coûte cher » ; les pommes bio représentent à elles seules 26 % du coût : le choix du bio est possible sur un produit de saison. Si on utilisait le repère EGalim de la restauration collective (50 %), il manquerait 22,6 points : ce repère n'est pas obligatoire pour un atelier, mais il sert de **point de comparaison** pédagogique.

Lien diététique – Lien BPADN : la valeur nutritionnelle d'une portion de parmentier

Une portion contient 40 g de lentilles corail crues, 150 g de pommes de terre, 75 g de carottes, 37,5 mL de lait et 10 g d'emmental. Avec les teneurs en protéines de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) : lentille corail sèche 27,7 g/100 g ; pomme de terre crue sans peau 2,02 g ; carotte crue 0,78 g ; lait demi-écrémé UHT 3,48 g ; emmental râpé 27,6 g. Calcul : 40 × 27,7 / 100 = 11,08 g ; 150 × 2,02 / 100 = 3,03 g ; 75 × 0,78 / 100 = 0,59 g ; 37,5 × 3,48 / 100 = 1,31 g ; 10 × 27,6 / 100 = 2,76 g ; **total ≈ 18,8 g de protéines**, dont (11,08 + 3,03 + 0,59) / 18,77 = 78,3 % d'origine végétale. L'association **légumineuse + produit laitier + féculent** améliore la complémentarité des acides aminés (lysine des légumineuses, acides aminés soufrés des céréales et du lait) : c'est un plat complet adapté au repère « légumes secs au moins 2 fois par semaine ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F8 (suite) – Hygiène, sécurité, éco-gestes et allergènes

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et entre chaque manipulation ; tablier, cheveux attachés ; légumes lavés ; lentilles rincées ; plat cuit servi immédiatement (ou maintenu au-dessus de 63 °C) ; restes refroidis rapidement et conservés au froid (0 à 4 °C) dans des boîtes fermées, à consommer sous 24 heures ; un plat témoin n'est pas obligatoire en atelier familial mais on note les lots des produits utilisés.
- **Sécurité** : couteaux posés à plat, planche stabilisée par un torchon humide, poignées de casseroles tournées vers l'intérieur, gants de cuisine pour le four ; enfants (atelier 4) jamais seuls près des plaques.
- **Éco-gestes** : légumes de saison et locaux ; épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé ; eau de cuisson des lentilles réutilisée pour la purée ; four rempli (crumble et parmentier cuits ensemble) ; produits en vrac (lentilles, flocons) ; restes emportés dans des boîtes réutilisables ; pas de vaisselle jetable.
- **Allergènes à déclarer** (14 allergènes du règlement INCO n° 1169/2011) : **lait** (lait, emmental, beurre), **gluten** (farine de blé, flocons d'avoine), **moutarde** ; **sulfites** possibles dans le vinaigre (vérifier l'étiquette). Recueil des allergies à l'inscription (fiche participant) ; variante sans lait (huile d'olive et lait végétal enrichi) prévue.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F9 – Grille de dégustation : résultats de l'atelier n° 3 (10 participants)

Échelle hédonique de 1 (« je n'aime pas du tout ») à 5 (« j'aime beaucoup »).

Préparation	Notes des 10 participants	Moyenne
Salade chou-carottes	3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3	3,3
Parmentier de lentilles	5 – 4 – 4 – 5 – 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 5	4,3
Crumble pommes-avoine	5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5	4,7

Calcul : moyenne = somme des notes / nombre de notes. Salade : (3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3) / 10 = 33 / 10 = **3,3** ; parmentier : 43 / 10 = **4,3** ; crumble : 47 / 10 = **4,7**. **Interprétation** : le plat à base de légumes secs est très bien accepté (4,3/5), ce qui est encourageant pour l'objectif spécifique 1 ; la salade de chou est moins appréciée (« trop acide », « chou trop dur ») : ajustement décidé pour le livret : chou émincé très finement et mariné 15 minutes, ajout de pomme râpée et de raisins secs.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F10 – Plan de communication (extrait)

Objectif	Cible	Message	Support et canal	Calendrier
Faire connaître et recruter	Familles du quartier	« Cuisinez bon et pas cher, venez avec nous ! »	Affiches A3 (écoles, épicerie, PMI, centre social) ; flyers illustrés traduits en arabe et en turc ; message sur le groupe de messagerie des parents du centre social	Février 2028
Mobiliser les partenaires	Épicerie, écoles, PMI	Présentation du projet et du rôle de chacun	Mail + réunion de présentation (diaporama de 8 diapositives)	Janvier 2028
Informer les financeurs	ARS, commune, CAF	Avancement et résultats	Fiche projet, bilan intermédiaire, bilan final	Février, avril, juin 2028
Valoriser	Habitants, élus, professionnels	« 12 familles, 12 recettes à moins de 1,50 € par personne »	Livret de recettes (FALC, pictogrammes), article dans le journal municipal, poster au forum santé	Mai-juin 2028

Points de vigilance : littératie (phrases courtes, pictogrammes, police lisible ≥ 12 pt, chapitre 5) ; **précarité numérique** (ne pas compter uniquement sur le numérique) ; **droit à l'image** et **RGPD** (autorisation écrite pour toute photo, pas de nom de famille dans le livret, données d'inscription conservées au centre social et détruites à la fin du projet).

Étape 6 – Évaluation (fiches F11 et F12)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F11 – Questionnaire d'évaluation et dépouillement (calculés dans le

tableur, feuille 5) Le même questionnaire de 10 questions de connaissances (une réponse juste = 1 point) a été rempli au 1er atelier (« avant ») et au 6e atelier (« après ») par les **12** participants, identifiés par un **code anonyme** (P01 à P12). Exemples de questions : « Combien de fois par semaine est-il conseillé de manger des légumes secs ? » ; « Quel est le prix au kilo des lentilles par rapport à celui de la viande hachée ? » ; « Citez deux légumes de saison en mars ».

Statistique	Score avant (/10)	Score après (/10)	Progression
Effectif	12	12	12
Moyenne	4,75	7,17	+ 2,42
Médiane	5	7	2
Écart-type	1,22	0,94	0,51
Minimum – maximum	3 – 7	6 – 9	2 – 3

Corrigé – Le dépouillement, pas à pas

Scores avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5. Scores après : 7, 8, 6, 8, 7, 6, 9, 7, 6, 8, 7, 7. **Étape 1 – Moyenne** = somme / effectif. Avant : 57 / 12 = **4,75** ; après : 86 / 12 = **7,17** ; progression moyenne : 7,17 − 4,75 = **+ 2,42 points**. **Étape 2 – Médiane** (valeur qui partage la série ordonnée en deux moitiés ; avec 12 valeurs, moyenne de la 6e et de la 7e). Avant, série ordonnée : 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 → (5 + 5) / 2 = **5**. Après : 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7**. **Étape 3 – Écart-type** (dispersion autour de la moyenne ; formule de l'échantillon : $s = \sqrt{[\ (x - \text{moyenne})^2 / \Sigma\ (n - 1)]}$). Avant : $(x - 4{,}75)^2 = 16{,}25$; 16,25 / 11 = 1,477 ; √1,477 = **1,22**. Après : $(x - 7{,}17)^2 = 9{,}67$; 9,67 / 11 = Σ Σ 0,879 ; √0,879 = **0,94**. **Étape 4 – Proportions** : participants ayant progressé = 12 / 12 = **100 %** ; score après ≥ 7 = 9 / 12 = **75 %** ; légumes secs au moins 2 fois par semaine : avant 3 / 12 = **25 %**, après 9 / 12 = **75 %**, soit **+ 50 points** ; satisfaits ou très satisfaits = (7 + 4) / 12 = **91,7 %** ; note moyenne de satisfaction = 42 / 12 = **3,50 / 4**. **Interprétation** : les connaissances progressent pour tous les participants et deviennent plus homogènes (l'écart-type diminue de 1,22 à 0,94) ; l'objectif « score moyen ≥ 7/10 » est atteint (7,17). Limites : petit effectif, données **déclaratives**, pas de groupe témoin, mesure à court terme : on ne peut pas conclure à un changement durable des comportements (chapitre 9).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F12 – Tableau de bord d'évaluation (calculé dans le tableur, feuille 6)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Processus	Ateliers réalisés	6	6	100 %	Atteint
Processus	Familles inscrites	12	12	100 %	Atteint
Processus	Présences cumulées (11 + 10 + 10 + 9 + 8 + 10)	72	58	80,6 %	Partiellement atteint
Processus	Taux moyen de participation	80 %	80,6 %	100,7 %	Atteint
Processus	Dépenses monétaires (hors contributions en nature)	3 060 €	3 092,90 €	101,1 %	Léger dépassement (+ 32,90 €, chapitre 8)

Type	Indicateur	Prévu	Réalisé	Taux d'atteinte	Statut
Résultat	Score moyen de connaissances après le cycle	7,0	7,17	102,4 %	Atteint
Résultat	Participants ayant progressé	75 %	100 %	133,3 %	Atteint
Résultat	Légumes secs au moins 2 fois par semaine	60 %	75 %	125,0 %	Atteint
Résultat	Participants satisfaits	85 %	91,7 %	107,8 %	Atteint

Calcul du taux d'atteinte = réalisé / prévu × 100. Exemple : présences : 58 / 72 × 100 = **80,6 %** ; ce taux est inférieur à 100 % pour l'indicateur « présences cumulées » (statut « partiellement atteint »), mais il dépasse la cible de 80 % fixée pour le taux de participation : les deux lectures sont cohérentes.

Étape 7 – Valorisation, veille et auto-évaluation (fiches F13 et F14)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F13 – Fiche de veille (exemple rempli)

Rubrique	Contenu
Date de la veille	15 avril 2026 (mise à jour le 26 octobre 2026)
Besoin	Vérifier le programme national de nutrition en vigueur pour la partie « contexte » de la fiche projet
Source	Ministère chargé de la Santé ; Réseau national nutrition santé ; mangerbouger.fr ; ecologie.gouv.fr (SNANC)
Type de source	Institutionnelle nationale (fiabilité élevée)
Information retenue	SNANC 2025-2030 publiée le 11/02/2026 ; PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés le 08/04/2026 ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, objectif de − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants
Conséquence pour le projet	Remplacer toutes les références au « PNNS 4 » par le PNNS 5 ; rattacher le projet à l'axe 2 ; citer l'objectif de réduction des inégalités
Diffusion	Note de 5 lignes envoyée à la tutrice et à la diététicienne ; enregistrée dans la base documentaire partagée (dossier « Politiques nutritionnelles »)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Fiche F14 – Check-list d'auto-évaluation d'Inès (extrait)

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Diagnostic posé à partir de données variées et sourcées	3	Données objectives et besoins exprimés solides ; données de santé locales limitées (une seule source)
Objectifs SMART cohérents avec le diagnostic	4	Chaque objectif renvoie à une cause de l'arbre à problèmes
Plan d'action et budget réalistes	3	Budget équilibré ; temps de préparation sous-estimé (38 h au lieu de 25 h prévues)
Communication adaptée au public	3	Flyers traduits appréciés ; message numérique peu efficace pour 3 familles
Évaluation construite et réalisée	3	Questionnaire avant/après exploité ; pas de mesure à distance (prévoir un appel à 3 mois)
Règles éthiques, RGPD, droit à l'image	4	Autorisations écrites, codes anonymes
Posture, écoute active, animation	3	À améliorer : gestion du temps de parole d'un participant très présent

Critère (indicateurs du référentiel)	Auto- évaluation (1 à 4)	Justification, ajustement
Ajustements proposés	—	Salade modifiée ; atelier 4 déplacé le mercredi pour les enfants ; rappel SMS la veille

À retenir – Ce que montre le fil rouge

- Un projet de santé publique part d'un **diagnostic** (données + besoins normatifs, exprimés, ressentis, observés), pas d'une idée du professionnel.
- Il **s'inscrit** dans les politiques en vigueur (PNNS 5, PRS, CLS) et mobilise des **partenaires**.
- Il combine plusieurs **modes d'intervention** (éducation pour la santé au service de la prévention sélective, démarche de promotion de la santé).
- Il est **évalué** avec des indicateurs de processus et de résultats, et ses limites sont reconnues.
- Toutes les fiches F1 à F14 sont **cohérentes entre elles** : c'est ce que le jury de l'épreuve E5 vérifie dans le dossier.

1.4 Approfondissements

1.4.1 Les données probantes en promotion de la santé

Une **donnée probante** est une information issue de la recherche ou de l'évaluation qui montre qu'une intervention est **efficace** (ou non) dans un contexte donné. En promotion de la santé, on combine trois sources : les **résultats de la recherche**, l'**expérience des professionnels** et les **savoirs des personnes concernées**. Santé publique France tient un **registre des interventions probantes ou prometteuses** en prévention et promotion de la santé (par exemple, des programmes de développement des compétences psychosociales à l'école, ou des programmes d'activité physique et de nutrition). Avant de concevoir un projet, il est recommandé de vérifier s'il existe une intervention déjà évaluée que l'on peut **adapter** (transférabilité) plutôt que de tout inventer.

Exemple – Ce que l'on sait de l'efficacité des actions en nutrition

- Les actions **multi-composantes** (éducation + modification de l'environnement + implication des familles) sont plus efficaces que l'information seule.
- Les actions sur l'**environnement** (offre scolaire, prix, étiquetage, reformulation) touchent toute la population et réduisent davantage les inégalités que l'éducation seule.
- Les ateliers culinaires améliorent les **compétences** et la **confiance** en cuisine et, à court terme, certains comportements déclarés (fruits et légumes) ; leurs effets à long terme sont moins documentés, d'où l'importance d'une évaluation bien construite.

Méthode – Trouver et utiliser une intervention probante

Étape 1 – Chercher : consulter le **registre des interventions probantes ou prometteuses** de Santé publique France, les fiches de la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé et des structures régionales, les synthèses de l'OMS Europe.

Étape 2 – Vérifier : l'intervention a-t-elle été **évaluée** ? Sur quel public, dans quel pays, avec quels résultats ? Les résultats portent-ils sur des **comportements** ou seulement sur des connaissances ?

Étape 3 – Juger la transférabilité : mon public, mon territoire et mes moyens ressemblent-ils à ceux de l'intervention d'origine ? Qu'est-ce qui doit être **adapté** (langue, recettes, horaires) et qu'est-ce qui doit être **gardé** (les « fonctions clés » qui expliquent l'efficacité) ?

Étape 4 – Citer : dans le dossier E5, nommer l'intervention, sa source et sa date ; expliquer en une phrase ce que vous avez adapté.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 bis – Juger une action

Une mairie veut lutter contre le surpoids des enfants. Trois propositions sont faites : A) distribuer un dépliant sur l'équilibre alimentaire à toutes les familles ; B) un programme d'un an associant ateliers culinaires parents-enfants, modification des goûters servis au périscolaire et fontaines à eau dans les écoles ; C) une pesée des enfants en classe avec un courrier aux familles des enfants en surpoids.

1. Classez les propositions de la plus probablement efficace à la moins efficace, en justifiant avec les données probantes.
2. Quelle proposition pose un problème éthique ? Pourquoi ?

Corrigé – Exercice 1.6 bis

1. **B** d'abord : action **multi-composantes** (éducation + environnement + familles), qui touche tous les enfants. Ensuite **A** : l'information seule a peu d'effet sur les comportements et touche surtout les familles déjà sensibilisées (risque d'accroître les inégalités). **C** en dernier : un repérage sans proposition d'accompagnement n'est pas une intervention efficace.
2. **C** : la pesée en classe et le courrier ciblé exposent les enfants à la **stigmatisation** (section 1.4.4) ; le repérage doit se faire dans un cadre médical confidentiel (santé scolaire, médecin traitant), avec une orientation vers une prise en charge.

1.4.2 Les théories du changement de comportement : premier aperçu

Pour comprendre pourquoi « savoir » ne suffit pas, on utilise des modèles qui seront détaillés au chapitre 3 :

- **Modèle des croyances relatives à la santé** (*Health Belief Model*, Rosenstock, années 1950-1970) : une personne adopte un comportement si elle se sent **vulnérable**, si elle perçoit la **gravité** du problème, si elle juge les **bénéfices** supérieurs aux **obstacles**, avec un **déclencheur** à l'action et un sentiment d'**auto-efficacité**.
- **Modèle transthéorique des étapes du changement** (Prochaska et DiClemente, 1983) : précontemplation, contemplation, préparation, action, maintien (et rechute possible). L'action éducative s'adapte à l'étape de la personne.
- **Théorie sociale cognitive** (Bandura, 1977-1986) : le **sentiment d'efficacité personnelle** (« je suis capable de cuisiner des lentilles ») est un levier central ; il se développe par l'expérience réussie (d'où l'intérêt de **faire** en atelier), l'observation de pairs, l'encouragement.

Lien diététique – Dans le fil rouge

Faire cuisiner les familles elles-mêmes (et non leur faire une démonstration) développe l'**auto-efficacité** ; la dégustation partagée et le choix des recettes par le groupe mobilisent l'**influence sociale** positive ; le coût par portion calculé ensemble lève un **obstacle perçu** (« c'est cher »).

1.4.3 Le débat sur les aliments ultra-transformés

La classification **NOVA** (Carlos Monteiro, université de São Paulo, 2009) classe les aliments selon leur **degré de transformation** en quatre groupes : 1) aliments non ou peu transformés ; 2) ingrédients culinaires transformés (huile, sucre, sel) ; 3) aliments transformés (conserves, fromages, pain artisanal) ; 4) **aliments ultra- transformés** (formulations industrielles contenant des ingrédients peu ou pas utilisés en cuisine domestique : additifs cosmétiques, isolats de protéines, sirops…). De nombreuses études d'observation, dont la cohorte NutriNet-

Santé, associent une forte consommation d'ultra-transformés à un risque accru d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de mortalité. Les repères de 2019 recommandent de les **limiter**. Le débat porte sur la **définition** (NOVA est critiquée pour son manque de précision), sur la **causalité** (études observationnelles) et sur l'articulation avec le Nutri-Score (qui mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation). Le PNNS 5 reconnaît l'enjeu et confie à l'ANSES l'élaboration d'une définition opérationnelle.

Outil	Ce qu'il mesure	Ce qu'il ne mesure pas	Exemple
Nutri-Score (A à E)	La **composition nutritionnelle** pour 100 g : énergie, sucres, graisses saturées, sel, fibres, protéines, fruits, légumes, légumineuses	Le degré de transformation, les additifs, le mode de production (bio), l'origine	Une boisson « zéro » sucre peut être bien classée tout en étant ultra-transformée
NOVA (groupes 1 à 4)	Le **degré de transformation** et les procédés industriels	La teneur en sucres, en sel ou en graisses	Une huile d'olive (groupe 2) est riche en lipides ; un pain complet artisanal (groupe 3) peut être salé
Label bio (AB, Eurofeuille)	Le **mode de production** agricole	La composition nutritionnelle	Un biscuit bio peut être très sucré

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 ter – Nutri-Score ou NOVA ?

Classez chaque aliment dans un groupe NOVA (1 à 4) : a) lentilles vertes sèches ; b) huile de colza ; c) pain de boulangerie (farine, eau, sel, levure) ; d) céréales du petit déjeuner fourrées au chocolat avec émulsifiant et arôme ; e) yaourt nature ; f) nuggets de poulet panés surgelés avec amidon modifié.

Puis expliquez en deux phrases à un groupe de parents pourquoi un produit classé A au Nutri-Score n'est pas forcément « peu transformé ».

Corrigé – Exercice 1.6 ter

a) Groupe **1** (non transformé). b) Groupe **2** (ingrédient culinaire). c) Groupe **3** (aliment transformé avec des ingrédients de cuisine). d) Groupe **4** (ultra-transformé : additifs cosmétiques). e) Groupe **1** (lait fermenté sans ajout). f) Groupe **4** (ultra-transformé : amidon modifié, procédés industriels).

Exemple d'explication : « Le Nutri-Score regarde ce que contient l'aliment : sucre, sel, gras, fibres. Il ne dit pas comment l'aliment a été fabriqué : pour choisir, regardez aussi la liste des ingrédients ; plus elle est courte et faite d'ingrédients que vous avez dans votre cuisine, mieux c'est. »

1.4.4 Promotion de la santé et non-stigmatisation du poids

La **stigmatisation du poids** (moqueries, discriminations, messages culpabilisants) est elle-même un facteur de risque : elle augmente le stress, les troubles du comportement alimentaire, l'évitement des soins et, paradoxalement, la prise de poids. Une déclaration de consensus internationale (*Nature Medicine*, 2020) appelle à l'éliminer. En pratique : parler de « personne vivant avec une obésité », éviter les images dégradantes, ne pas peser les enfants en public, centrer les actions sur la **santé** et le **plaisir** de manger plutôt que sur le poids, proposer des actions **universelles** (pour tous les enfants) plutôt que de désigner les enfants « en surpoids ».

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
« Les obèses », « les gros »	« Les personnes vivant avec une obésité »	On nomme la personne avant la maladie
« Lutter contre l'obésité des enfants » (sur une affiche destinée aux familles)	« Bien manger et bouger en famille »	Le message vise tous les enfants et ne désigne personne
« Aliments interdits », « mauvais aliments »	« Aliments à limiter », « à garder pour les moments de plaisir »	On évite la culpabilité et la moralisation

Formulations à éviter	Formulations à préférer	Pourquoi
Photo d'un corps sans tête, ventre en gros plan	Photo de personnes de corpulences variées en activité	On évite l'image dégradante
« Il faut perdre du poids »	« On peut améliorer sa santé quel que soit son poids »	On centre l'action sur la santé et le plaisir

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quater – Réécrire un message

Réécrivez ces trois phrases trouvées sur l'affiche d'une action en collège pour qu'elles ne soient pas stigmatisantes : a) « Stop à l'obésité : les sodas sont interdits ! » ; b) « Élèves en surpoids : inscrivez-vous à l'atelier sport » ; c) « Les mauvaises habitudes des familles font grossir les enfants ».

Corrigé – Exercice 1.6 quater

a) « Envie de te désaltérer ? L'eau, c'est gratuit et à volonté : découvre nos eaux aromatisées maison. » b) « Atelier sport pour tous, tous niveaux, le mardi midi : viens essayer ! » c) « Cuisiner ensemble, c'est bon pour toute la famille : découvrez nos ateliers parents-enfants. » Les trois réécritures s'adressent à **tous**, valorisent le **plaisir** et une **action positive**, et ne désignent personne.

1.4.5 Santé publique, alimentation et climat

Le système alimentaire représente environ **un quart de l'empreinte carbone** de la consommation des ménages français (ordre de grandeur cité par l'ADEME et le Haut Conseil pour le climat). Une alimentation plus **végétale**, **de saison**, **locale** quand c'est pertinent, **peu transformée** et **sans gaspillage** est généralement favorable à la fois à la santé et au climat : c'est le principe des « co-bénéfices » qui fonde la SNANC. La commission **EAT-Lancet** (2019) a proposé un « régime de santé planétaire » ; le HCSP (2025) recommande pour le PNNS 5 une diminution d'environ 50 % de la consommation de viande et une augmentation des produits végétaux. Le diététicien veille toutefois à la **couverture des besoins** (fer, vitamine B12, calcium, iode) et à l'**acceptabilité** culturelle et économique des changements.

Calcul – Diversifier les sources de protéines : combien faut-il manger pour obtenir 20 g de protéines ?

Données (table Ciqual 2025, ANSES, pour 100 g d'aliment cuit) : steak haché de bœuf 15 % MG cuit : 23,6 g de protéines, 2,6 mg de fer, 0 g de fibres, 239 kcal ; lentille verte cuite à l'eau : 10,1 g, 2,45 mg, 8,45 g, 125 kcal ; pois chiche cuit à l'eau : 8,31 g, 1,3 mg, 8,2 g, 148 kcal ; tofu nature : 13,4 g, 2,4 mg, fibres < 0,5 g (comptées 0), 147 kcal.

Étape 1 – Quantité pour 20 g de protéines = 20 / teneur × 100. Steak haché : 20 / 23,6 × 100 = **84,7 g** ; lentilles : 20 / 10,1 × 100 = **198,0 g** ; pois chiches : 20 / 8,31 × 100 = **240,7 g** ; tofu : 20 / 13,4 × 100 = **149,3 g**.

Étape 2 – Ce qu'apporte cette quantité : steak haché : 2,2 mg de fer, 0 g de fibres, 203 kcal ; lentilles : 4,9 mg de fer, 16,7 g de fibres, 248 kcal ; pois chiches : 3,1 mg de fer, 19,7 g de fibres, 356 kcal ; tofu : 3,6 mg de fer, 0 g de fibres, 219 kcal.

Interprétation : une assiette de lentilles (environ 200 g cuites) apporte autant de protéines qu'un steak haché, plus de fer et plus de la moitié des 30 g de fibres conseillés par jour. Attention : le fer des végétaux (fer non héminique) est moins bien absorbé que celui de la viande ; on améliore son absorption avec une source de vitamine C dans le repas (crudités, agrumes). C'est un exemple de **co-bénéfice** santé et climat à présenter en atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.6 quinquies – Argumenter pour un menu végétarien

Le responsable d'une cantine craint que le menu végétarien hebdomadaire « manque de protéines ». Avec les données du calcul ci-dessus, rédigez une réponse de 5 lignes qui cite deux chiffres, un point de vigilance et

une proposition de plat.

Corrigé – Exercice 1.6 quinquies (exemple de réponse)

« Selon la table Ciqual 2025, 200 g de lentilles cuites apportent environ 20 g de protéines, autant qu'un steak haché de 85 g, et en plus 16,7 g de fibres. Le menu végétarien peut donc couvrir le besoin en protéines du repas. Le point de vigilance est le fer, moins bien absorbé : on ajoute une crudité ou un agrume au menu. Je propose un dahl de lentilles corail avec du riz et une salade de carottes au citron. » Le correcteur valorise : deux chiffres sourcés, la vigilance sur le fer, une proposition concrète.

1.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'approche par les capabilités (Amartya Sen)

Pour l'économiste Amartya Sen (prix Nobel 1998), la justice sociale ne se mesure pas aux ressources possédées mais aux **capabilités** : les libertés réelles d'une personne d'être et de faire ce qu'elle valorise. Appliquée à l'alimentation, cette approche montre qu'il ne suffit pas de **savoir** ce qu'est une alimentation équilibrée ni même d'avoir un revenu : il faut aussi avoir le **temps**, l'**équipement**, l'**accès physique** aux commerces, les **compétences** et la **liberté** de choisir. Elle fonde la notion de **droit à l'alimentation** et les expérimentations de « sécurité sociale de l'alimentation » débattues en France depuis 2019.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La syndémie mondiale (Swinburn et coll., *The Lancet*, 2019)

La commission du *Lancet* sur l'obésité propose le concept de **syndémie mondiale** : l'obésité, la dénutrition et le changement climatique sont trois pandémies qui **interagissent** et partagent des **déterminants communs** (systèmes alimentaires, transports, urbanisme, utilisation des terres, intérêts commerciaux). Elle appelle à des actions « à double ou triple bénéfice » et à limiter l'influence des grandes industries sur les politiques publiques : c'est le cadre intellectuel des stratégies intégrées comme la SNANC.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Évaluer la complexité : l'évaluation réaliste

Les interventions de promotion de la santé sont **complexes** (plusieurs composantes, plusieurs acteurs, contextes variables). L'**évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997) ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? », mais « **qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ?** » ; elle formule des configurations **contexte – mécanisme – effet**. Exemple : dans un quartier où les familles se connaissent (contexte), un atelier cuisine crée de l'entraide (mécanisme) qui maintient la pratique culinaire après le projet (effet). Le Medical Research Council britannique a publié en 2021 un cadre de référence actualisé pour le développement et l'évaluation des interventions complexes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La santé dans toutes les politiques et les déterminants commerciaux de la santé

La déclaration d'Helsinki (2013) invite tous les secteurs (agriculture, économie, urbanisme, éducation) à évaluer l'**impact sur la santé** de leurs décisions (**évaluation d'impact sur la santé, EIS**). Plus récemment, l'OMS et *The Lancet* (série 2023) ont mis en avant les **déterminants commerciaux de la santé** : les stratégies des entreprises (marketing, lobbying, formulation des produits, prix) influencent la santé des populations. Ces travaux éclairent les débats sur l'encadrement du marketing alimentaire destiné aux enfants et sur le caractère volontaire du Nutri-Score.

1.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Consultation et santé publique

Une diététicienne libérale constate que beaucoup d'enfants qu'elle reçoit en consultation pour surpoids viennent de la même école. **Lien** : la consultation (BC1, soin individuel, prévention tertiaire ou secondaire) révèle un **problème de santé publique** ; elle peut alerter la santé scolaire et proposer une action **universelle** dans l'école (BC3) plutôt que de multiplier les consultations. Elle veille à ne pas stigmatiser les enfants et à respecter le **secret professionnel** (aucune information individuelle transmise).

Situation bc1 – De l'ETP à l'atelier ouvert

Un programme d'ETP « diabète » d'un hôpital souhaite proposer un atelier cuisine ouvert aux habitants du quartier. **Lien** : il faut distinguer l'**ETP** (réservée aux patients du programme déclaré à l'ARS) et l'**éducation pour la santé** ouverte à tous (prévention primaire) ; les objectifs, les messages et l'évaluation ne sont pas les mêmes.

Situation bc2 – Restauration scolaire et EGalim

Le diététicien d'une cuisine centrale (BC2) doit atteindre les objectifs EGalim et introduire un deuxième repas végétarien par semaine. **Lien BC3** : accompagner ce changement par une action d'**éducation au goût** dans les écoles (ateliers de dégustation de légumineuses), une **communication** vers les parents (plan de communication) et une **évaluation** (taux de consommation, gaspillage, satisfaction).

Situation bc2 – Former les professionnels

Le CCAS demande de former les aides à domicile à repérer la dénutrition des personnes âgées. **Lien** : compétence C2.6 (former les professionnels) au service d'une action de **prévention secondaire** (repérage précoce), inscrite dans le PNNS 5 (prévention de la dénutrition).

Situation bc3 – Répondre à un appel à projets

L'ARS lance un appel à projets « Nutrition et précarité ». Une association d'aide alimentaire vous sollicite. **Compétences** : C3.1 (diagnostic, objectifs, fiche projet, budget), C3.4 (veille sur les priorités du PRS et du PNNS 5), C3.5 (présentation du projet aux partenaires), C3.6 (dépôt du dossier sur une plateforme sécurisée, gestion des données des bénéficiaires).

Situation bc3 – Une demande inadaptée

Un directeur d'école vous demande une intervention d'une heure « pour expliquer aux enfants en surpoids qu'il faut moins manger ». **Analyse** : la demande est **stigmatisante** et fondée sur l'approche informative ; vous proposez une action **universelle** (toute la classe), **participative** (éducation sensorielle, découverte des fruits et légumes), associée à une action sur l'environnement (goûters, fontaine à eau) et à l'implication des parents, en cohérence avec la Charte d'Ottawa.

Méthode 1 – Présenter le cadre de son action en deux minutes (oral E5)

Le jury de l'épreuve E5 attend que vous situiez votre action dans son **cadre institutionnel et politique** (savoirs « enjeux de santé publique » du guide 2025). Cette présentation tient en deux minutes et suit toujours le même plan, du général au particulier.

Étape	Ce que vous dites	Exemple (fil rouge)	Durée
1. Le problème de santé	Le problème, chiffré et sourcé, au niveau national puis local	« 17 % des 6-17 ans sont en surpoids en France (Esteban 2015) ; 14 % des enfants de grande section des Tilleuls, contre 9 % dans le département (santé scolaire, 2026). »	30 s
2. Les politiques	La stratégie et le programme national, puis le niveau régional et local	« Le PNNS 5 vise une baisse de 30 % du surpoids des enfants, de 20 % chez ceux des familles défavorisées ; le PRS en fait une priorité ; le CLS de Valmont a une fiche-action nutrition. »	30 s
3. Le mode d'intervention	Promotion, prévention (OMS et Gordon), éducation (nutritionnelle, alimentaire, sensorielle)	« C'est une action de promotion de la santé et de prévention primaire, sélective, avec une éducation alimentaire et sensorielle. »	20 s
4. Les acteurs	Décideur, financeur, opérateurs, partenaires	« L'ARS finance par appel à projets ; le centre social porte le projet ; l'épicerie solidaire et la PMI sont partenaires. »	20 s
5. Votre place	Votre rôle et vos compétences	« J'ai réalisé le diagnostic, conçu et animé les ateliers, et construit l'évaluation (C3.1, C3.2, C3.5). »	20 s

Le jury attend – Les erreurs qui coûtent des points

- Citer un programme **périmé** (PNNS 4 au lieu du PNNS 5) ou présenter comme adopté un texte qui n'est qu'un projet (la SNS 2023-2033, non adoptée en mai 2026).
- Donner un chiffre **sans source ni année**.
- Confondre **promotion de la santé** et **éducation pour la santé**, ou qualifier une action collective d'**ETP**.
- Oublier les **acteurs** et présenter l'action comme celle d'une personne seule.

À vous de jouer – Exercice d'application 1.7 – Mon cadre en deux minutes

Rédigez, pour votre action de stage (ou, à défaut, pour l'action « Bouge et mange » d'un club sportif d'adolescents), les cinq phrases du tableau ci-dessus. Chronométrez-vous à voix haute : vous devez tenir en deux minutes.

Corrigé – Exercice 1.7 (exemple pour le club sportif)

1. « Selon Esteban, 17 % des 6-17 ans sont en surpoids ; dans le club, 6 adolescents sur 10 sautent le petit déjeuner avant l'entraînement du samedi (questionnaire, mars 2027). » 2. « L'action répond au PNNS 5 (comportements nutritionnels sains et milieux de vie) et à la Stratégie nationale sport-santé ; le PRS de la région cible la santé des jeunes. » 3. « C'est une action de promotion de la santé dans un milieu de vie, de prévention primaire universelle (tous les licenciés), avec une éducation nutritionnelle. » 4. « Le club porte le projet ; la commune et la mutuelle financent ; le comité départemental et l'infirmière du collège sont partenaires. » 5. « J'ai réalisé le questionnaire, animé deux ateliers petit déjeuner et évalué l'action. » Les données du club sont fictives : dans votre dossier, chaque chiffre doit venir de votre propre recueil ou d'une source datée.

Méthode 2 – Lire de façon critique un document de santé publique

Le référentiel (compétence C3.4) demande de **sélectionner des sources fiables** et d'en faire une **analyse critique**. Avant d'utiliser un document (article, rapport, affiche, page web), posez-vous six questions.

Question	Ce que l'on vérifie	Signal d'alerte
Qui ?	L'auteur ou l'organisme, sa compétence, ses liens d'intérêts	Document d'une marque ou d'un lobby présenté comme neutre
Quand ?	La date de publication et la date du recueil des données	Chiffre de plus de 10 ans présenté comme actuel
Quoi ?	Le type de document : étude, avis d'expert, opinion, publicité	Témoignage présenté comme une preuve
Sur qui ?	La population étudiée et son effectif	Résultat sur 30 personnes généralisé à toute la France
Comment ?	La méthode : données mesurées ou déclarées, étude d'observation ou essai	Lien de cause à effet affirmé à partir d'une simple association
Et alors ?	La cohérence avec les recommandations officielles (HCSP, ANSES, Santé publique France)	Conseil contraire aux repères officiels, sans débat scientifique

À vous de jouer – Exercice d'application 1.8 – Analyser un document

Document (fictif, construit pour l'exercice) : une page web d'un fabricant de céréales, datée de 2026, titre « Le petit déjeuner aux céréales rend les enfants plus performants à l'école ». Le texte cite « une étude » menée en 2009 auprès de 42 enfants d'une école privée, dont les parents déclaraient ce que mangeait leur enfant ; les enfants qui mangeaient des céréales avaient de meilleures notes.

1. Appliquez les six questions de la méthode.
2. Pouvez-vous utiliser ce document dans votre dossier E5 ? Si oui, comment ?

Corrigé – Exercice 1.8

1. **Qui ?** Un fabricant : conflit d'intérêts. **Quand ?** Page de 2026, mais données de 2009 (17 ans). **Quoi ?** Un texte promotionnel qui résume une étude non référencée. **Sur qui ?** 42 enfants d'une seule école privée : effectif faible, population non représentative (niveau social plus élevé). **Comment ?** Données déclarées par les parents ; étude d'observation : on ne peut pas conclure que les céréales « rendent » les enfants performants (le niveau social peut expliquer à la fois le petit déjeuner et les notes). **Et alors ?** Les repères officiels recommandent un petit déjeuner, sans privilégier un produit de marque.
2. Pas comme une **source**. On peut l'utiliser comme **exemple** de document à analyser avec le public (atelier d'éducation critique à la publicité), ce qui développe la littératie en santé (chapitre 5).

1.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concepts

- **Santé (OMS, 1946)** : « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Critique : idéal, statique ; la santé est aussi une capacité d'adaptation et une **ressource de la vie quotidienne** (Ottawa, 1986).
- **Une seule santé / One Health** : santé humaine, animale et des écosystèmes interdépendantes (Quadripartite OMS-FAO-OMSA-PNUE) ; cadre de toute intervention du BC3 (guide 2025).
- **Santé publique** : actions organisées et collectives pour maintenir et améliorer la santé de la population en

agissant sur ses déterminants (Winslow, 1920 ; CSP art. L. 1411-1).

- **Paradoxe de Rose** : un grand nombre de personnes à faible risque produit plus de cas qu'un petit nombre à haut risque : il faut des actions populationnelles.
- **Danger** (capacité à nuire) ≠ **risque** (probabilité, = danger × exposition) ; **facteur de risque** = association, pas forcément cause.

À retenir – Modes d'intervention

- **Surveillance** (recueil continu, analyse, diffusion) et **veille sanitaire** (détection des signaux, alerte) : Santé publique France, ANSES.
- **Promotion de la santé** (Ottawa, 21/11/1986) : processus qui confère aux populations les moyens d'un plus grand contrôle sur leur santé ; **5 domaines** (politique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services) et **3 stratégies** (plaider, conférer les moyens, servir de médiateur).
- **Prévention** (OMS 1948) : primaire (incidence), secondaire (prévalence, dépistage), tertiaire (complications), quaternaire (surmédicalisation) ; Gordon (1983) : universelle, sélective, indiquée.
- **Éducation pour la santé** : nutritionnelle, alimentaire, sensorielle ; approche participative et compétences psychosociales.
- **ETP** : soin, patients atteints de maladie chronique, programme déclaré à l'ARS (BC1) ≠ éducation pour la santé.
- **Universalisme proportionné** (Marmot, 2010) : pour tous, plus intensément pour les plus défavorisés.

À retenir – Acteurs et politiques

- National : DGS (PNNS), DGAL (PNA, EGalim), Santé publique France, ANSES, HAS, HCSP, CNA ; régional : **ARS** (PRS = COS 10 ans + SRS 5 ans + PRAPS ; appels à projets), DRAAF ; local : CLS, PAT, contrats de ville, communes, CCAS, PMI.
- **SNANC 2025-2030** (loi Climat et résilience, art. 265) publiée le **11/02/2026** ; **PNNS 5** et **PNA 4** (2026-2030) lancés le **08/04/2026** ; PNNS 5 : 3 axes, 20 mesures, − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents.
- **Repères 2019** (Santé publique France) : augmenter (fruits et légumes, légumes secs, fruits à coque, activité physique), aller vers (complets, colza-noix-olive, poisson 2/sem., 2 produits laitiers, saison/local/bio), réduire (alcool, boissons sucrées, produits gras-sucrés-salés et ultra-transformés, charcuterie 150 g/sem., viande 500 g/sem., sel, sédentarité).
- **EGalim** : 50 % durables et de qualité dont 20 % bio ; 60 % pour viandes et poissons (2024) ; menu végétarien hebdomadaire à l'école. **Nutri-Score** : facultatif, nouvel algorithme (arrêté du 14/03/2025).

À retenir – Chiffres-clés (à dater et sourcer dans vos écrits)

Donnée	Valeur (source, année)
Obésité de l'adulte	18,1 % (OFÉO, 2024) ; 17 % mesuré (ESTEBAN, 2015)
Surpoids des 6-17 ans	17 % dont 4 % d'obésité (ESTEBAN, 2015)
Précarité alimentaire	16 % (Crédoc, 2022)
Atteinte des 5 fruits et légumes	30 % des adultes, 20 % des enfants (HCSP, 2025)
Fibres < 25 g/jour	90 % des adultes (HCSP, 2025)
Espérance de vie	85,9 ans (F), 80,3 ans (H) (Insee, 2025)
Écart d'espérance de vie selon le revenu	≈ 13 ans chez les hommes (Insee, 2018)
EGalim, achats 2023	≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio (bilan 2024)

Donnée	Valeur (source, année)
PAT	≈ 450 reconnus (juillet 2025) ; objectif 80 % du territoire (SNANC)
Fil rouge (fictif)	Repas complet à 1,38 €/personne ; score 4,75 → 7,17/10 ; légumes secs 25 % → 75 %

1.8 Entraînement

1.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La définition de la santé de l'OMS date de :

a) 1946 (signature de la Constitution), entrée en vigueur en 1948 **b)** 1978 (Alma-Ata) **c)** 1986 (Ottawa) **d)** 2004 (loi relative à la politique de santé publique)

QCM 2 – Selon la Charte d'Ottawa, la promotion de la santé :

a) vise une maladie précise **b)** confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé **c)** se limite à l'information du public **d)** agit sur les politiques publiques et les milieux de vie

QCM 3 – Parmi ces domaines, lequel n'est PAS l'un des cinq domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?

a) Créer des milieux favorables **b)** Renforcer l'action communautaire **c)** Développer le dépistage organisé **d)** Réorienter les services de santé

QCM 4 – La prévention primaire vise à réduire :

a) la prévalence d'une maladie **b)** l'incidence d'une maladie **c)** les complications d'une maladie installée **d)** la surmédicalisation

QCM 5 – Le repérage du rebond d'adiposité précoce sur la courbe de corpulence d'un enfant relève de la prévention :

a) primaire **b)** secondaire **c)** tertiaire **d)** quaternaire

QCM 6 – Une action réservée aux familles d'un quartier prioritaire, sans signe de maladie, est une prévention (Gordon) :

a) universelle **b)** sélective **c)** indiquée **d)** tertiaire

QCM 7 – L'éducation thérapeutique du patient :

a) est une forme d'éducation pour la santé destinée à toute la population **b)** s'adresse à des personnes atteintes d'une maladie chronique **c)** est encadrée par la loi HPST du 21 juillet 2009 **d)** relève de la prévention tertiaire

QCM 8 – Le risque se définit comme :

a) la propriété intrinsèque d'un agent à provoquer un effet néfaste **b)** la probabilité de survenue d'un effet néfaste, compte tenu du danger et de l'exposition **c)** une caractéristique associée à une moindre probabilité de maladie **d)** le nombre de nouveaux cas dans une population

QCM 9 – Les études INCA sont conduites par :

a) Santé publique France **b)** l'ANSES **c)** la HAS **d)** l'Insee

QCM 10 – Le projet régional de santé (PRS) :

a) est élaboré par l'ARS **b)** comprend un cadre d'orientation stratégique sur 10 ans **c)** comprend un schéma régional de santé sur 5 ans **d)** comprend un PRAPS destiné aux personnes les plus démunies

QCM 11 – La SNANC 2025-2030 :

a) est prévue par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 **b)** a été publiée le 11 février 2026 **c)** remplace la loi EGalim **d)** détermine les orientations du PNNS et du PNA

QCM 12 – Le PNNS en vigueur en octobre 2026 est :

a) le PNNS 3 **b)** le PNNS 4 (2019-2023) **c)** le PNNS 5 (2026-2030) **d)** le PNAN 2019-2023

QCM 13 – Selon les repères de Santé publique France (2019), il est recommandé de consommer des légumes secs :

a) au moins une fois par mois **b)** au moins deux fois par semaine **c)** tous les jours obligatoirement **d)** uniquement en remplacement du pain

QCM 14 – La loi EGalim impose en restauration collective :

a) 50 % de produits durables et de qualité dont au moins 20 % de produits bio **b)** 100 % de produits locaux **c)** un menu végétarien au moins une fois par semaine en restauration scolaire **d)** l'affichage obligatoire du Nutri-Score sur les menus

QCM 15 – Le Nutri-Score :

a) est obligatoire sur tous les produits vendus en France **b)** classe les produits de A à E **c)** a un nouvel algorithme applicable en France depuis l'arrêté du 14 mars 2025 **d)** mesure le degré de transformation des aliments

QCM 16 – L'universalisme proportionné consiste à :

a) cibler uniquement les plus défavorisés **b)** proposer la même action avec la même intensité à tous **c)** proposer une action à tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage social **d)** supprimer les actions universelles

QCM 17 – Le paradoxe de la prévention (Rose) signifie que :

a) la prévention est inutile **b)** la majorité des cas provient souvent du grand nombre de personnes à risque faible ou modéré **c)** il faut uniquement traiter les personnes à haut risque **d)** une mesure utile à la population apporte souvent peu à chaque individu

QCM 18 – Lequel de ces organismes assure la veille sanitaire en France ?

a) Santé publique France **b)** le CNA **c)** l'EFSA **d)** la DGCCRF

QCM 19 – Le modèle de Dahlgren et Whitehead :

a) classe les niveaux de prévention **b)** représente les déterminants de la santé en couches concentriques **c)** place au centre l'âge, le sexe et les facteurs héréditaires **d)** montre que les comportements dépendent des conditions de vie

QCM 20 – Une campagne télévisée nationale « Manger Bouger » relève de :

a) l'éducation pour la santé informative **b)** la prévention primaire universelle **c)** l'éducation thérapeutique **d)** la prévention tertiaire

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a. Constitution signée le 22 juillet 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948. Alma-Ata (1978) concerne les soins de santé primaires ; Ottawa (1986) la promotion de la santé.

2. b, d. La promotion de la santé ne vise pas une maladie précise (c'est la prévention) et ne se limite pas à l'information : elle agit sur les politiques, les milieux, la communauté, les aptitudes et les services.

3. c. Le dépistage relève de la prévention secondaire, pas des cinq domaines d'Ottawa.

4. b. La prévention primaire évite l'apparition de nouveaux cas (incidence) ; la secondaire réduit la prévalence ; la tertiaire les complications ; la quaternaire la surmédicalisation.

5. b. Le repérage précoce d'un signe (avant l'installation de l'obésité et de ses complications) est une prévention secondaire.

6. b. Sous-groupe exposé à un risque (précarité), sans signe de maladie : prévention sélective.

7. b, c, d. L'ETP n'est pas de l'éducation pour la santé « tout public » : elle s'adresse aux patients (art. L. 1161-1 du CSP issu de la loi HPST) et relève du soin et de la prévention tertiaire.

8. b. La réponse a définit le danger ; c le facteur de protection ; d l'incidence.

9. b. INCA = études individuelles nationales des consommations alimentaires de l'ANSES (ESTEBAN = Santé publique France).

10. a, b, c, d. Les quatre affirmations sont exactes (art. L. 1434-1 et suivants du CSP).

11. a, b, d. La SNANC ne remplace pas EGalim : elle rappelle et prolonge ses objectifs.

12. c. PNNS 5 lancé le 8 avril 2026. Citer le PNNS 4 comme « en vigueur » serait une erreur de veille.

13. b. Légumes secs au moins 2 fois par semaine (catégorie « augmenter »).

14. a, c. L'affichage du Nutri-Score n'est pas obligatoire ; le « 100 % local » n'existe pas (le critère « local » n'est d'ailleurs pas autorisé en tant que tel par le droit des marchés publics).

15. b, c. Le Nutri-Score est facultatif (droit européen) et mesure la composition nutritionnelle, pas la transformation (c'est la classification NOVA).

16. c. Définition de Marmot (2010).

17. b, d. Le paradoxe justifie les actions populationnelles en complément des actions à haut risque.

18. a. Le CNA est une instance de concertation ; l'EFSA est européenne ; la DGCCRF contrôle la loyauté commerciale.

19. b, c, d. Les niveaux de prévention, c'est la classification de l'OMS.

20. a, b. Communication de masse, informative, destinée à toute la population, avant toute maladie.

1.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les niveaux de prévention

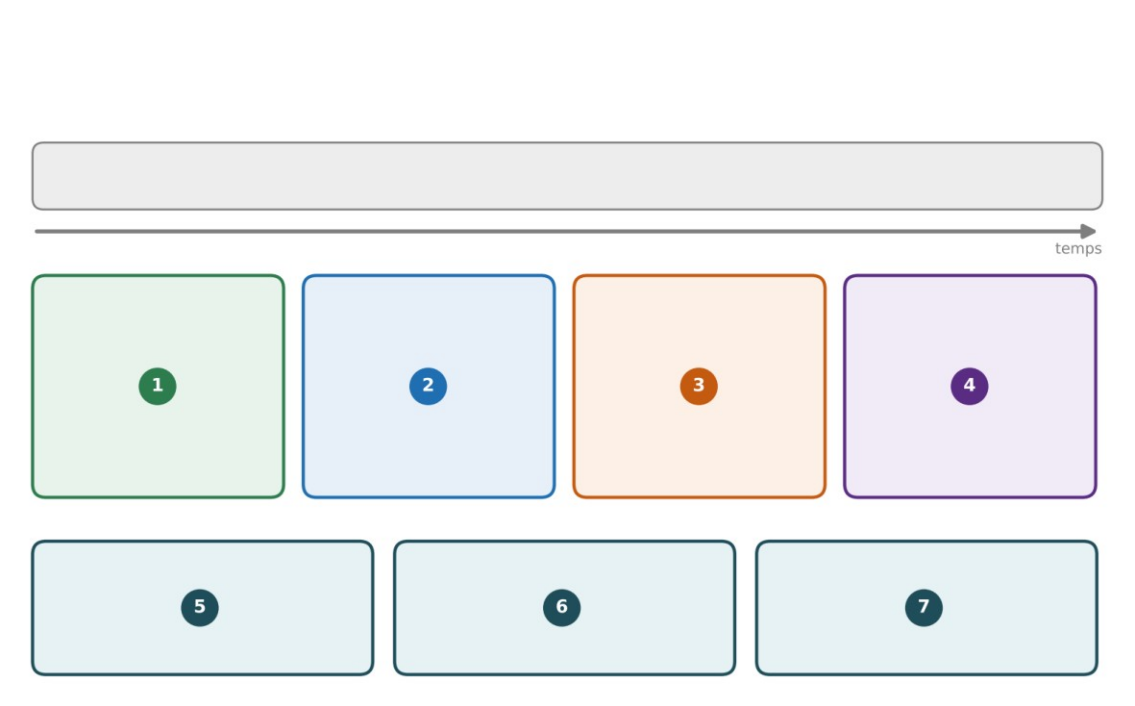


Figure 1.15 – Schéma à légender (niveaux de prévention)

Complétez les légendes 1 à 7 : nom du niveau ou du type de prévention, auteur et date de la classification, indicateur que chaque niveau fait baisser, un exemple en nutrition pour chacun.

Corrigé

1. Prévention primaire (OMS, 1948) : avant la maladie ; diminue l'**incidence** ; exemple : atelier cuisine pour

tous, réduction du sel dans le pain.

2. Prévention secondaire : au début de la maladie ; diminue la **prévalence** par le dépistage ; exemple : repérage du surpoids en santé scolaire, dépistage de la dénutrition.

3. Prévention tertiaire : maladie installée ; diminue les **complications et récidives** ; exemple : suivi diététique de la personne diabétique, ETP.

4. Prévention quaternaire (Jamoulle, 1986) : évite la **surmédicalisation** ; exemple : déconseiller un régime d'éviction sans diagnostic.

5. Prévention universelle (Gordon, 1983) : toute la population ; exemple : repères PNNS.

6. Prévention sélective : sous-groupe exposé ; exemple : familles d'une épicerie solidaire.

7. Prévention indiquée : personnes présentant déjà des facteurs de risque ; exemple : programme pour enfants en surpoids repérés.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les déterminants de la santé

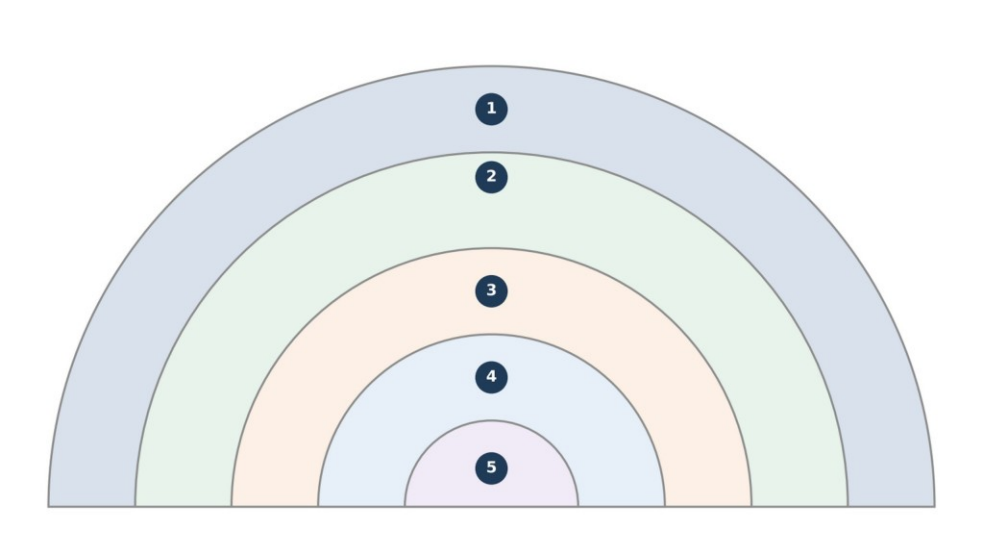


Figure 1.16 – Schéma à légender (modèle des déterminants)

Donnez le nom du modèle et sa date, puis légendez les couches 1 à 5. Pour chaque couche, donnez un exemple de déterminant de l'alimentation d'un enfant vivant dans un quartier prioritaire.

Corrigé

Modèle de **Dahlgren et Whitehead (1991)**.

1. Âge, sexe, facteurs héréditaires : âge de l'enfant (8 ans), préférences innées pour le sucré.

2. Style de vie personnel : grignotage devant les écrans, faible activité physique.

3. Réseaux sociaux et communautaires : habitudes familiales, influence des camarades, soutien des voisins, centre social.

4. Conditions de vie et de travail : logement exigu sans cuisine équipée, offre alimentaire du quartier (supérette, restaurants rapides), cantine, horaires de travail des parents, chômage.

5. Conditions socio-économiques, culturelles et environnementales générales : prix des aliments, minima sociaux, politiques alimentaires (EGalim, Nutri-Score), publicité, culture alimentaire.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'architecture des politiques

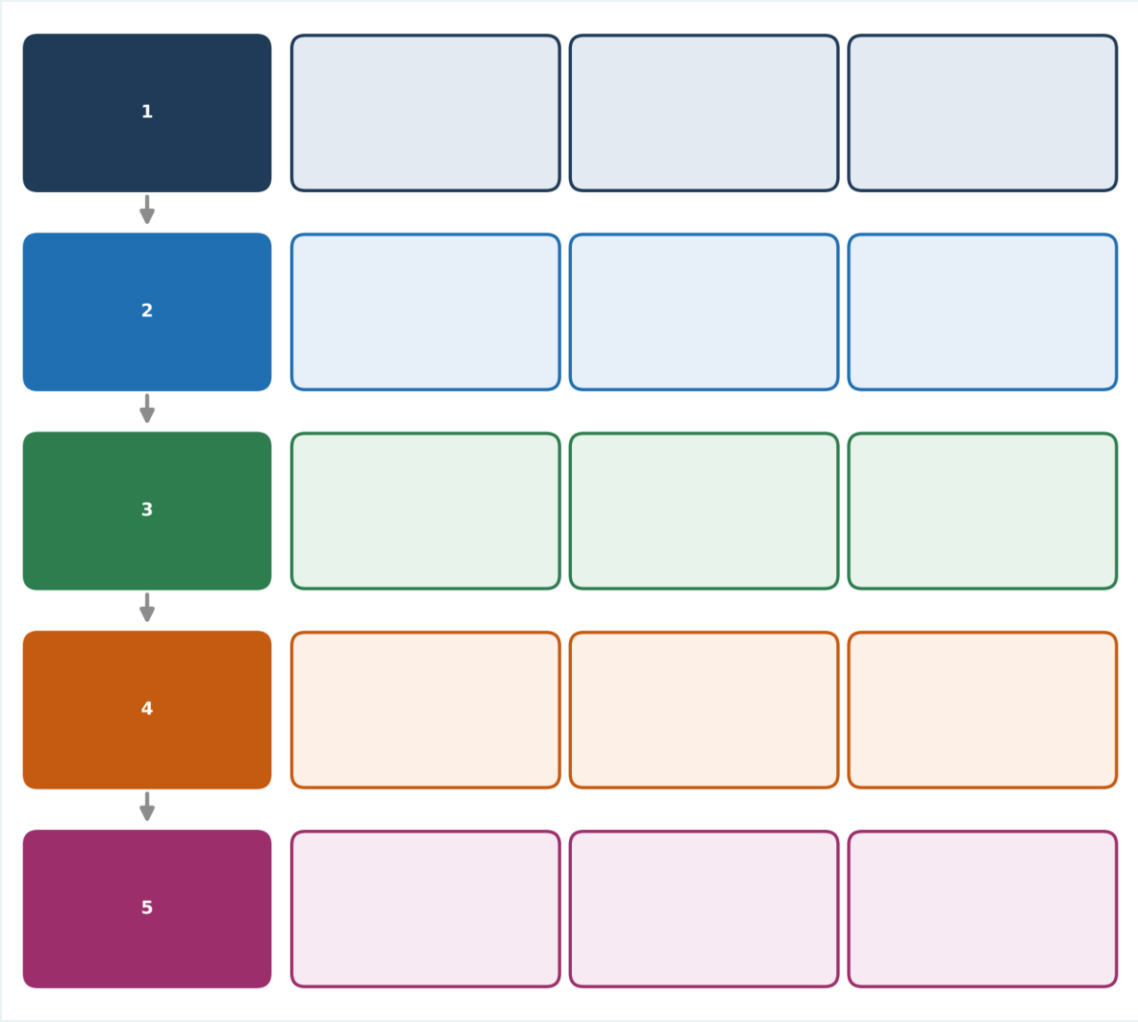


Figure 1.17 – Schéma à légender (architecture des politiques nutritionnelles)

Nommez les 5 niveaux (1 à 5) et placez dans les bonnes cases : OMS ; SNANC 2025-2030 ; PNNS 5 ; PNA 4 ; ARS – PRS ; DRAAF ; CLS ; PAT ; loi EGalim ; Stratégie nationale de santé ; règlement INCO ; centre social ; diététicien.

Corrigé

1. Mondial et européen : OMS ; règlement INCO (Union européenne).

2. National – stratégies : Stratégie nationale de santé (dernière adoptée : 2018-2022) ; SNANC 2025-2030.

3. National – programmes et lois : PNNS 5 ; PNA 4 ; loi EGalim.

4. Régional : ARS – PRS ; DRAAF.

5. Local et terrain : CLS ; PAT ; centre social ; diététicien.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la démarche de projet

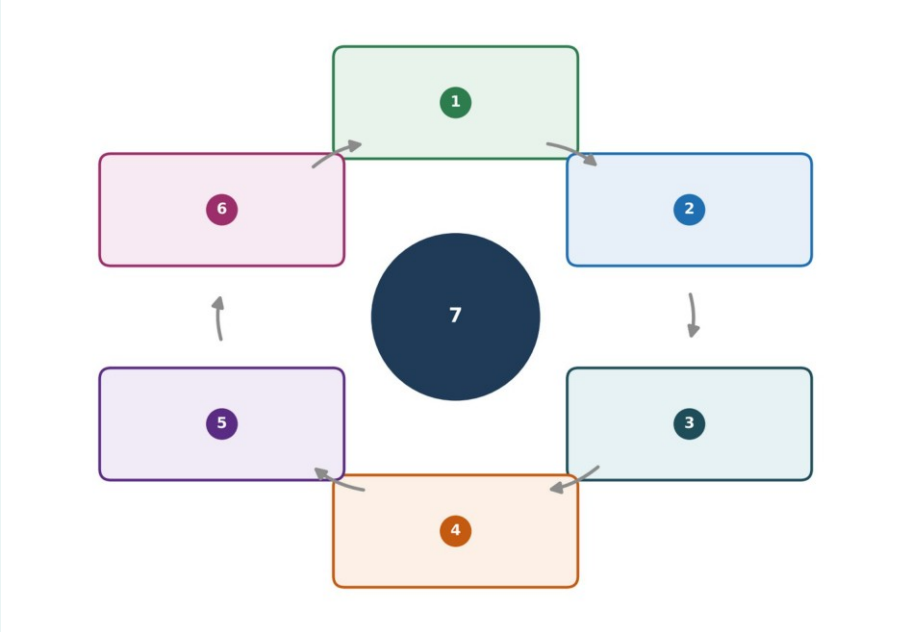


Figure 1.18 – Schéma à légender (démarche de projet)

Nommez les étapes 1 à 6 et le centre 7, puis placez les fiches F1 à F14.

Corrigé

1. Analyse de situation et diagnostic (F1, F2). 2. Priorités et objectifs (F3). 3. Conception et plan d'action (F4, F5, F6). 4. Mise en œuvre et pilotage (F7, F8, F9, F10). 5. Évaluation (F11, F12). 6. Valorisation et ajustements (F13, F14). 7. Démarche de projet en santé publique (cycle).

À vous de jouer – Exercice 5 – Classer des actions (tableau)

Classez les 8 actions suivantes selon le mode d'intervention dominant et le niveau de prévention : a) taxe sur les boissons sucrées ; b) dépistage de la dénutrition à l'admission en EHPAD ; c) classe du goût en CE1 ; d) déclaration d'une TIAC à l'ARS ; e) programme d'ETP « insuffisance rénale » ; f) jardin partagé co-géré par les habitants ; g) enquête Albane ; h) atelier « repas à petit prix » à l'épicerie solidaire.

Corrigé

Action	Mode d'intervention	Prévention
a	Promotion de la santé (politique publique saine, fiscalité)	Primaire, universelle
b	Prévention (dépistage)	Secondaire, sélective (population âgée à risque)
c	Éducation pour la santé (sensorielle)	Primaire, universelle (toute la classe)
d	Veille sanitaire (signal, alerte)	Permet la prévention de nouveaux cas (primaire)
e	ETP (soin, BC1)	Tertiaire
f	Promotion de la santé (action communautaire, milieu favorable)	Primaire, universelle ou sélective selon le quartier
g	Surveillance	– (production de données)
h	Éducation pour la santé (alimentaire)	Primaire, sélective

À vous de jouer – Exercice 6 – Paradoxe de Rose (calcul)

Dans une ville de 50 000 adultes, 4 000 ont un IMC ≥ 35 (risque de diabète sur 5 ans : 60 pour 1 000) et 46 000 ont un IMC < 35 (risque : 8 pour 1 000). a) Calculez le nombre de cas de diabète attendus dans chaque groupe sur 5 ans. b) Quelle part des cas provient du groupe « à faible risque » ? c) Concluez.

Corrigé

a) Groupe à haut risque : 4 000 × 60 / 1 000 = **240 cas**. Groupe à faible risque : 46 000 × 8 / 1 000 = **368 cas**. **b)** Total : 240 + 368 = 608 cas ; part du groupe à faible risque : 368 / 608 = 0,605, soit **60,5 %**. **c)** Même si le risque individuel est 7,5 fois plus élevé dans le groupe IMC ≥ 35 (60 / 8 = 7,5), la majorité des cas vient du groupe le plus nombreux : il faut associer une **stratégie populationnelle** (environnement, éducation pour tous) à la **stratégie à haut risque** (repérage, prise en charge).

À vous de jouer – Exercice 7 – Calculer un taux EGalim et proposer des ajustements

Un restaurant d'entreprise achète 200 000 € HT de denrées par an : bio 30 000 € ; Label Rouge et AOP/IGP 40 000 € ; produits « local mais conventionnel » 25 000 €. Les viandes et poissons représentent 60 000 € dont 30 000 € sous signe de qualité. a) Calculez les taux bio et « durables et de qualité ». b) Le taux pour les viandes et poissons. c) Respect de la loi ? d) Combien faudrait-il réorienter d'achats bio pour atteindre 20 % ?

Corrigé

a) Bio : 30 000 / 200 000 × 100 = **15 %**. Durables et de qualité : (30 000 + 40 000) / 200 000 × 100 = **35 %** (le « local conventionnel » ne compte pas : le local n'est pas un critère EGalim en soi). **b)** Viandes et poissons : 30 000 / 60 000 × 100 = **50 %**. **c)** Non respect : 15 % < 20 % (bio) ; 35 % < 50 % ; 50 % < 60 % (viandes et poissons, obligation depuis le 1er janvier 2024 ; la restauration collective privée est concernée depuis 2024). **d)** Objectif bio : 20 % × 200 000 = 40 000 € ; il faut **10 000 €** d'achats bio supplémentaires (à budget constant, par réorientation d'achats conventionnels).

À vous de jouer – Exercice 8 – Coût d'une recette mise à l'échelle

Une recette de « dahl de lentilles » pour 6 personnes utilise : 300 g de lentilles corail (3,20 €/kg), 400 g de tomates concassées en conserve (2,10 €/kg), 200 mL de lait de coco (4,50 €/L), 150 g d'oignons (1,80 €/kg), 10 g d'épices (25 €/kg), 300 g de riz (1,90 €/kg). Calculez le coût pour 15 personnes et le coût par portion. Vous pouvez vérifier avec la feuille 1 du tableur.

Corrigé

Coefficient = 15 / 6 = **2,5**. Quantités pour 15 : lentilles 750 g ; tomates 1 000 g ; lait de coco 500 mL ; oignons 375 g ; épices 25 g ; riz 750 g. Coûts : lentilles 750 / 1 000 × 3,20 = 2,40 € ; tomates 1 000 / 1 000 × 2,10 = 2,10 € ; lait de coco 0,5 × 4,50 = 2,25 € ; oignons 0,375 × 1,80 = 0,675 € ; épices 0,025 × 25 = 0,625 € ; riz 0,75 × 1,90 = 1,425 €. **Total** = 2,40 + 2,10 + 2,25 + 0,675 + 0,625 + 1,425 = **9,475 € ≈ 9,48 €** pour 15 personnes. **Coût par portion** = 9,475 / 15 = **0,63 €**. Interprétation : un plat complet à base de légumineuses et de céréales coûte moins de 1 € par portion ; le lait de coco est l'ingrédient le plus coûteux (24 % du total : 2,25 / 9,475) et peut être remplacé en partie par du lait ou du yaourt.

À vous de jouer – Exercice 9 – Rédiger des objectifs SMART

Réécrivez ces objectifs pour qu'ils soient SMART : a) « Améliorer l'alimentation des collégiens. » b) « Faire des ateliers sur le petit-déjeuner. » c) « Que les personnes âgées mangent mieux. »

Corrigé

a) Objectif spécifique : « D'ici juin 2028, la proportion d'élèves de 6e du collège Jean-Moulin qui déclarent prendre un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 passe de 62 % à 75 %. » **b)** Objectif opérationnel : « Animer, entre janvier et mars 2028, 4 ateliers petit-déjeuner d'une heure dans chacune des 5 classes de 6e, avec au moins 90 % des élèves présents. » **c)** Objectif spécifique : « D'ici décembre 2028, 80 % des résidents de la résidence autonomie Les Lilas bénéficient d'une pesée mensuelle et 100 % des résidents ayant perdu 5 % de leur poids en un mois sont orientés vers le médecin traitant. » Chaque objectif comporte un public précis, un indicateur chiffré avec une valeur de départ quand elle est connue, une échéance, et reste réaliste au regard des moyens.

À vous de jouer – Exercice 10 – Tableau de bord

Un projet prévoyait 8 séances, 15 participants par séance, 85 % de satisfaits et un budget de 2 400 €. Réalisé : 7 séances, 94 présences cumulées, 26 satisfaits sur 30 répondants, 2 280 € dépensés. Calculez les taux d'atteinte et concluez.

Corrigé

- Séances : 7 / 8 × 100 = **87,5 %** (partiellement atteint).
- Présences : prévu 8 × 15 = 120 ; 94 / 120 × 100 = **78,3 %** (non atteint, < 80 %). Présence moyenne réelle par séance réalisée : 94 / 7 = 13,4 participants.
- Satisfaction : 26 / 30 = **86,7 %** ; taux d'atteinte 86,7 / 85 × 100 = **102 %** (atteint).
- Budget : 2 280 / 2 400 × 100 = **95 %** (dans le budget ; 120 € non dépensés, cohérent avec la séance annulée).
- **Conclusion** : le projet satisfait les participants mais la participation est insuffisante ; analyser les causes (horaires, communication, séance annulée) et proposer des ajustements (rappels, horaires, implication de relais).

À vous de jouer – Exercice 11 – Interpréter des chiffres

Expliquez pourquoi on ne peut pas conclure que l'obésité a augmenté de 1,1 point entre 2015 (17 %, ESTEBAN) et 2024 (18,1 %, OFÉO).

Corrigé

Les deux études diffèrent par la **méthode** (mesures réalisées par un enquêteur dans ESTEBAN ; poids et taille **déclarés** dans OFÉO, qui ont tendance à sous-estimer l'IMC), par la **population** (18-74 ans pour ESTEBAN ; adultes y compris personnes âgées et outre-mer pour OFÉO) et par l'**échantillonnage**. Une comparaison dans le temps exige la même méthode : c'est l'intérêt des enquêtes répétées comme Albane. On peut seulement dire que l'ordre de grandeur reste d'environ **un adulte sur six**.

1.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Pourquoi une action d'éducation nutritionnelle « pour tous » peut-elle augmenter les inégalités sociales de santé ? Comment l'éviter ?

Corrigé

Les personnes les plus favorisées ont plus de **ressources** (temps, argent, littératie, réseau) pour s'approprier les messages et changer leurs pratiques : l'écart avec les plus défavorisés peut donc **s'accroître** (effet « Matthieu »). Pour l'éviter : appliquer l'**universalisme proportionné** (renforcer l'action là où les besoins sont plus importants), adapter les supports à la **littératie** (FALC, pictogrammes, langues), agir sur les **déterminants structurels** (prix, offre, cantine à tarification sociale) et impliquer les personnes concernées dans la conception (**participation**).

À vous de jouer – Question 2

Un industriel propose de financer vos ateliers en échange de la distribution de ses céréales du petit-déjeuner. Que faites-vous ?

Corrigé

Il s'agit d'un **conflit d'intérêts** : le diététicien doit délivrer une information **indépendante** et ne pas faire la promotion d'une marque (chapitre 6). On refuse la distribution de produits de marque et la présence du logo sur les supports pédagogiques ; on peut rechercher d'autres financements (ARS, collectivités, fondations sans lien avec les produits concernés) ou, si un partenariat privé est envisagé, l'encadrer par une **convention** garantissant l'indépendance du contenu, conformément aux règles de la structure. On en informe la tutrice et on le mentionne dans le dossier (règles éthiques et déontologiques respectées, C3.1).

À vous de jouer – Question 3

« La santé publique, c'est convaincre les gens de changer leurs comportements. » Discutez cette affirmation.

Corrigé

L'affirmation est **réductrice**. Les comportements sont influencés par de nombreux **déterminants** (Dahlgren et Whitehead) : revenus, offre alimentaire, culture, conditions de travail. La Charte d'Ottawa montre que la santé publique agit aussi sur les **politiques**, les **milieux de vie**, la **communauté** et les **services**, et pas seulement sur les aptitudes individuelles. Une approche uniquement persuasive risque de **culpabiliser** et d'être peu efficace. Toutefois, l'éducation pour la santé reste un levier important lorsqu'elle est **participative** et développe les **compétences** (auto-efficacité). Conclusion : la santé publique combine actions sur l'environnement et développement du pouvoir d'agir.

À vous de jouer – Question 4

En quoi l'approche « Une seule santé » change-t-elle le contenu d'un atelier culinaire ?

Corrigé

L'atelier intègre, en plus de l'équilibre nutritionnel, des critères **environnementaux** (produits de saison, végétalisation, légumineuses, limitation du gaspillage, tri des déchets, énergie) et parfois **animaux** (origine et mode d'élevage des produits animaux). Les messages montrent les **co-bénéfices** (« bon pour moi, bon pour la planète, bon pour le budget ») sans culpabiliser, et l'évaluation peut inclure des indicateurs environnementaux (part de produits de saison, quantité de déchets). C'est l'esprit de la SNANC et des gestes éco-responsables exigés par le référentiel (C3.2).

1.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – La commune de Saint-Aubin (12 000 habitants)

La commune rurale de Saint-Aubin vous recrute pour un mois afin de préparer un projet sur l'alimentation des personnes âgées vivant à domicile. Documents : 26 % des habitants ont 65 ans ou plus ; 180 bénéficiaires du portage de repas du CCAS ; 1 supermarché à 8 km, pas de transport en commun ; un club des aînés (60 adhérents) ; une maison de santé pluriprofessionnelle ; 4 hospitalisations pour dénutrition signalées par la MSP l'an dernier. Le CLS de la communauté de communes comporte un axe « bien vieillir ».

1. Identifiez le problème de santé, la population, et justifiez qu'il s'agit d'un problème de santé publique.
2. Quels modes d'intervention et niveaux de prévention pouvez-vous mobiliser ? Donnez un exemple d'action pour chacun.
3. Citez les acteurs et les politiques sur lesquels vous appuyer.
4. Proposez un objectif général, deux objectifs spécifiques SMART et deux indicateurs d'évaluation.
5. Quelles précautions éthiques prenez-vous ?

Corrigé

1. Problème : risque de **dénutrition** des personnes âgées vivant à domicile. **Population** : 65 ans et plus (26 % de 12 000 = **3 120 personnes**), en particulier les 180 bénéficiaires du portage (fragilité). C'est un problème de santé publique car il est **fréquent** (la dénutrition concerne une part importante des personnes âgées, notamment à domicile et en établissement), **grave** (chutes, infections, hospitalisations, mortalité), **coûteux**, **évitable** et socialement inégalitaire (isolement, revenus, ruralité, absence de transport), et une **priorité** du PNNS 5 (prévention de la dénutrition) et du CLS (axe « bien vieillir »).

2. Promotion de la santé : plaider pour un transport à la demande vers le supermarché ou un marché itinérant ; repas partagés au club des aînés (milieu favorable, lien social). **Prévention primaire** : ateliers « bien manger après 70 ans » au club (éducation alimentaire) ; enrichissement des repas portés. **Prévention secondaire** : repérage (pesée mensuelle, questionnaire) par les livreurs de repas formés et la MSP, orientation vers le médecin. **Prévention tertiaire** : prise en charge diététique des personnes dénutries (BC1). **Prévention quaternaire** : éviter les régimes restrictifs inutiles après 75 ans (par exemple, régime sans sel strict non justifié).

3. Acteurs : CCAS (portage), MSP et médecins traitants, club des aînés, conseil départemental (APA), ARS (CLS, appels à projets), caisses de retraite (actions de prévention), associations d'aide à domicile. **Politiques** : PNNS 5, PRS (axe vieillissement), CLS « bien vieillir », recommandations HAS/FFAMCO 2021 sur le diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus.

4. Objectif général : contribuer à prévenir la dénutrition des personnes âgées vivant à domicile à Saint-Aubin d'ici 2028. **Objectif spécifique 1** : d'ici juin 2028, 100 % des bénéficiaires du portage de repas sont pesés au moins une fois par mois et toute perte de poids ≥ 5 % en un mois est signalée au médecin traitant. **Objectif spécifique 2** : d'ici juin 2028, 70 % des participants aux ateliers déclarent consommer au moins 3 produits laitiers par jour (repère personnes âgées) contre une valeur initiale mesurée au premier atelier. **Indicateurs** : proportion de bénéficiaires pesés mensuellement (processus) ; nombre d'orientations vers le médecin (processus) ; proportion de participants atteignant le repère produits laitiers (résultat).

5. Éthique : consentement des personnes pour la pesée et la transmission d'informations au médecin ; **secret professionnel** et **RGPD** (données de santé = données sensibles) ; respect de l'autonomie (pas d'imposition) ; non-stigmatisation (ne pas parler de « vieux dénutris ») ; attention aux personnes isolées ou atteintes de troubles cognitifs (associer l'aidant).

1.8.5 Mises en situation express

Répondez en 3 à 5 lignes, comme à l'entretien de l'épreuve E5.

Mise en situation – MSE 1

Le jury vous demande : « Votre projet, c'est de la prévention ou de la promotion de la santé ? » (projet d'ateliers cuisine dans un centre social).

Corrigé

C'est d'abord une action d'**éducation pour la santé** (alimentaire et nutritionnelle) au service de la **prévention primaire sélective** (public exposé à un risque du fait de la précarité). Elle s'inscrit dans une **démarche de promotion de la santé** dans la mesure où les familles ont participé au choix des thèmes (pouvoir d'agir), où un partenariat avec l'épicerie solidaire améliore l'accès aux produits (milieu favorable) et où le projet s'inscrit dans le CLS (politique locale).

Mise en situation – MSE 2

Une animatrice vous dit : « Le PNNS 4, c'est bien ce qui est en vigueur ? »

Corrigé

Non : le PNNS 4 couvrait 2019-2023. Depuis le **8 avril 2026**, c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**, déclinaison de la **SNANC 2025-2030** publiée le 11 février 2026. Je lui propose une courte note de veille avec les sources (ministère de la Santé, mangerbouger.fr) et je mets à jour nos supports.

Mise en situation – MSE 3

Dans une école, un enseignant veut peser tous les élèves en classe pour « sensibiliser ».

Corrigé

Je déconseille la pesée collective : elle est **stigmatisante**, sans intérêt éducatif et pose un problème de **confidentialité** des données de santé. Le repérage relève du service de santé scolaire, en individuel. Je propose plutôt une action universelle (éducation sensorielle, goûters, activité physique) et un travail avec les parents.

Mise en situation – MSE 4

Une mère dit lors d'un atelier : « De toute façon, chez nous on mange du riz tous les jours, c'est notre culture. »

Corrigé

J'accueille cette remarque sans jugement (posture de **respect culturel**) et je valorise ce qui est favorable (le riz est un féculent, base de repas) ; je propose de **partir de ses recettes** (par exemple, riz associé à des légumes secs et des légumes : plats complets du monde) plutôt que de lui imposer un modèle ; la recette peut être intégrée au livret (atelier « recettes du monde »).

Mise en situation – MSE 5

Vous voulez utiliser des photos de l'atelier pour le livret et le compte du centre social sur un réseau social.

Corrigé

Il faut une **autorisation écrite** de chaque personne photographiée (et des deux titulaires de l'autorité parentale pour un mineur), précisant les supports, la durée et la finalité (**droit à l'image** et RGPD) ; possibilité de refuser ou de retirer son accord ; photos sans visage (mains, plats) pour ceux qui refusent ; pas de noms de famille.

Mise en situation – MSE 6

L'ARS demande un indicateur de résultat pour votre projet d'ateliers.

Corrigé

Un indicateur de **résultat** mesure un effet sur le public : par exemple, « proportion de participants déclarant consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine, avant et après le cycle » (25 % → 75 % dans le fil rouge). Le nombre d'ateliers ou de participants est un indicateur de **processus**.

Mise en situation – MSE 7

Le directeur d'un EHPAD vous demande une « action de santé publique » sur la dénutrition.

Corrigé

Je précise d'abord le besoin par un **diagnostic** (prévalence de la dénutrition selon les critères HAS/FFAMCO 2021, pesées, organisation des repas, avis des résidents et des soignants). L'action peut associer prévention secondaire (dépistage systématique), primaire (repas enrichis, convivialité, textures adaptées, collations) et formation des soignants (BC2) ; elle s'inscrit dans le PNNS 5 (dénutrition) et les recommandations de la HAS.

Mise en situation – MSE 8

Quelle différence entre surveillance et veille sanitaire ?

Corrigé

La **surveillance** est une collecte **continue et systématique** de données pour décrire et suivre l'état de santé (par exemple, enquêtes INCA, ESTEBAN, Albane). La **veille** vise à **détecter des signaux** inhabituels (TIAC, alerte sur un produit) pour **alerter** rapidement les autorités. En France, Santé publique France assure les deux missions.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Pourquoi parlez-vous d'universalisme proportionné dans votre projet ? »

Corrigé

Parce que le projet propose des actions ouvertes à toutes les familles du quartier (universel) mais renforcées pour les familles de l'épicerie solidaire (gratuité, transport pour la visite du marché, rappels personnalisés, supports traduits) : l'intensité de l'action est **proportionnelle au désavantage**, pour ne pas creuser les inégalités tout en évitant la stigmatisation.

Mise en situation – MSE 10

Un participant à votre atelier vous annonce qu'il est diabétique et vous demande un régime.

Corrigé

L'atelier est une action d'éducation pour la santé collective : je ne prescris pas de régime individuel. Je l'oriente vers son **médecin traitant** et une **consultation diététique** ou un **programme d'ETP** (BC1). Je m'assure que les recettes de l'atelier lui conviennent (pas de contre-indication) et je respecte la confidentialité de son information devant le groupe.

Mise en situation – MSE 11

Où trouvez-vous des données sur l'état de santé de la population de votre lieu de stage ?

Corrigé

Insee (démographie, pauvreté par commune ou par QPV), **Géodes** (Santé publique France), ORS (portraits de territoire, Score-santé), ARS (diagnostic du PRS et du CLS), Drees, CPAM (données de l'Assurance maladie, ALD), service de santé scolaire et PMI (avec leur accord, données agrégées). Je **date** et **source** chaque donnée.

Mise en situation – MSE 12

Votre tutrice vous demande d'envoyer la liste des participants (nom, adresse, allergies) à l'épicerie partenaire par messagerie personnelle.

Corrigé

Les allergies sont des **données de santé** (données sensibles, RGPD). Je ne transmets que les données **strictement nécessaires** et avec l'**accord** des personnes ; j'utilise la messagerie professionnelle de la structure (pas ma messagerie personnelle), un fichier protégé si nécessaire, et je n'envoie pas de données de santé sans finalité justifiée (compétences C3.5 et C3.6 ; chapitres 20 et 21).

Mise en situation – MSE 13

Comment montrez-vous que votre atelier intègre des gestes éco-responsables ?

Corrigé

Choix de produits de **saison** et **locaux** (60,9 % du coût dans l'atelier n° 3), produits en vrac, plat **végétal** principal (légumineuses), compostage des épluchures au jardin partagé, four rempli, restes emportés dans des boîtes réutilisables, pas de vaisselle jetable, consommation d'eau et d'énergie maîtrisée ; j'en fais un indicateur (part de produits de saison, quantité de déchets).

Mise en situation – MSE 14

Une famille allophone ne comprend pas le flyer.

Corrigé

> Je tiens compte de la **littératie** et de la **langue** : flyer illustré avec pictogrammes et photos, traduction dans les langues les plus parlées (avec des habitants relais ou un service d'interprétariat), invitation **orale** par une personne de confiance (animatrice, médiatrice), et animation de l'atelier par le geste et la démonstration (chapitre 5).

1.9 Glossaire

Terme	Définition
Action communautaire	Action dans laquelle les membres d'une communauté (quartier, groupe) participent à l'identification des problèmes, aux décisions et à la mise en œuvre ; domaine 3 de la Charte d'Ottawa
Agence régionale de santé (ARS)	Établissement public créé par la loi HPST (2009) qui pilote la politique de santé en région (PRS, financement de la prévention, appels à projets, CLS)
Appel à projets (AAP)	Procédure par laquelle un financeur (ARS, DRAAF, fondation) définit un cahier des charges et sélectionne des projets à financer
Approche populationnelle	Approche qui vise l'ensemble d'une population pour déplacer la distribution d'un facteur de risque (Rose)
Contrat local de santé (CLS)	Contrat entre l'ARS et une collectivité pour mettre en œuvre le PRS localement
Danger	Propriété intrinsèque d'un agent ou d'une situation capable de provoquer un effet néfaste
Déterminant de santé	Facteur personnel, social, économique ou environnemental qui influence l'état de santé
Éducation pour la santé	Démarche qui vise à ce que chacun acquière les compétences et les moyens de promouvoir sa santé ; nutritionnelle, alimentaire, sensorielle
Éducation thérapeutique du patient (ETP)	Démarche de soin visant à aider les patients atteints de maladie chronique à acquérir des compétences pour gérer leur maladie (art. L. 1161-1 CSP) ; relève du BC1
EGalim	Loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Empowerment (pouvoir d'agir)	Processus par lequel une personne ou un groupe acquiert la capacité de contrôler les décisions qui concernent sa santé
Facteur de protection	Caractéristique associée à une diminution de la probabilité de maladie
Facteur de risque	Caractéristique ou exposition associée à une augmentation de la probabilité de maladie
Gradient social de santé	Dégradation progressive de l'état de santé à chaque échelon de l'échelle sociale
Incidence	Nombre de nouveaux cas d'une maladie survenus pendant une période dans une population à risque
Indicateur de processus	Indicateur qui mesure la réalisation des activités et des moyens (nombre de séances, de participants, budget)
Indicateur de résultat	Indicateur qui mesure les effets sur le public (connaissances, comportements, état de santé)

Terme	Définition
Inégalités sociales de santé	Différences systématiques, évitables et injustes d'état de santé entre groupes sociaux
Marketing social	Application des techniques du marketing à la promotion de comportements favorables à la santé
Nudge	Modification de l'architecture du choix qui oriente les comportements sans interdiction ni incitation financière
Nutri-Score	Logo nutritionnel facultatif à 5 classes (A à E) ; nouvel algorithme applicable par arrêté du 14 mars 2025
One Health (Une seule santé)	Approche intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes
Paradoxe de la prévention	Constat de Rose (1985) : une mesure bénéfique à la population apporte peu à chaque individu ; la majorité des cas provient de la population à risque modéré
PNA	Programme national pour l'alimentation (ministère de l'Agriculture) ; PNA 4 : 2026-2030
PNNS	Programme national nutrition santé (ministère de la Santé), depuis 2001 ; PNNS 5 : 2026-2030
Prévalence	Nombre (ou proportion) de cas existants d'une maladie dans une population à un moment donné
Prévention primaire / secondaire / tertiaire	Classification de l'OMS (1948) : avant la maladie (incidence) / au début (prévalence, dépistage) / maladie installée (complications)
Prévention quaternaire	Prévention de la surmédicalisation (Jamoulle, 1986)
Prévention universelle / sélective / indiquée	Classification de Gordon (1983) selon le public : tous / groupe à risque / personnes présentant des facteurs de risque
Projet alimentaire territorial (PAT)	Démarche collective territoriale pour une alimentation locale, durable et accessible (loi du 13 octobre 2014)
Projet régional de santé (PRS)	Document de l'ARS : COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci (Ottawa, 1986)
QPV	Quartier prioritaire de la politique de la ville, défini par un critère de revenu des habitants
Risque	Probabilité de survenue d'un effet néfaste, fonction du danger et de l'exposition
Santé (OMS)	État de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité (1946)
Santé publique	Ensemble des savoirs et actions organisées et collectives visant à maintenir et améliorer la santé de la population
SMART	Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel : critères de formulation des objectifs
SNANC	Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (loi Climat et résilience, art. 265), publiée le 11 février 2026
Surveillance épidémiologique	Collecte systématique et continue, analyse, interprétation et diffusion de données de santé pour orienter l'action
Universalisme proportionné	Actions universelles dont l'intensité est proportionnelle au niveau de désavantage (Marmot, 2010)

Terme	Définition
Veille sanitaire	Détection et évaluation des signaux sanitaires pour alerter les autorités

1.10 Renvois bibliographiques par notion

Les numéros renvoient à la bibliographie numérotée (partie 1.12).

Notion	Références
Définition de la santé, One Health	[1] Constitution de l'OMS ; [3] Charte d'Ottawa ; [5] OHHLEP/Quadripartite ; [6] Huber et coll. ; [21] guide d'accompagnement du BTS
Santé publique, missions	[2] Winslow ; [7] Code de la santé publique art. L. 1411-1 ; [8] loi du 26 janvier 2016 ; [33] Bonita et coll. (OMS)
Paradoxe de la prévention	[9] Rose, 1985
Promotion de la santé	[3] Charte d'Ottawa ; [4] chartes et déclarations ultérieures ; [10] Dahlgren et Whitehead ; [11] Marmot, 2010 ; [32] AFDN, guide santé publique
Prévention	[12] Gordon, 1983 ; [13] Jamoulle ; [14] San Marco
Éducation pour la santé, CPS	[15] Plan national d'éducation pour la santé, 2001 ; [16] Santé publique France, référentiel CPS, 2022
Surveillance, données	[17] Santé publique France, ESTEBAN ; [18] ANSES, INCA 3 ; [19] Albane ; [20] OFÉO ; [26] Insee ; [27] Crédoc
Politiques nutritionnelles	[22] SNANC 2025-2030 ; [23] PNNS 5 ; [24] PNA 4 ; [25] HCSP, avis 2025 ; [28] loi EGalim ; [29] arrêté Nutri-Score 2025 ; [30] repères Santé publique France 2019 ; [31] HCSP, repères 2017
Organisation territoriale	[7] CSP (ARS, PRS, CLS) ; [34] loi HPST ; [35] loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
Diététicien en santé publique	[7] CSP art. L. 4371-1 ; [21] référentiel et guide du BTS ; [32] AFDN
Approfondissements et L3	[38] Sen ; [39] Swinburn et coll. ; [40] Pawson et Tilley ; [41] Monteiro (NOVA) ; [42] consensus sur la stigmatisation du poids ; [43] EAT-Lancet

1.12 Bibliographie numérotée

Liens consultés le 26 octobre 2026. Les textes réglementaires sont consultables sur legifrance.gouv.fr.

Textes fondateurs et définitions

1. Organisation mondiale de la santé. *Constitution de l'Organisation mondiale de la santé*. New York, 22 juillet 1946 (entrée en vigueur le 7 avril 1948). who.int/fr/about/governance/constitution
2. Winslow C.-E. A. « The untilled fields of public health ». *Science*, 1920, 51 (1306), p. 23-33.
3. Organisation mondiale de la santé. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. Première Conférence internationale pour la promotion de la santé, Ottawa, 21 novembre 1986.
4. Organisation mondiale de la santé. Déclarations d'Alma-Ata (1978), d'Adélaïde (1988 et 2010), de Jakarta (1997), Charte de Bangkok (2005), Déclaration d'Helsinki (2013), de Shanghai (2016), Charte de Genève pour le bien- être (2021).

5. One Health High-Level Expert Panel (OHHLEP), Adisasmito W. B. et coll. « One Health: A new definition for a sustainable and healthy future ». *PLoS Pathogens*, 2022, 18 (6) ; plan d'action conjoint One Health de la Quadripartite (FAO, PNUE, OMS, OMSA) 2022-2026.

6. Huber M. et coll. « How should we define health? » *BMJ*, 2011, 343:d4163.

7. *Code de la santé publique* : articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1 (politique et stratégie nationale de santé), L. 1434-1 et suivants (PRS), L. 1434-10 (CLS), L. 1161-1 (ETP), L. 4371-1 et suivants (profession de diététicien).

8. Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

9. Rose G. « Sick individuals and sick populations ». *International Journal of Epidemiology*, 1985, 14 (1), p. 32-38.

10. Dahlgren G., Whitehead M. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Stockholm, Institute for Futures Studies, 1991.

11. Marmot M. et coll. *Fair Society, Healthy Lives (The Marmot Review)*. Londres, 2010.

12. Gordon R. « An operational classification of disease prevention ». *Public Health Reports*, 1983, 98 (2), p. 107-109.

13. Jamoulle M. « Information et informatisation en médecine générale » (concept de prévention quaternaire), 1986 ; Jamoulle M. « Quaternary prevention, an answer of family doctors to overmedicalization ». *International Journal of Health Policy and Management*, 2015.

14. San Marco J.-L. « Définitions » de la prévention, in Bourdillon F., Brücker G., Tabuteau D. (dir.). *Traité de santé publique*. Paris, Flammarion Médecine-Sciences, 3e éd., 2016.

15. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. *Plan national d'éducation pour la santé*. Paris, 2001.

16. Santé publique France. *Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes*. Saint-Maurice, 2022.

Données et surveillance

17. Santé publique France. *Étude de santé sur l'environnement, la biosurveillance, l'activité physique et la nutrition (ESTEBAN), 2014-2016 – Volet nutrition – Chapitre corpulence*. 2017.

18. ANSES. *Troisième étude individuelle nationale des consommations alimentaires (INCA 3)*. Avis et rapport, juin 2017.

19. Santé publique France, ANSES. *Albane : enquête de santé, biosurveillance, environnement, alimentation et nutrition* – lancement du cycle 1, communiqué du 10 juin 2025. anses.fr

20. Ligue nationale contre l'obésité. *Étude OFÉO – Prévalence de l'obésité en France*. Dossier de presse, 20 juin 2024. liguecontrelobesite.org

Référentiel, guide et profession

21. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition », *JO* du 17 décembre 2024 ; *Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition*, 29 avril 2025.

Politiques nutritionnelles

22. Gouvernement. *Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat 2025-2030 (SNANC)*. Publiée le 11 février 2026. ecologie.gouv.fr – SNANC 2025-2030

23. Ministère chargé de la Santé. *Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5)*. Lancé le 8 avril 2026. Synthèses : Réseau national nutrition santé, reseau-national-nutrition-sante.fr ; Vidal, « Le cinquième programme national nutrition santé officiellement lancé », avril 2026.

24. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. *Programme national pour l'alimentation 2026-2030 (PNA 4)*. Avril 2026. agriculture.gouv.fr

25. Haut Conseil de la santé publique. *Recommandations pour l'élaboration du 5e Programme national nutrition santé*. Juin 2025. hcsp.fr

26. Insee. *Bilan démographique 2025*. Insee Première n° 2087, janvier 2026 ; Blanpain N. « L'espérance de vie par niveau de vie », Insee Première n° 1687, février 2018.

27. Crédoc. *En forte hausse, la précarité alimentaire s'ajoute à d'autres fragilités*. Consommation et modes de vie, 2023.

28. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim) ; loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; plateforme ma-cantine.agriculture.gouv.fr.

29. Arrêté du 31 octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle (Nutri-Score), modifié par l'arrêté du 14 mars 2025 ; sante.fr – le nouveau Nutri-Score.

30. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. Janvier 2019 ; mangerbouger.fr.

31. Haut Conseil de la santé publique. *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les adultes du futur PNNS 2017-2021*. Février 2017 ; *Avis relatif à la révision des repères alimentaires pour les enfants âgés de 0-36 mois et de 3-17 ans*. Juin 2020 ; ANSES. *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires*. Décembre 2016.

Profession, organisation, approfondissements

32. Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). *Le diététicien dans les actions de santé publique*. Version 2, 2022. afdn.org

33. Bonita R., Beaglehole R., Kjellström T. *Éléments d'épidémiologie*. 2e éd., Organisation mondiale de la santé, 2010.

34. Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).

35. Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (projets alimentaires territoriaux).

36. Lalonde M. *Nouvelle perspective de la santé des Canadiens*. Ottawa, Gouvernement du Canada, 1974.

37. Commission des déterminants sociaux de la santé (OMS). *Combler le fossé en une génération*. Genève, OMS, 2008.

38. Sen A. *Repenser l'inégalité*. Paris, Seuil, 2000 ; Sen A. *Un nouveau modèle économique*. Paris, Odile Jacob, 2000.

39. Swinburn B. et coll. « The Global Syndemic of Obesity, Undernutrition, and Climate Change: The Lancet Commission report ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 791-846.

40. Pawson R., Tilley N. *Realistic Evaluation*. Londres, Sage, 1997 ; Skivington K. et coll. « A new framework for developing and evaluating complex interventions ». *BMJ*, 2021, 374:n2061.

41. Monteiro C. A. et coll. « Ultra-processed foods: what they are and how to identify them ». *Public Health Nutrition*, 2019, 22 (5), p. 936-941.

42. Rubino F. et coll. « Joint international consensus statement for ending stigma of obesity ». *Nature Medicine*, 2020, 26, p. 485-497.

43. Willett W. et coll. « Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems ». *The Lancet*, 2019, 393, p. 447-492.

44. Thaler R., Sunstein C. *Nudge*. New Haven, Yale University Press, 2008.

45. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Ruel J., Allaire C. (dir.), 2018, mise à jour février 2025.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 1.2.2)

46. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

47. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.